Estilo UERJ

Simulado 4 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	24	2, 5, 7, 11, 12, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 39, 40, 44, 45, 48, 63, 66, 67, 68, 70, 75, 79
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	8	3, 10, 34, 36, 38, 46, 64, 71
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	5	22, 32, 43, 58, 65
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	5	6, 16, 31, 73, 74
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	14	4, 8, 18, 26, 30, 41, 52, 54, 57, 62, 69, 72, 76, 78
Qualificador	o comando restringe o que se pede	3	1, 24, 80
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	7	9, 20, 23, 33, 42, 47, 56
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	7	19, 35, 49, 53, 60, 61, 77
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	7	13, 14, 37, 50, 51, 55, 59

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **B**	2 **D**	3 **D**	4 **A**	5 **D**	6 **C**	7 **C**	8 **D**	9 **C**	10 **C**
11 **D**	12 **C**	13 **D**	14 **D**	15 **B**	16 **D**	17 **D**	18 **C**	19 **A**	20 **C**
21 **C**	22 **A**	23 **C**	24 **C**	25 **D**	26 **A**	27 **B**	28 **D**	29 **B**	30 **A**
31 **C**	32 **B**	33 **B**	34 **B**	35 **B**	36 **A**	37 **C**	38 **D**	39 **D**	40 **B**
41 **B**	42 **D**	43 **A**	44 **C**	45 **C**	46 **A**	47 **B**	48 **A**	49 **A**	50 **C**
51 **A**	52 **D**	53 **D**	54 **C**	55 **A**	56 **B**	57 **B**	58 **A**	59 **A**	60 **D**
61 **A**	62 **B**	63 **B**	64 **A**	65 **A**	66 **B**	67 **C**	68 **B**	69 **D**	70 **B**
71 **A**	72 **B**	73 **A**	74 **B**	75 **C**	76 **A**	77 **C**	78 **A**	79 **C**	80 **D**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 21, B 20, C 20, D 19.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Neurologia · Mielopatia cervical real com ELA escondida: o reflexo mandibular exaltado não cabe numa compressão cervical

Qualificador **Gabarito B**

Homem de 66 anos, ex-carregador de sacos em armazém, com cervicalgia há anos, tem há 10 meses fraqueza progressiva das mãos, dificuldade para abotoar a camisa e marcha 'presa'. Nega disfagia, alteração da voz e alteração esfincteriana. Exame: atrofia de interósseos bilateral, fasciculações em bíceps e deltoides, reflexo bicipital reduzido com tricipital vivo, Hoffmann bilateral, espasticidade e Babinski bilaterais em membros inferiores; língua sem atrofia. RM de coluna cervical: estenose do canal em C4-C5 e C5-C6, com hipersinal medular discreto em T2 em C5. A cirurgia de descompressão é programada. Ao rever o exame antes da cirurgia, o achado adicional que, isoladamente, não pode ser atribuído à compressão cervical e obriga a investigar doença do neurônio motor é:

O DADO QUE DECIDE

não pode ser atribuído à compressão cervical

Resolução. A mielopatia aqui é real (estenose em dois níveis com hipersinal medular), e o apressado procura o achado que 'parece ELA'. Quem fixou que déficit sensitivo afasta ELA marca a sensibilidade normal, mas a recíproca não vale: a amiotrofia espondilótica cervical e a mielopatia inicial podem ser puramente motoras, então sensibilidade normal é compatível com a compressão. Tudo o que fica do nível comprimido para baixo pode vir da medula cervical: neurônio motor inferior no nível (atrofia, fasciculação de C5-C6, reflexo bicipital invertido), neurônio motor superior abaixo (Hoffmann, espasticidade, clônus, Babinski) e Lhermitte pela compressão dos cordões posteriores. O reflexo mandibular, ao contrário, é um arco do trigêmeo na ponte: exaltado, indica lesão corticobulbar acima do forame magno, onde nenhuma compressão cervical chega. Estenose cervical degenerativa é comum nessa idade e pode coexistir com ELA, e esse achado pede eletroneuromiografia de vários segmentos antes de atribuir tudo à coluna e operar.

A) Clônus aquileu bilateral

Errada. Clônus aquileu é sinal de neurônio motor superior abaixo da compressão, esperado na mielopatia cervical tanto quanto na ELA; não separa as duas.

B) Reflexo mandibular exaltado CORRETA

Correta. O reflexo mandibular depende da ponte; exaltado, aponta neurônio motor superior acima do forame magno, fora do alcance de qualquer compressão cervical.

C) Sensibilidade tátil e vibratória normais ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Sensibilidade normal combina com ELA, mas também com a mielopatia predominantemente motora (amiotrofia espondilótica cervical); só um achado sensitivo afastaria a ELA, e a recíproca não vale.

D) Sinal de Lhermitte

Errada. Lhermitte é choque descendente à flexão do pescoço por lesão dos cordões posteriores cervicais, a favor da mielopatia (ou de EM), não da ELA.

Para levar. Na estenose cervical com sinais motores mistos, procure sinal acima do forame magno: reflexo mandibular exaltado, fasciculação ou atrofia de língua. Eles não cabem na coluna e pedem ENMG antes de operar. Sensibilidade normal não diferencia.

Critérios de Gold Coast 2020 (ELA); AOSpine/WFNS 2017 e 2019 (mielopatia cervical degenerativa); Brooks et al., El Escorial revisado 2000.

2

Endocrinologia · Tireotoxicose no pós-parto com irmã com Graves: tireoidite pós-parto

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 30 anos, quatro meses após o parto, em aleitamento materno exclusivo, refere palpitações, irritabilidade e insônia há três semanas. Tem anti-TPO positivo documentado no primeiro trimestre, com TSH normal na gestação; a irmã tem doença de Graves. Sem dor cervical ou febre. Exame: FC 104 bpm, tremor fino, tireoide discretamente aumentada, indolor, sem sopro, sem oftalmopatia. Exames: TSH abaixo de 0,01 µUI/mL, T4 livre 2,6 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 168 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo, VHS 12 mm/h. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

TRAb negativo

Resolução. Irmã com Graves, bócio discreto e tireotoxicose no pós-parto: o rótulo familiar puxa para Graves, que de fato tem pico no primeiro ano após o parto. O que separa é o TRAb negativo, somado à ausência de sopro e de oftalmopatia, ao anti-TPO positivo prévio (principal fator de risco) e ao momento (dois a seis meses após o parto). Tireoidite pós-parto é destrutiva, indolor e autolimitada, frequentemente seguida de fase hipotireóidea. A captação seria baixa, mas na lactação o iodo radioativo é contraindicado e o tecnécio exige interromper a amamentação, por isso o TRAb é o exame que decide. O tratamento da fase tireotóxica é sintomático com betabloqueador (propranolol é compatível com a amamentação), sem tionamida.

A) Tireoidite subaguda granulomatosa
Errada. Daria dor cervical, febre e VHS alta, ausentes.

B) Tireotoxicose factícia
Errada. Daria glândula não palpável e tireoglobulina baixa, sem relação com anti-TPO e pós-parto.

C) Doença de Graves no pós-parto ARMADILHA
Errada. Seria o diagnóstico com TRAb positivo, sopro, oftalmopatia ou tireotoxicose além de três meses; a história familiar não substitui o anticorpo.

D) Tireoidite pós-parto CORRETA
Correta. Tireotoxicose indolor quatro meses após o parto, com anti-TPO positivo e TRAb negativo.

Para levar. Tireotoxicose de dois a seis meses após o parto com TRAb negativo é tireoidite pós-parto (destrutiva): betabloqueador e seguimento, sem tionamida; na lactação, o TRAb substitui a cintilografia.

ATA Guidelines for Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum 2017; ATA Hyperthyroidism Guidelines 2016.

---

3 Oncologia · Adenocarcinoma em linfonodo axilar com mamografia normal: ressonância das mamas

Negativo no meio **Gabarito D**

Mulher de 52 anos percebeu nódulo axilar esquerdo há 1 mês. Exame: linfonodo axilar de 3 cm, móvel; mamas sem nódulos à palpação, sem alterações cutâneas ou papilares. Biópsia por agulha grossa do linfonodo: metástase de adenocarcinoma pouco diferenciado; imuno-histoquímica com CK7 positiva, CK20 negativa, GATA3 positiva, receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo. Mamografia e ultrassonografia mamárias bilaterais sem lesões suspeitas (BI-RADS 1). TC de tórax e abdome sem outras lesões. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Mamografia e ultrassonografia mamárias bilaterais sem lesões suspeitas (BI-RADS 1)

Resolução. Sítio primário desconhecido convida ao PET-CT, que parece o exame mais completo. Mas este é um subgrupo favorável e específico: mulher com adenocarcinoma em linfonodo axilar e imuno-histoquímica de origem mamária (CK7 positiva, CK20 negativa, GATA3 e receptor de estrogênio positivos). Mamografia e ultrassonografia normais não afastam câncer de mama oculto, e a ressonância das mamas identifica o primário em cerca de dois terços desses casos, orientando a cirurgia. Mesmo com ressonância negativa, ela é tratada como câncer de mama com axila positiva. PET-CT e endoscopias não acrescentam ao primário mais provável, e marcadores não localizam nada.

A) Endoscopia e colonoscopia
Errada. Endoscopias seriam pertinentes com perfil CK20 ou CDX2 positivos; GATA3 e receptor de estrogênio apontam a mama.

B) PET-CT com FDG ARMADILHA
Errada. É a isca: o PET-CT tem baixa sensibilidade para tumores pequenos de mama e não é o passo seguinte quando a imuno-histoquímica já aponta a mama.

C) Marcadores CA 15-3 e CEA
Errada. Marcadores tumorais não localizam o primário nem mudam a conduta.

D) Ressonância magnética das mamas CORRETA
Correta. Adenocarcinoma axilar com perfil mamário e mamografia normal: a ressonância das mamas encontra o primário oculto na maioria.

Para levar. Metástase axilar de adenocarcinoma em mulher, com mamografia normal: ressonância das mamas; se negativa, trata-se como câncer de mama com axila positiva.

ESMO Clinical Practice Guideline: Cancers of unknown primary site (2023); NCCN Occult Primary (2025)

---

4 Infectologia · Choque séptico com noradrenalina acima de 0,25 mcg/kg/min: vasopressina e hidrocortisona

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 64 anos, no 2º dia de UTI por choque séptico de foco urinário (Escherichia coli em hemoculturas, sensível à ceftriaxona em uso desde a admissão, sem obstrução à ultrassonografia), recebeu 30 mL/kg de cristaloide nas primeiras 3 horas e hoje não responde a volume pela elevação passiva das pernas. Está há 6

horas com noradrenalina, agora em 0,32 mcg/kg/min, para manter PAM de 65 mmHg. Lactato 3,1 mmol/L, diurese 0,4 mL/kg/h. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 60%, sem derrame pericárdico, veia cava inferior distendida. Não usa corticoide cronicamente. Segundo a Surviving Sepsis Campaign, associar vasopressina e iniciar hidrocortisona são condutas, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Está há 6 horas com noradrenalina, agora em 0,32 mcg/kg/min

Resolução. Muitos reservam o corticoide para o choque refratário a tudo ou condicionam ao cortisol sérico baixo, e associam só a vasopressina. A diretriz usa dois limiares que este caso cruza ao mesmo tempo. Vasopressina: sugerida quando a noradrenalina atinge 0,25 a 0,5 mcg/kg/min, em vez de continuar subindo a noradrenalina. Hidrocortisona 200 mg/dia: sugerida no choque séptico com necessidade contínua de vasopressor, definida como noradrenalina de 0,25 mcg/kg/min ou mais por pelo menos 4 horas, sem necessidade de dosar cortisol. Com 0,32 mcg/kg/min há 6 horas, as duas estão indicadas. Mais volume não ajuda (sem fluido-responsividade, cava distendida) e dobutamina não cabe com FE de 60%.

A) Indicada / indicada CORRETA
Correta. Noradrenalina acima de 0,25 mcg/kg/min: associar vasopressina; mantida por mais de 4 horas: hidrocortisona 200 mg/dia.

B) Indicada / não indicada ARMADILHA
Errada. É a armadilha: acerta a vasopressina, mas trata o corticoide como reserva para refratariedade extrema ou cortisol baixo, o que a diretriz não exige.

C) Não indicada / indicada
Errada. Acerta o corticoide, mas manter só a noradrenalina subindo acima de 0,25 a 0,5 contraria a sugestão de associar vasopressina.

D) Não indicada / não indicada
Errada. Seria a resposta com noradrenalina baixa e em queda; 0,32 mcg/kg/min por 6 horas cruza os dois limiares.

Para levar. Choque séptico com noradrenalina de 0,25 mcg/kg/min ou mais: associe vasopressina e, se mantida por 4 horas ou mais, hidrocortisona 200 mg/dia, sem dosar cortisol.

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock (2021).

5

Reumatologia · Suspeita de Still em idoso com linfonodos endurecidos e LDH alta: biópsia antes do corticoide

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Homem de 61 anos procura atendimento por febre diária de até 39,8 °C há 7 semanas, com picos ao entardecer, sudorese noturna, perda de 9 kg e artralgia de punhos e joelhos. Nos picos febris aparece exantema macular rosado em tronco, que some com a defervescência. Exame físico: linfonodos cervicais e axilares de 2 a 3 cm, endurecidos, indolores e coalescentes à esquerda, baço a 5 cm do rebordo costal, artrite de punhos. Exames: Hb 9,8 g/dL, leucócitos 16.900/mm³ (84% neutrófilos), plaquetas 470.000/mm³, ferritina 9.600 ng/mL, AST 72 U/L, LDH 1.240 U/L (VR até 250), FAN e fator reumatoide não reagentes, hemoculturas e sorologias para HIV, hepatites, EBV, CMV e toxoplasmose negativas, ecocardiograma normal. TC: linfonodomegalias retroperitoneais confluentes de até 4 cm. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

endurecidos, indolores e coalescentes à esquerda

Resolução. Febre quotidiana, exantema evanescente, artrite, neutrofilia e ferritina de 9.600 preenchem quase todo o quadro de Still, e a ferritina glicosilada baixa parece o exame que fecha. Mas Still é diagnóstico de exclusão, e os critérios de Yamaguchi só valem depois de afastar infecção e neoplasia. Aqui há sinais de linfoma: homem de 61 anos, perda de 9 kg, linfonodos endurecidos e coalescentes, massa retroperitoneal confluente e LDH cinco vezes acima. Linfomas, sobretudo de células T e de Hodgkin, imitam Still com febre, exantema e ferritina alta, e o corticoide dado antes da biópsia pode mascarar a histologia. O próximo exame é a biópsia excisional do linfonodo periférico acessível, com imuno-histoquímica; o PET-CT pode ajudar a escolher o alvo, mas não substitui o tecido.

A) Biópsia de pele do exantema
Errada. A biópsia do exantema do Still é inespecífica e não diferencia de linfoma; o tecido que decide é o linfonodo.

B) PET-CT de corpo inteiro
Errada. Mostraria captação nos linfonodos, que a TC já mostrou; seria útil para guiar biópsia em linfonodo profundo, mas não dá o diagnóstico.

C) Ferritina glicosilada ARMADILHA
Errada. Ferritina glicosilada baixa reforça Still, mas não exclui linfoma, que também a reduz; não responde à pergunta que importa aqui.

D) Biópsia excisional de linfonodo CORRETA
Correta. Linfonodos endurecidos e coalescentes, massa retroperitoneal e LDH alta exigem tecido antes de qualquer corticoide.

Para levar. Still é diagnóstico de exclusão: com linfonodo endurecido, massa profunda ou LDH muito alta, biópsia de linfonodo antes do corticoide.

Critérios de Yamaguchi (1992), com exclusão de infecção e neoplasia; EULAR/PReS 2024 recommendations for Still's disease.

6

Cardiologia · Infarto inferior com acometimento de VD: hipotensão após nitrato sublingual

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 58 anos, tabagista, chega à UPA com dor torácica em aperto há 90 minutos. ECG: supradesnivelamento de ST em DII, DIII e aVF, maior em DIII do que em DII, com infradesnivelamento em DI e aVL. Recebe AAS e, para a dor, um comprimido sublingual. Quinze minutos depois está sudoreico e confuso, PA 72×40 mmHg, FC 64 bpm, turgência jugular a 45 graus, pulmões limpos, sem sopros, SpO2 96% em ar ambiente. O mecanismo principal da hipotensão é:

O DADO QUE DECIDE

turgência jugular a 45 graus, pulmões limpos

Resolução. O comprimido sublingual para dor torácica é o nitrato, e a banca não o nomeou. Infarto com hipotensão e turgência jugular puxa para falência de bomba, mas falência do VE congestiona o pulmão, e aqui os pulmões estão limpos. A tríade hipotensão, jugular turgente e pulmão limpo, num infarto inferior com

ST maior em DIII que em DII (oclusão proximal da coronária direita), é infarto de VD. O VD isquêmico depende da pré-carga para manter o débito, e o nitrato, venodilatador, derruba o retorno venoso: o VD deixa de encher o VE. Por isso o nitrato é contraindicado no infarto de VD, que se confirma com V3R e V4R e se trata com volume, sem diurético.

A) Vasodilatação arterial periférica pelo nitrato
Errada. O nitrato age sobretudo no leito venoso; a dilatação arterial isolada não explica a jugular turgente.

B) Reflexo vagal de Bezold-Jarisch
Errada. O reflexo de Bezold-Jarisch causa hipotensão com bradicardia acentuada e sem turgência jugular; a FC aqui é 64 e as jugulares estão cheias.

C) Pré-carga reduzida num VD isquêmico CORRETA
Correta. O nitrato reduziu a pré-carga de um VD infartado, dependente de volume, e o débito do VE caiu; jugular turgente com pulmão limpo é a assinatura.

D) Falência sistólica do ventrículo esquerdo ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Falência do VE no infarto dá estertores e congestão; pulmões limpos com jugular turgente apontam o VD.

Para levar. Infarto inferior com hipotensão, jugular turgente e pulmão limpo é infarto de VD: peça V3R e V4R, dê volume, e nada de nitrato, diurético ou morfina, que reduzem a pré-carga.

ESC 2023 (acute coronary syndromes); Diretriz da SBC sobre IAM com Supradesnível do Segmento ST (2015)

7

Nefrologia · PTH em elevação na DRC estágio 4 não dialítica · dosar 25-hidroxivitamina D, e não a vitamina D ativa

Rótulo verdadeiro | **Gabarito C**

Mulher de 59 anos, com doença renal crônica por nefroesclerose hipertensiva, TFGe de 22 mL/min/1,73 m², não dialítica, sem fraturas, em uso de losartana e anlodipino. Trabalha em casa e quase não se expõe ao sol. Exames de rotina: cálcio 8,9 mg/dL, fósforo 4,4 mg/dL, fosfatase alcalina 112 U/L (normal), bicarbonato 23 mEq/L e PTH 196 pg/mL (15 a 65), que era 142 pg/mL há seis meses. No prontuário, o residente anotou que o rim doente produz menos vitamina D ativa. Para orientar o manejo do PTH em elevação, o exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

quase não se expõe ao sol

Resolução. PTH três vezes o limite e subindo numa DRC estágio 4 lembra a falta de calcitriol do rim doente, e o reflexo é dosar a vitamina D ativa. A anotação do residente é verdadeira, mas leva ao exame errado: a 1,25-di-hidroxivitamina D é regulada pelo próprio PTH e pelo fósforo, cai tarde, não mede reserva e não orienta o tratamento, e a KDIGO não recomenda dosá-la na DRC. A KDIGO de distúrbio mineral e ósseo orienta, na DRC G3a a G5 não dialítica com PTH em elevação progressiva, procurar primeiro os fatores modificáveis: hiperfosfatemia, hipocalcemia, ingesta alta de fósforo e deficiência de vitamina D. Cálcio e fósforo estão normais e a paciente quase não se expõe ao sol: falta a 25-hidroxivitamina D, que mede o estoque. Se baixa, o tratamento é colecalciferol; calcitriol e análogos não são rotina na DRC não dialítica (hipercalcemia sem benefício clínico demonstrado) e ficam para o hiperparatireoidismo grave e progressivo, e o cinacalcete é para quem está em diálise.

A) 1,25-di-hidroxivitamina D sérica ARMADILHA

Errada, é a armadilha. O rim doente produz menos calcitriol, mas o nível sérico de 1,25-di-hidroxivitamina D não mede estoque nem guia o tratamento; seria útil na hipercalcemia com suspeita de produção extrarrenal (sarcoidose, linfoma).

B) Cintilografia de paratireoides

Errada. A cintilografia localiza glândula para paratireoidectomia (primário, ou terciário com indicação cirúrgica); não diagnostica nem orienta o tratamento clínico do hiperparatireoidismo secundário.

C) 25-hidroxivitamina D sérica CORRETA

Correta. Com cálcio e fósforo normais e PTH subindo, o fator modificável a avaliar é a deficiência de vitamina D nativa, medida pela 25-hidroxivitamina D; se baixa, colecalciferol antes de pensar em calcitriol.

D) Densitometria óssea

Errada. A densitometria estima risco de fratura na DRC quando o resultado muda a conduta, mas não explica nem guia o tratamento do PTH em elevação.

Para levar. DRC não dialítica com PTH subindo: dose a 25-hidroxivitamina D (estoque), não a 1,25 (ativa), e corrija fósforo, cálcio e deficiência de vitamina D com colecalciferol antes de pensar em calcitriol; cinacalcete só em diálise.

KDIGO 2017 (CKD-MBD Guideline Update); Diretriz Brasileira de Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (SBN 2021).

8

Medicina baseada em evidências · Razão de verossimilhança positiva e probabilidade pós-teste

Grade X / Y **Gabarito D**

Um teste rápido para uma infecção tem sensibilidade de 80% e especificidade de 90%. Para um paciente com probabilidade pré-teste de 50%, a razão de verossimilhança positiva do teste e a probabilidade de doença após um resultado positivo são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

probabilidade pré-teste de 50%

Resolução. A razão de verossimilhança positiva é sensibilidade dividida por (1 menos especificidade): 0,80 dividido por 0,10, igual a 8. O 0,89 vem de dividir a sensibilidade pela especificidade, conta sem significado. Para a probabilidade pós-teste, converte-se a probabilidade em chance: 50% é chance de 1 para 1; multiplicada por 8, a chance pós-teste é 8, que vira probabilidade de 8 dividido por 9, cerca de 89%. O 80% é a sensibilidade, que responde a outra pergunta (a proporção de doentes com teste positivo), e é a troca que a armadilha explora.

A) 0,89 / 80%

Errada nas duas metades. 0,89 não é razão de verossimilhança e 80% é a sensibilidade.

B) 8 / 80% ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Acerta a razão de verossimilhança, mas toma a sensibilidade pela probabilidade pós-teste.

C) 0,89 / 89%

Errada. A probabilidade pós-teste está certa, mas a razão de verossimilhança positiva é 0,8 dividido por 0,1, não 0,8 dividido por 0,9.

D) 8 / 89% CORRETA

Correta. RV positiva de 8; chance pré-teste 1, chance pós-teste 8, probabilidade de cerca de 89%.

Para levar. RV positiva = sensibilidade dividida por (1 menos especificidade); probabilidade vira chance, multiplica pela RV e volta a probabilidade.

Guyatt, Users' Guides to the Medical Literature, 3ª ed.; Fletcher, Epidemiologia Clínica, 6ª ed.

9

Hematologia · Hemocromatose com ferritina normal: a saturação de transferrina acima de 45% indica o HFE

Limiar **Gabarito C**

Homem de 34 anos, sem comorbidades, IMC de 23 kg/m², abstêmio, é encaminhado por ALT discretamente elevada em exame admissional. Está assintomático. Nunca recebeu transfusão e não usa suplementos, anabolizantes nem medicamentos. Exame físico normal, sem hepatomegalia. Ultrassonografia de abdome sem esteatose e sem alterações. Exames em jejum, repetidos com 1 mês de intervalo: saturação de transferrina de 71% e 68% (VR 20 a 50%), ferritina de 380 e 410 ng/mL (VR 30 a 400), ALT 52 U/L, AST 41 U/L, glicemia e hemograma normais. Sorologias para hepatites B e C negativas. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de transferrina de 71% e 68%

Resolução. A ferritina praticamente normal é o que tranquiliza o apressado, que repete o exame mais tarde. Na hemocromatose HFE, porém, a saturação de transferrina sobe primeiro, anos antes de a ferritina acumular, e é ela que define a suspeita: saturação de 45% ou mais em jejum, confirmada, pede genotipagem do HFE, independentemente da ferritina. Ele tem 71% e 68%, sem álcool, sem esteatose, sem hepatite viral e sem transfusão, e a ALT discretamente alta pode ser a primeira expressão da doença. A biópsia e a ressonância ficam para depois: a biópsia, para o homozigoto C282Y com ferritina acima de 1.000 e transaminases altas, em que se avalia fibrose; a ressonância, para quantificar ferro quando o genótipo não explica a sobrecarga. É o espelho da hiperferritinemia metabólica: lá a ferritina engana para cima, aqui engana para baixo, e nos dois casos quem decide é a saturação.

A) Ressonância hepática com T2*

Errada. A ressonância quantifica ferro e seria útil se o HFE viesse negativo com sobrecarga suspeita; não é o primeiro passo.

B) Biópsia hepática com coloração de Perls

Errada. A biópsia se reserva ao homozigoto C282Y com ferritina acima de 1.000 e transaminases elevadas, para estadiar fibrose.

C) Pesquisa da mutação C282Y do HFE CORRETA

Correta. Saturação de transferrina persistentemente acima de 45% em jejum, sem outra causa, com ALT discretamente alta: genotipagem do HFE, mesmo com ferritina normal.

D) Repetir o perfil de ferro em 6 meses ARMADILHA

Errada. É a armadilha: ferritina normal não afasta hemocromatose inicial; repetir em 6 meses só atrasa o diagnóstico de doença tratável.

Para levar. Na hemocromatose a saturação de transferrina sobe antes da ferritina: saturação de 45% ou mais em jejum pede HFE mesmo com ferritina normal; ferritina alta com saturação normal não pede.

EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis 2022; ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis (2019).

---

10 Gastroenterologia · Dor abdominal desproporcional ao exame no etilista com pulso irregular: isquemia mesentérica aguda, e não pancreatite

Negativo no meio **Gabarito C**

Homem de 71 anos, hipertenso em uso de losartana, etilista de cerca de cinco latas de cerveja por dia e que bebeu mais no último fim de semana, chega à emergência com dor abdominal periumbilical súbita e intensa há 5 horas, sem melhora com dipirona, seguida de dois vômitos e de uma evacuação diarreica. Nega febre, icterícia e episódios semelhantes. Exame: agitado pela dor, T 36,9 °C, PA 150 × 92 mmHg, pulso irregularmente irregular a 112 bpm, abdome flácido, com dor leve e difusa à palpação profunda, sem descompressão dolorosa, ruídos hidroaéreos presentes. Exames: leucócitos 16.800/mm³, amilase 210 U/L (até 100), lipase 95 U/L (até 60), bilirrubina total 0,9 mg/dL, lactato 1,8 mmol/L (até 2,0), creatinina 1,1 mg/dL. Radiografia de abdome em pé sem pneumoperitônio. O diagnóstico mais provável é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *abdome flácido, com dor leve e difusa à palpação profunda, sem descompressão dolorosa*

Resolução. Etilismo, vômitos e amilase e lipase elevadas puxam para pancreatite alcoólica. Mas a lipase está abaixo de três vezes o limite superior, e a dor periumbilical súbita, que não cede, contrasta com um abdome flácido, pouco doloroso e sem descompressão: é a dor desproporcional ao exame físico, que marca a isquemia mesentérica aguda nas primeiras horas, antes da necrose transmural. O pulso irregularmente irregular é fibrilação atrial não diagnosticada, a fonte embólica mais comum para a artéria mesentérica superior, e a evacuação logo após a dor completa o quadro. Lactato normal não afasta: ele sobe tarde, quando já há infarto intestinal, e esperar por ele é o erro. Amilase e lipase discretamente elevadas são comuns na isquemia intestinal. O passo seguinte é angiotomografia de abdome com fase arterial, heparina e avaliação cirúrgica ou endovascular imediata.

A) Pancreatite aguda alcoólica ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o etilismo é real, mas a lipase está abaixo de três vezes o limite e a pancreatite costuma dar dor em faixa com abdome doloroso; seria a resposta com lipase acima de 180 U/L e dor compatível ao exame.

B) Úlcera péptica perfurada

Errada. Seria a resposta com abdome em tábua, descompressão dolorosa e pneumoperitônio; aqui o abdome é flácido e não há ar livre.

C) Isquemia mesentérica aguda CORRETA

Correta. Dor súbita desproporcional a um abdome flácido e sem descompressão, com fibrilação atrial não diagnosticada como fonte embólica; lactato normal não afasta.

D) Colecistite aguda
Errada. Seria a resposta com dor em hipocôndrio direito, sinal de Murphy e febre; a dor é periumbilical e o exame não a localiza.

Para levar. Dor abdominal súbita e intensa com exame pobre é isquemia mesentérica até prova em contrário, sobretudo com fibrilação atrial; lactato normal e enzimas pancreáticas pouco elevadas não afastam, e o exame é a angiotomografia imediata.

ESVS 2017 (doenças das artérias e veias mesentéricas); WSES 2022 (isquemia mesentérica aguda); classificação de Atlanta revisada (2012).

---

11 Endocrinologia · Monitorização contínua de glicose: hipoglicemia manda mais que a HbA1c

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos, doença renal crônica (TFG estimada 38 mL/min/1,73 m²) e infarto prévio, usa glargina 24 UI à noite, glibenclamida 5 mg duas vezes ao dia, linagliptina e empagliflozina. Mora sozinho e refere tremores noturnos ocasionais. HbA1c 8,4%. Relatório de 14 dias do sensor de glicose: tempo no alvo (70 a 180 mg/dL) 49%, acima de 180 mg/dL 44%, entre 54 e 69 mg/dL 5%, abaixo de 54 mg/dL 2%, com os eventos concentrados entre 2 e 5 horas da manhã; glicose média 182 mg/dL. A conduta mais adequada agora é:

O DADO QUE DECIDE
entre 54 e 69 mg/dL 5%, abaixo de 54 mg/dL 2%

Resolução. HbA1c de 8,4% e 44% do tempo acima de 180 são o rótulo verdadeiro: o paciente está mal controlado, e intensificar parece óbvio. O relatório do sensor tem outra linha, e ela tem prioridade: 7% do tempo abaixo de 70 e 2% abaixo de 54, quando a meta para idoso de alto risco é menos de 1% abaixo de 70. Hipoglicemia noturna em idoso que mora sozinho, coronariopata e com DRC é o problema a resolver primeiro, e a HbA1c alta convive com ela (variabilidade). O culpado mais provável é a glibenclamida, sulfonilureia de ação longa com metabólitos ativos de excreção renal, inadequada com TFG de 38. Retirá-la é o primeiro passo; só depois, com a hipoglicemia resolvida, se reavalia a intensificação, preferindo fármacos sem risco de hipoglicemia.

A) Trocar para esquema basal-bolus
Errada. Mais insulina e mais injeções em idoso que mora sozinho e já tem hipoglicemia aumentam o risco.

B) Associar semaglutida semanal
Errada. Pode vir depois para a hiperglicemia, mas não resolve a hipoglicemia, que é a prioridade.

C) Aumentar a glargina em 10% ARMADILHA
Errada. Seria o ajuste com hiperglicemia isolada e tempo abaixo do alvo menor que 1%; aqui aumenta a hipoglicemia noturna.

D) Suspender a glibenclamida CORRETA
Correta. Tempo abaixo de 70 de 7% e abaixo de 54 de 2% obrigam a retirar a causa da hipoglicemia, a sulfonilureia de ação longa na DRC.

Para levar. No relatório do sensor, leia primeiro o tempo abaixo do alvo: acima de 4% (acima de 1% no idoso frágil) abaixo de 70, ou acima de 1% abaixo de 54, a conduta é desintensificar a droga culpada, mesmo com HbA1c alta.

International Consensus on Time in Range (Battelino et al., Diabetes Care 2019); ADA Standards of Care 2026, seções 6 e 13.

---

12 Neurologia · Sensibilidade grave a neuroléptico revela demência com corpos de Lewy num idoso com delirium

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 76 anos é internado por pneumonia. A família conta que, há 1 ano, ele tem dias bons e dias ruins de memória e atenção, vê 'crianças brincando na sala' sem se assustar, e há vários anos se debate e grita dormindo. No 2º dia de internação, agitado à noite, recebeu haloperidol 5 mg IM; na manhã seguinte estava rígido, mal deglutia e caiu ao tentar levantar. Exame: Tax 37,2 °C, rigidez plástica simétrica nos quatro membros, bradicinesia, sem tremor de repouso, desatento, CPK 240 U/L. Antes da internação andava sozinho, sem rigidez percebida pela família. A infecção está em melhora com antibiótico. O diagnóstico de base mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

vê 'crianças brincando na sala' sem se assustar, e há vários anos se debate e grita dormindo

Resolução. O delirium é verdadeiro (agitação noturna, desatenção, infecção), e quem para nele trata o quadro como transitório. Mas o comando pede o diagnóstico de base, e a história anterior à internação já tem os critérios centrais de demência com corpos de Lewy: flutuação cognitiva de 1 ano, alucinações visuais bem formadas e distúrbio comportamental do sono REM de vários anos. A reação ao haloperidol (parkinsonismo grave e disfagia após uma dose) é a sensibilidade grave a neurolépticos, critério de suporte da DCL, presente em até metade dos pacientes. Doença de Parkinson com demência exige parkinsonismo pelo menos 1 ano antes da demência, e ele andava sem rigidez. No Alzheimer a memória declina de forma progressiva, sem flutuação marcante, alucinações precoces ou sono REM alterado. Nos pacientes com DCL, evitar antipsicóticos de primeira geração, como o haloperidol; para psicose, inibidor da colinesterase e, se necessário, quetiapina ou clozapina em dose baixa.

A) Delirium por pneumonia ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O delirium existe, mas o comando pede a doença de base, e flutuação, alucinações e sono REM alterado precedem a internação em anos.

B) Doença de Parkinson com demência
Errada. Na Parkinson com demência o parkinsonismo precede a demência em mais de 1 ano; ele não tinha rigidez antes do haloperidol.

C) Demência com corpos de Lewy CORRETA
Correta. Flutuação, alucinações visuais, distúrbio do sono REM e sensibilidade grave ao neuroléptico.

D) Doença de Alzheimer
Errada. O Alzheimer cursa com declínio progressivo da memória, sem flutuação marcante, alucinações precoces ou distúrbio do sono REM.

Para levar. Parkinsonismo grave após uma dose de neuroléptico num idoso com flutuação e alucinações é DCL: evitar antipsicótico de primeira geração.

McKeith et al., Neurology 2017 (4º consenso de DCL); Beers AGS 2023.

---

13 Infectologia · Neutropenia febril de alto risco com febre persistente no 5º dia de cefepima: TC de tórax mesmo com radiografia normal

Cronologia **Gabarito D**

Homem de 52 anos, com leucemia mieloide aguda em indução com citarabina e daunorrubicina, está no 14º dia do ciclo. Usa aciclovir profilático e não recebe antifúngico profilático. Iniciou febre há 5 dias, com neutrófilos de 60/mm³, e recebe cefepima desde a primeira hora. Continua com picos de 38,6 °C, sem tosse, dispneia, dor torácica, diarreia, dor abdominal ou lesões de pele; mucosite oral leve; cateter totalmente implantado sem sinais flogísticos. Exame: FC 102 bpm, PA 118 × 72 mmHg, FR 18 irpm, SpO2 96% em ar ambiente, ausculta pulmonar normal. Hemoculturas (cateter e periférica) e urocultura colhidas na admissão e no 3º dia: negativas. Radiografias de tórax na admissão e ontem: normais. Neutrófilos hoje: 40/mm³. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Iniciou febre há 5 dias

Resolução. Sem sintomas respiratórios, com ausculta normal e duas radiografias normais, o pulmão parece fora de questão, e repetir a radiografia parece o passo proporcional. Mas o neutropênico profundo quase não forma infiltrado visível na radiografia nem produz sintomas, e o que decide é o tempo: febre persistente após 4 a 7 dias de antibiótico de amplo espectro, em neutropenia prolongada de alto risco (leucemia aguda em indução, sem profilaxia antifúngica), é o momento de procurar infecção fúngica invasiva, sobretudo aspergilose. A TC de tórax (com galactomanana sérica, na estratégia preemptiva) é o exame indicado, e achados como nódulo com halo orientam o voriconazol; sem acesso a essa investigação, inicia-se antifúngico empírico. Trocar ou ampliar o antibacteriano só pela febre, com o paciente estável e culturas negativas, não é recomendado.

A) Nova radiografia de tórax ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a radiografia já foi normal duas vezes e tem baixa sensibilidade no neutropênico, que não forma infiltrado; repeti-la atrasa o diagnóstico de aspergilose.

B) Ultrassonografia de abdome

Errada. A candidíase hepatoesplênica é procurada quando os neutrófilos se recuperam e a febre persiste; em neutropenia profunda as lesões ainda não aparecem.

C) Ecocardiograma transtorácico

Errada. Ecocardiograma seria o passo com bacteremia persistente ou por S. aureus; as hemoculturas, inclusive a do cateter, são negativas.

D) TC de tórax CORRETA

Correta. Febre persistente após 4 a 7 dias de cefepima em neutropenia de alto risco: TC de tórax para procurar fungo filamentoso, mesmo com radiografia normal.

Para levar. Neutropenia de alto risco com febre persistente após 4 a 7 dias de antibiótico: TC de tórax (e galactomanana) para infecção fúngica invasiva, mesmo sem sintomas respiratórios e com radiografia normal.

IDSA Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer (2010); IDSA Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis (2016).

14

Reumatologia · Dermatomiosite do adulto: janela de maior risco de neoplasia associada

Cronologia **Gabarito D**

Na dermatomiosite do adulto, o período de maior risco de surgimento de neoplasia associada é:

O DADO QUE DECIDE

período de maior risco de surgimento de neoplasia associada

Resolução. O raciocínio que derruba é o da imunossupressão: a neoplasia viria depois de anos de corticoide e imunossupressor. Na dermatomiosite, a neoplasia é na maioria das vezes paraneoplásica, e o risco se concentra em torno do diagnóstico, do ano anterior até cerca de 3 anos depois, caindo em seguida. Por isso o rastreio é feito ao diagnóstico e repetido nos 3 primeiros anos, com intensidade conforme o risco: maior acima dos 40 anos, com disfagia, lesões cutâneas necróticas, doença refratária e anticorpos anti-TIF1-gama ou anti-NXP2; menor na síndrome antissintetase (anti-Jo-1 e outros) e no anti-SRP. Ovário, pulmão, mama, colorretal, pâncreas e estômago estão entre os sítios mais frequentes.

A) Entre 3 e 5 anos após o diagnóstico
Errada. Depois do terceiro ano o risco cai e se aproxima do da população; não é a janela de maior risco.

B) Entre 5 e 10 anos após o diagnóstico ARMADILHA
Errada. Seria o raciocínio da neoplasia induzida por imunossupressão crônica; a da dermatomiosite é paraneoplásica e concentrada perto do diagnóstico.

C) Constante ao longo de toda a doença
Errada. O risco não é constante: é máximo em torno do diagnóstico e cai nos anos seguintes, por isso o rastreio tem prazo.

D) Entre 1 ano antes e 3 anos após o diagnóstico CORRETA
Correta. O risco se concentra em torno do diagnóstico, do ano anterior ao terceiro ano depois, e o rastreio se repete nesse intervalo.

Para levar. Dermatomiosite do adulto: neoplasia concentra-se do ano anterior ao terceiro ano após o diagnóstico; rastreie ao diagnóstico e repita nesse intervalo, mais intensamente com anti-TIF1-gama ou anti-NXP2.

IMACS 2023 guideline on cancer screening in idiopathic inflammatory myopathies (Oldroyd et al.); Hill et al., Lancet 2001.

15

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Cardiologia · Cardiopatia chagásica em hipertenso e diabético: sorologia antes do cateterismo

Homem de 54 anos, hipertenso e diabético, nascido na zona rural do norte de Minas Gerais, onde viveu até os 20 anos em casa de pau a pique, refere palpitações e dispneia aos médios esforços há 8 meses. Nega angina. PA 132×80 mmHg, FC 58 bpm, B3, sem sopros. ECG: bradicardia sinusal, bloqueio completo de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo e extrassístoles ventriculares polimórficas. Ecocardiograma: FE 38%, aneurisma apical do VE e hipocinesia inferolateral. Troponina normal. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

bloqueio completo de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo

Resolução. Hipertensão, diabetes e um aneurisma apical são rótulos verdadeiros que levam à cardiopatia isquêmica e ao cateterismo, e é para lá que ele costuma ir, pedindo o exame do degrau seguinte. O ECG e a epidemiologia dizem outra coisa: bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional anterossuperior, bradicardia sinusal e extrassístoles ventriculares polimórficas, em quem viveu em casa de pau a pique em área endêmica, é a combinação da cardiopatia chagásica. O aneurisma apical e a hipocinesia inferolateral (segmentos em que a fibrose chagásica predomina, sem angina) cabem na mesma doença. O diagnóstico é sorológico, com dois métodos de princípios diferentes (ELISA, imunofluorescência ou hemaglutinação), e é barato e decisivo; a pesquisa de doença coronária fica para depois se houver angina ou se a sorologia for negativa.

A) Cineangiocoronariografia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria o caminho na suspeita isquêmica com angina ou alteração segmentar em território coronário; aqui o padrão eletrocardiográfico e a epidemiologia apontam Chagas, que se confirma com sorologia.

B) Sorologia para T. cruzi CORRETA
Correta. BRD com BDAS, aneurisma apical e epidemiologia: a sorologia por dois métodos confirma a etiologia, que muda o tratamento e o prognóstico.

C) Ressonância cardíaca com realce tardio
Errada. A ressonância mostra fibrose, mas não define a etiologia sem a sorologia; é exame complementar, não o próximo.

D) Cintilografia de perfusão miocárdica
Errada. A cintilografia pode mostrar defeitos de perfusão também no Chagas e não confirma a etiologia.

Para levar. Bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional anterossuperior, aneurisma apical e extrassístoles em quem viveu em área endêmica: sorologia para T. cruzi por dois métodos antes de qualquer exame invasivo.

I Diretriz Latino-Americana para o Diagnóstico e Tratamento da Cardiopatia Chagásica (SBC 2011); Consenso Brasileiro em Doença de Chagas 2015; AHA Scientific Statement 2018 (Chagas cardiomyopathy)

16 Nefrologia · Intoxicação crônica por lítio precipitada por analgésico sem receita · hemodiálise pela clínica, não pela litemia

Droga a deduzir **Gabarito D**

Homem de 49 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio 900 mg/dia há dez anos (litemias anteriores entre 0,7 e 0,9 mEq/L), torceu o tornozelo há dez dias e passou a tomar, três vezes ao dia, um comprimido para dor e inchaço comprado sem receita. Há três dias tem diarreia e tremor grosseiro, e hoje ficou confuso. Exame: Glasgow 10, mioclonias, hiper-reflexia, PA 118/72 mmHg, FC 56 bpm. Exames: creatinina 2,1 mg/dL (basal 1,0), sódio 141 mEq/L, potássio 4,3 mEq/L, litemia de 2,6 mEq/L colhida 12 horas após a última dose. ECG: bradicardia sinusal e QTc de 470 ms. Além de suspender o lítio e o analgésico, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Glasgow 10

Resolução. Litemia de 2,6, abaixo dos cortes de 4 e 5 mEq/L que ele lembra como indicação de diálise, leva a tratar com soro e repetir a dosagem. Mas na intoxicação crônica o lítio já se distribuiu para o cérebro, e a litemia subestima a gravidade: quem manda é a clínica. Pelo EXTRIP, a hemodiálise é recomendada, qualquer que seja a litemia, quando há rebaixamento de consciência, convulsões ou arritmia com risco de vida, e aqui há Glasgow 10 com mioclonias. A causa da intoxicação é a droga a deduzir: comprimido para dor e inchaço vendido sem receita é anti-inflamatório não esteroidal, que reduz a filtração e aumenta a reabsorção proximal de lítio; a diarreia e a lesão renal agravaram o acúmulo. Carvão ativado não adsorve lítio, e a furosemida, ao depletar volume, aumenta a reabsorção de lítio. SF 0,9% é adjuvante, mas não substitui a diálise neste quadro.

A) Carvão ativado em doses múltiplas

Errada. O lítio é um íon pequeno e não é adsorvido por carvão ativado; a irrigação intestinal só tem papel na ingestão aguda de comprimidos de liberação prolongada.

B) Diurese forçada com furosemida

Errada. A furosemida espolia volume e aumenta a reabsorção proximal de sódio e de lítio, piorando a intoxicação.

C) SF 0,9% e nova litemia em 6 horas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Hidratação e nova dosagem seriam a conduta na intoxicação leve, sem rebaixamento e com função renal preservada; com Glasgow 10, esperar significa mais dano neurológico, potencialmente permanente.

D) Hemodiálise CORRETA

Correta. Rebaixamento de consciência na intoxicação por lítio indica hemodiálise qualquer que seja a litemia, e a lesão renal reforça a indicação.

Para levar. Na intoxicação crônica por lítio, a clínica manda: rebaixamento, convulsão ou arritmia grave indicam hemodiálise mesmo com litemia abaixo de 4; AINE, tiazídico e IECA ou BRA elevam o lítio.

EXTRIP Workgroup, Extracorporeal Treatment for Lithium Poisoning (Clin J Am Soc Nephrol 2015); Harrison 21ª ed. (Acute Poisoning).

17 Hematologia · Linfoma do manto leucemizado x LLC: CD5 positivo com CD23 negativo

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 64 anos procura atendimento por perda de 7 kg e sudorese noturna há 4 meses, com diarreia e pesquisa de sangue oculto positiva. Exame: linfonodos cervicais, axilares e inguinais de 2 a 4 cm, baço a 6 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 10,8 g/dL, leucócitos 46.000/mm³ com 78% de linfócitos pequenos a médios de contorno nuclear irregular, plaquetas 112.000/mm³. LDH 410 U/L. Imunofenotipagem do sangue periférico: CD19+, CD20+ forte, CD5+, CD23 negativo, CD200 negativo, CD10 negativo, cadeia leve lambda restrita. Colonoscopia: múltiplos pólipos pequenos no cólon. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

CD23 negativo, CD200 negativo

Resolução. Linfocitose B monoclonal CD5+ com linfonodomegalia e esplenomegalia num idoso parece leucemia linfocítica crônica, e o CD5 positivo é verdadeiro. O que separa é o restante do painel: a LLC é CD5+ com CD23+ e CD200+, CD20 fraco e linfócitos pequenos e redondos; aqui CD23 e CD200 são negativos, CD20 é forte e os núcleos são irregulares. CD5+ com CD23 negativo é linfoma do manto até prova em contrário, confirmado por ciclina D1 (ou SOX11) e t(11;14). A polipose linfomatosa múltipla do intestino é forma de apresentação do manto, e os sintomas B e a LDH alta indicam doença agressiva, diferente da LLC indolente. O folicular seria CD10+ e CD5 negativo, e a zona marginal, CD5 e CD10 negativos.

A) Leucemia linfocítica crônica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: CD5+ também está na LLC, mas ela seria CD23+ e CD200+, com CD20 fraco.

B) Linfoma folicular
Errada. O folicular é CD10+ e CD5 negativo, com t(14;18).

C) Linfoma da zona marginal esplênico
Errada. A zona marginal esplênica é CD5 e CD10 negativos, com esplenomegalia volumosa e pouca linfonodomegalia.

D) Linfoma do manto CORRETA
Correta. CD5+ com CD23 e CD200 negativos, CD20 forte e polipose linfomatosa intestinal: linfoma do manto.

Para levar. CD5+ não é sinônimo de LLC: LLC é CD5+ CD23+ CD200+ com CD20 fraco; CD5+ com CD23 negativo é linfoma do manto (ciclina D1, t(11;14)).

Classificação OMS 2022 (5ª edição) das neoplasias linfoides; iwCLL 2018 e escore de Matutes.

---

18 Pneumologia · Urinotórax: o transudato de pH baixo após nefrostomia

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 71 anos, com hiperplasia prostática, está internado há 6 dias por uropatia obstrutiva com hidronefrose bilateral, tratada com sondagem vesical e, no 2º dia, nefrostomia percutânea à direita após tentativa frustrada de cateter duplo J. Há 2 dias tem dispneia leve e dor lombar direita. Afebril, PA 136 × 82 mmHg, FC 88 bpm, SpO2 94% em ar ambiente. Radiografia: derrame pleural direito novo, de volume moderado. Toracocentese: líquido citrino e claro, pH 7,12, glicose 98 mg/dL, proteína 0,9 g/dL (sérica 6,4), LDH 82 U/L

(sérica 240; limite superior da normalidade 250), 300 células/mm³, Gram sem bactérias. Creatinina sérica 2,3 mg/dL. A classificação do líquido e o passo seguinte mais adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

proteína 0,9 g/dL (sérica 6,4), LDH 82 U/L (sérica 240; limite superior da normalidade 250)

Resolução. O pH de 7,12 dispara a regra do parapneumônico complicado (pH abaixo de 7,2, drenar). Mas a regra vale para exsudato infectado, e este líquido é transudato por todos os critérios de Light (proteína 0,14, LDH 0,34 e LDH pleural abaixo de dois terços do limite), com glicose normal, poucas células, Gram negativo e paciente afebril. Transudato com pH baixo tem praticamente uma causa: urinotórax, a urina que chega à pleura pelo retroperitônio, aqui do mesmo lado de uma nefrostomia recente, numa uropatia obstrutiva. Confirma-se com creatinina no líquido maior que a sérica (relação acima de 1). O tratamento é resolver a via urinária (reposicionar a nefrostomia ou desobstruir), e o derrame some sem dreno torácico.

A) Exsudato / drenagem torácica ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O pH abaixo de 7,2 só indica drenagem no exsudato parapneumônico; este líquido é transudato, afebril e sem bactérias.

B) Exsudato / creatinina no líquido
Errada na classificação. O exame está certo, mas proteína 0,14 e LDH 0,34 pelos critérios de Light são de transudato.

C) Transudato / creatinina no líquido CORRETA
Correta. Transudato com pH baixo do lado da nefrostomia: urinotórax, confirmado por creatinina pleural maior que a sérica.

D) Transudato / drenagem torácica
Errada. Acerta a classificação, mas o urinotórax resolve com a correção da via urinária; dreno torácico não trata a causa.

Para levar. Transudato com pH baixo é urinotórax até prova em contrário: pede creatinina no líquido (relação com a sérica acima de 1) e correção da via urinária, não dreno.

BTS Guideline for pleural disease 2023; Light RW, Pleural Diseases, 6ª ed. (2013)

---

19 Oncologia · Hidratação artificial nos últimos dias de vida: cuidado oral em vez de soro

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 81 anos com adenocarcinoma de pâncreas metastático está em fim de vida em enfermaria de cuidados paliativos (PPS 10%), sonolenta, despertando ao chamado, e aceita apenas pequenos goles de água há 3 dias. Sem dor, sem dispneia, sem agitação; urina concentrada, cerca de 300 mL/dia. A filha pede soro para que a mãe não morra de sede. Exame: mucosa oral seca, edema de membros inferiores 2+, estertores finos em bases, sem desconforto respiratório. Sódio 147 mEq/L, creatinina 1,9 mg/dL. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

edema de membros inferiores 2+, estertores finos em bases

Resolução. O pedido da filha e o sódio de 147 empurram para hipodermóclise, que parece o mínimo humano. Nos últimos dias de vida, a hidratação artificial não melhora sede, delirium nem sobrevida, e a boca seca se alivia com higiene e umidificação oral frequentes, pequenos goles e gelo. Esta paciente já tem edema 2+ e estertores em bases: soro aumenta a congestão, as secreções respiratórias e o edema, sem aliviar a sede. A conduta é explicar à família que a perda do interesse por comida e água faz parte do morrer, oferecer cuidado oral e reavaliar diariamente; hidratação pode ser considerada em casos selecionados, sem sinais de sobrecarga e com objetivo definido.

A) Cuidado oral, sem hidratação artificial CORRETA
Correta. Fim de vida com sinais de sobrecarga hídrica: o cuidado oral alivia a boca seca, e a hidratação artificial não traz benefício e aumenta a congestão.

B) Hipodermóclise com 1.000 mL/dia de soro ARMADILHA
Errada. É a isca: a hipodermóclise tem papel em casos selecionados, mas com edema e estertores piora secreções e desconforto sem aliviar a sede.

C) Soro glicosado 5% intravenoso
Errada. Volume intravenoso, com glicose, agrava a sobrecarga e exige acesso venoso sem benefício.

D) Sonda nasoenteral para água e dieta
Errada. Sonda nasoenteral nos últimos dias causa desconforto e risco de aspiração e não prolonga a vida.

Para levar. Nos últimos dias de vida, boca seca se trata com cuidado oral; hidratação artificial não alivia sede e piora edema e secreções.

NICE NG31: Care of dying adults in the last days of life (2015); Bruera et al., Parenteral hydration in patients with advanced cancer (J Clin Oncol, 2013)

---

20 Infectologia · Chikungunya na fase subaguda: corticoide antes da droga modificadora

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 52 anos, previamente hígida, teve há 10 semanas febre alta súbita, exantema e poliartralgia intensa durante surto de chikungunya no bairro, com RT-PCR positivo para o vírus no 3º dia. A febre cedeu em 5 dias, mas persistem dor e edema em punhos, metacarpofalangeanas e tornozelos, com rigidez matinal de 40 minutos, que a impedem de trabalhar. Usou paracetamol e dipirona, e depois ibuprofeno por 2 semanas, sem melhora. Exame: artrite de punhos, 2ª e 3ª metacarpofalangeanas bilaterais e tornozelos, tenossinovite de extensores. VHS 42 mm, PCR 2,1 mg/dL, fator reumatoide e anti-CCP não reagentes, creatinina 0,8 mg/dL, glicemia 92 mg/dL, sem hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

teve há 10 semanas febre alta súbita

Resolução. Poliartrite simétrica persistente de mãos com rigidez matinal leva ao raciocínio de artrite crônica e à droga modificadora, e a hidroxicloroquina é justamente a primeira linha da chikungunya crônica. O limiar que decide é o tempo: o Ministério da Saúde divide a doença em fase aguda (até 14 dias), subaguda (do 15º dia até 3 meses) e crônica (depois de 3 meses). Com 10 semanas, ela está na fase subaguda, em que a droga de escolha, com dor moderada a intensa e falha dos analgésicos e anti-inflamatórios, é a prednisona em dose de 0,5 mg/kg/dia (máximo de cerca de 40 mg), por curto período e com desmame. Hidroxicloroquina,

sulfassalazina e metotrexato ficam para a fase crônica. FR e anti-CCP negativos e a relação com o surto afastam artrite reumatoide.

A) Metotrexato semanal
Errada. Metotrexato é opção na fase crônica, sobretudo com padrão de artrite reumatoide; com 10 semanas, ainda é cedo.

B) Hidroxicloroquina diária ARMADILHA
Errada. É a armadilha: hidroxicloroquina é a primeira linha da chikungunya crônica (mais de 3 meses); com 10 semanas, a fase é subaguda.

C) Prednisona 0,5 mg/kg/dia com desmame CORRETA
Correta. Fase subaguda (15 dias a 3 meses) com dor intensa refratária: prednisona 0,5 mg/kg/dia com desmame.

D) Manter anti-inflamatório por 3 meses
Errada. Ela já falhou ao anti-inflamatório; manter a mesma droga por 3 meses prolonga a incapacidade sem ganho.

Para levar. Chikungunya: até 14 dias, analgésico; de 15 dias a 3 meses, prednisona; depois de 3 meses, hidroxicloroquina, sulfassalazina ou metotrexato.

Chikungunya: manejo clínico (MS, 2017); Recomendações da SBR para o diagnóstico e tratamento da febre chikungunya (Rev Bras Reumatol, 2017).

21

Neurologia · Vertigem aguda pós-resfriado com impulso cefálico anormal e desvio vertical: um sinal central basta

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 58 anos, hipertenso, apresenta há 7 horas tontura rotatória contínua, vômitos e desequilíbrio, iniciados ao acordar, sem relação com a posição da cabeça. Teve resfriado há 10 dias. Nega hipoacusia, cefaleia e disartria. Exame: nistagmo horizontal-torcional batendo para a direita, unidirecional, que diminui com a fixação visual; teste do impulso cefálico com sacada corretiva para a esquerda; na cobertura alternada, o olho direito corrige para baixo e o esquerdo para cima a cada troca; marcha com lateropulsão para a esquerda, sem dismetria apendicular. TC de crânio sem contraste normal. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

na cobertura alternada, o olho direito corrige para baixo e o esquerdo para cima a cada troca

Resolução. Resfriado recente, nistagmo unidirecional que diminui com a fixação e impulso cefálico anormal compõem o retrato de neurite vestibular, e esses dados são verdadeiros. Mas o HINTS só é periférico quando os três componentes são periféricos, e aqui há desvio vertical (skew) na cobertura alternada: o realinhamento vertical a cada troca de olho é sinal de lesão de tronco ou cerebelo, com especificidade alta para AVC. Um impulso cefálico anormal não protege contra AVC: o infarto da artéria cerebelar anteroinferior (AICA), que irriga o labirinto, dá impulso anormal e pode vir sem hipoacusia no início. Hipertensão e instalação ao acordar completam o risco. TC sem contraste não exclui isquemia de fossa posterior; o próximo passo é RM com difusão (com repetição em 48 a 72 horas se a primeira vier normal e a suspeita persistir) e avaliação vascular.

A) Manobra de reposicionamento de Epley

Errada. Epley trata VPPB de canal posterior, que dá crises posicionais de segundos e não tontura contínua com nistagmo espontâneo.

B) Audiometria e prova calórica ambulatoriais

Errada. Audiometria e prova calórica servem à investigação ambulatorial de vestibulopatia periférica; aqui há sinal central e a RM é urgente.

C) RM de encéfalo com difusão CORRETA

Correta. Desvio vertical na cobertura alternada é componente central do HINTS: RM com difusão, mesmo com impulso cefálico anormal e pródromo viral.

D) Prednisona oral e alta ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a conduta na neurite vestibular com HINTS inteiramente periférico; o desvio vertical torna o HINTS central.

Para levar. O HINTS é periférico só com os três componentes periféricos. Desvio vertical, nistagmo que muda de direção ou impulso cefálico normal: tratar como AVC.

Kattah et al., Stroke 2009; Newman-Toker 2013 (HINTS plus); Guideline ACEP/SAEM 2023 (tontura aguda).

---

22 Endocrinologia · Gastrinoma com prolactinoma: o cálcio que falta no caso (NEM 1)

Dado omitido | Gabarito A

Homem de 36 anos é investigado por úlceras duodenais múltiplas e recorrentes, uma delas no jejuno proximal, diarreia crônica e gastrina de jejum de 1.400 pg/mL (até 100) com pH gástrico de 1,5, colhida após uma semana sem inibidor de bomba. Há dois anos teve prolactinoma de 8 mm, controlado com cabergolina. O pai foi operado de cálculos renais três vezes. A tomografia mostra lesão de 1,2 cm na parede duodenal e outra de 0,8 cm na cabeça do pâncreas. O exame que mais modifica a conduta neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

O pai foi operado de cálculos renais três vezes

Resolução. O caso dá gastrinoma confirmado (gastrina acima de dez vezes o limite com pH abaixo de 2, sem necessidade de secretina) e lesões já vistas, e convida a completar a localização e estadiar. O dado omitido é o cálcio: gastrinoma múltiplo duodenal com prolactinoma em homem jovem é neoplasia endócrina múltipla tipo 1, cujo componente mais frequente (acima de 90%) é o hiperparatireoidismo, e o pai com nefrolitíase de repetição é a pista. Cálcio e PTH mudam a conduta de três formas: confirmam a síndrome e o rastreio familiar, indicam paratireoidectomia subtotal, e a hipercalcemia estimula a gastrina, de modo que corrigir o hiperparatireoidismo primeiro reduz a hipergastrinemia e a dose de inibidor de bomba. No gastrinoma da NEM 1 com lesões de até 2 cm, o tratamento costuma ser clínico, e não cirúrgico.

A) Cálcio sérico e PTH CORRETA

Correta. Gastrinoma com prolactinoma é NEM 1 até prova em contrário; o hiperparatireoidismo deve ser confirmado e tratado primeiro, porque a hipercalcemia agrava a hipergastrinemia.

B) Teste de estímulo com secretina
Errada. Só é necessário quando a gastrina está abaixo de dez vezes o limite; 1.400 pg/mL com pH de 1,5 já confirma.

C) Ecoendoscopia pancreática
Errada. Detalha lesões pancreáticas, mas não muda a ordem do tratamento.

D) Cintilografia com análogo da somatostatina ARMADILHA
Errada. Seria útil para estadiar um gastrinoma esporádico candidato a ressecção; aqui não muda a decisão antes de definir a síndrome.

Para levar. Gastrinoma ou prolactinoma em jovem com história familiar de cálculo renal: dose cálcio e PTH (NEM 1); corrigir o hiperparatireoidismo vem antes e reduz a gastrina.

Clinical Practice Guidelines for Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 (Thakker et al., J Clin Endocrinol Metab 2012); ENETS Guidance Paper for gastroduodenal NETs 2023.

23

Reumatologia · Artrite reumatoide sem resposta a metotrexato em subdose e sem ácido fólico

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 38 anos tem artrite reumatoide diagnosticada há 4 meses (FR e anti-CCP reagentes, erosão em 1 metacarpofalângica), em uso de metotrexato 10 mg/semana por via oral desde o diagnóstico, sem ácido fólico, e prednisona 5 mg/dia. Refere aftas orais recorrentes e náusea no dia da tomada. Não consome álcool e não planeja gestação, com contracepção eficaz. Exame físico: 8 articulações dolorosas e 6 edemaciadas. Exames: CDAI 28, hemograma normal, creatinina 0,7 mg/dL, ALT 28 U/L, sorologias para hepatites B e C negativas. Radiografia de tórax normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

metotrexato 10 mg/semana por via oral desde o diagnóstico, sem ácido fólico

Resolução. Doença ativa após 4 meses de metotrexato com fatores de mau prognóstico (soropositividade e erosão) parece falha e indicação de biológico. Mas o metotrexato nunca foi usado em dose eficaz: 10 mg/semana é dose inicial, e a falha só se declara após escalonar para 20 a 25 mg/semana (ou a dose máxima tolerada) por tempo suficiente. As aftas e a náusea não são motivo para trocar a droga: são efeitos ligados à antagonização do folato, que o ácido fólico semanal reduz, e a via subcutânea ajuda na náusea. O passo correto é otimizar o metotrexato com ácido fólico, reavaliar em cerca de 3 meses buscando ao menos melhora significativa, e só então associar biológico ou outro sintético se o alvo não for atingido. Aumentar o corticoide trata o sintoma e acumula toxicidade, sem modificar a doença.

A) Trocar metotrexato por leflunomida
Errada. Trocar por intolerância só se justifica quando a intolerância persiste com ácido fólico e mudança de via; aftas e náusea são as que o folato corrige.

B) Associar adalimumabe ARMADILHA
Errada. Seria o passo na falha de metotrexato em dose otimizada, com fatores de mau prognóstico; aqui a dose nunca passou de 10 mg.

C) Metotrexato 20 mg/semana com ácido fólico CORRETA

Correta. Escalonar o metotrexato até 20 a 25 mg/semana e associar ácido fólico é cumprir o degrau antes de declarar falha.

D) Aumentar prednisona para 20 mg/dia

Errada. Corticoide é ponte de curta duração e não modifica a doença; subir a dose acumula efeitos adversos.

Para levar. Falha de metotrexato só conta com 20 a 25 mg/semana (ou dose máxima tolerada) e ácido fólico; aftas e náusea se tratam com folato e via subcutânea, não com troca.

SBR 2017 recomendações para o tratamento da artrite reumatoide; EULAR 2022 recommendations for RA management; ACR 2021 RA guideline.

---

24 Oncologia · Dispneia no fim de vida com doença renal crônica sem diálise: fentanil em vez de morfina

Qualificador **Gabarito C**

Para controle de dispneia refratária nos últimos dias de vida de paciente com doença renal crônica dialítica que optou por suspender a hemodiálise, o opioide mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

optou por suspender a hemodiálise

Resolução. Morfina é a primeira linha para dispneia refratária, e é a regra que ele precisa fixar; esta questão cobra a exceção. Sem diálise, a morfina acumula metabólitos ativos de eliminação renal (morfina-3-glicuronídeo, neuroexcitatório, e morfina-6-glicuronídeo, sedativo e depressor respiratório), com mioclonias, delirium e sedação prolongada. O fentanil é metabolizado no fígado em metabólitos inativos e é o opioide preferido na insuficiência renal grave, por via subcutânea ou transdérmica. Codeína e tramadol também dependem do rim, têm efeito imprevisível, e o tramadol baixa o limiar convulsivo.

A) Codeína

Errada. A codeína é pró-droga convertida em morfina, com os mesmos metabólitos renais e efeito errático.

B) Tramadol

Errada. O tramadol acumula na insuficiência renal, baixa o limiar convulsivo e tem pouco efeito sobre a dispneia.

C) Fentanil CORRETA

Correta. O fentanil não tem metabólitos ativos de eliminação renal e é o opioide de escolha na doença renal terminal sem diálise.

D) Morfina ARMADILHA

Errada. É a isca: a morfina é a primeira linha para dispneia, exceto na insuficiência renal grave sem diálise, em que seus metabólitos acumulam.

Para levar. Opioide no fim de vida com insuficiência renal grave: fentanil (ou metadona, buprenorfina); evitar morfina, codeína e tramadol.

King et al., EAPC recommendations on opioids in renal impairment (Palliat Med, 2011); ASCO Guideline: Management of Dyspnea in Advanced Cancer (2021); KDIGO Controversies Conference on supportive care in CKD (2015)

---

25 Nefrologia · GESF com proteinúria nefrótica e albumina normal na obesidade grave · forma adaptativa, e não primária

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 36 anos, com IMC de 42 kg/m², apneia do sono e hipertensão em uso de anlodipino, foi encaminhado por proteinúria em exame admissional. Sem edema e sem história familiar de doença renal. Exames: proteinúria de 24 h de 4,6 g, albumina sérica 4,1 g/dL, colesterol total 214 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL, urina com 2 hemácias por campo, sorologias para HIV e hepatites B e C negativas, FAN negativo, C3 e C4 normais. Biópsia renal: glomeruloesclerose segmentar e focal de variante peri-hilar, com glomerulomegalia; microscopia eletrônica com apagamento segmentar dos processos podocitários. Quanto à forma da GESF, o diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

albumina sérica 4,1 g/dL

Resolução. Proteinúria de 4,6 g com biópsia de GESF puxa para a GESF primária, a que se trata com corticoide, e é aí que o rótulo histológico engana. A GESF é um padrão de lesão, não uma doença: a primária é uma podocitopatia difusa por fator circulante e se apresenta como síndrome nefrótica completa, com hipoalbuminemia, edema e apagamento podocitário difuso. Aqui a proteinúria é nefrótica, mas a albumina sérica é normal (4,1) e não há edema, e a microscopia eletrônica mostra apagamento apenas segmentar, com glomerulomegalia e variante peri-hilar: é a GESF adaptativa à hiperfiltração da obesidade grave. Sem história familiar e com sorologias negativas, as formas genética e viral ficam menos prováveis, e a viral costuma ser colapsante. A classificação muda o tratamento: na adaptativa, bloqueio do sistema renina-angiotensina, iSGLT2 e perda de peso (inclusive cirurgia bariátrica); corticoide e inibidores de calcineurina não funcionam e expõem um obeso a efeitos adversos graves.

A) Genética, por variante podocitária
Errada. A forma genética entra no jovem com história familiar, início precoce ou resistência a corticoide; não há história familiar, e a glomerulomegalia peri-hilar num IMC de 42 tem explicação mais simples.

B) Primária, por fator circulante ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a forma com síndrome nefrótica completa (albumina baixa, edema) e apagamento podocitário difuso, a que justifica corticoide; aqui a albumina é de 4,1 g/dL e o apagamento é segmentar.

C) Viral, por lesão podocitária direta
Errada. A GESF viral (HIV, parvovírus B19, CMV) costuma ser colapsante, com síndrome nefrótica intensa e perda rápida de função; as sorologias são negativas e a variante é peri-hilar.

D) Adaptativa, por hiperfiltração CORRETA
Correta. Proteinúria nefrótica sem hipoalbuminemia nem edema, variante peri-hilar, glomerulomegalia e apagamento segmentar num IMC de 42: GESF adaptativa à hiperfiltração.

Para levar. GESF é padrão de lesão: proteinúria nefrótica com albumina sérica normal, apagamento podocitário segmentar e variante peri-hilar indicam forma adaptativa (obesidade, hiperfiltração), tratada com bloqueio do SRAA, iSGLT2 e perda de peso, sem imunossupressão.

KDIGO 2021 (Glomerular Diseases), capítulo de GESF; De Vriese et al., JASN 2018 (classificação da GESF primária e secundária).

---

26 Hematologia · Síndrome antifosfolípide primária com tripla positividade: varfarina por tempo indeterminado

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 41 anos, sem lúpus ou outra doença autoimune, teve trombose venosa profunda femoropoplítea esquerda há 4 meses, sem fator desencadeante, tratada com rivaroxabana 20 mg/dia, sem recorrência e sem sangramento até agora; ela prefere seguir com o comprimido sem exames de controle. Tem duas perdas gestacionais após 10 semanas de gestação. Exames colhidos antes da anticoagulação mostraram anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina IgG 82 GPL e anti-beta-2-glicoproteína I IgG 64 U, e os três se repetiram positivos após 12 semanas, em amostra tratada para remover a interferência do anticoagulante. FAN negativo, função renal normal, IMC de 26 kg/m². Quanto ao anticoagulante e à duração, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina IgG 82 GPL e anti-beta-2-glicoproteína I IgG 64 U

Resolução. A duração é a metade mais segura: TEV não provocado com síndrome antifosfolípide persistente tem alto risco de recorrência, e a anticoagulação é por tempo indeterminado. A armadilha está na droga: ela já usa rivaroxabana, que é cômoda e trata a TVP, e o apressado só estende. Mas o perfil é de tripla positividade (anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína I persistentes), o de maior risco, e no ensaio TRAPS a rivaroxabana, nesse grupo, teve mais eventos trombóticos (sobretudo arteriais) que a varfarina, a ponto de o estudo ser interrompido. EULAR e ISTH recomendam não usar rivaroxabana na tripla positividade e preferir antagonista da vitamina K com INR de 2 a 3. Ela não precisa de LES para ser SAF: é a forma primária.

A) Trocar por varfarina / indefinida CORRETA
Correta. SAF com tripla positividade e TEV não provocado: varfarina (INR 2 a 3) por tempo indeterminado.

B) Manter rivaroxabana / indefinida ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a duração está certa, mas a rivaroxabana na tripla positividade aumenta trombose arterial e venosa em relação à varfarina.

C) Manter rivaroxabana / 6 meses
Errada. Erra as duas metades: seis meses seria para TEV provocado sem SAF, e a droga não é a indicada para este perfil.

D) Trocar por varfarina / 6 meses
Errada. A droga está certa, mas parar aos 6 meses na SAF com TEV não provocado expõe a recorrência alta.

Para levar. SAF com TEV não provocado anticoagula por tempo indeterminado com varfarina; na tripla positividade a rivaroxabana é contraindicada (TRAPS), com ou sem LES.

EULAR 2019 recommendations for the management of APS in adults; ISTH 2020 guidance on DOACs in APS; critérios de classificação ACR/EULAR 2023 para SAF.

---

27 Pneumologia · Silicose com cavitação nova: tuberculose antes de câncer

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 54 anos trabalhou 22 anos em pedreira, com jateamento de areia e corte de granito, e tem silicose com conglomerados nos lobos superiores diagnosticada há 6 anos. É tabagista (35 maços-ano). Há 2 meses tem tosse produtiva, febre baixa vespertina, sudorese noturna e perda de 5 kg. TC de tórax: os conglomerados do lobo superior direito, estáveis há 2 anos, agora apresentam cavidade de paredes espessas de 3 cm. Leucócitos 8.900/mm³. Duas baciloscopias de escarro negativas. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

agora apresentam cavidade de paredes espessas de 3 cm

Resolução. Tabagista de 35 maços-ano com cavidade de paredes espessas e perda de peso lembra carcinoma escamoso cavitado, e duas baciloscopias negativas parecem afastar tuberculose. Mas silicose multiplica o risco de tuberculose (de 3 a 30 vezes, mais nas formas com conglomerado), e cavitação nova num conglomerado antes estável, com febre vespertina e sudorese noturna, é silicotuberculose até prova em contrário. Baciloscopia tem sensibilidade baixa, sobretudo em lesões encapsuladas. O passo seguinte é o teste rápido molecular (que também mostra resistência à rifampicina) e a cultura com teste de sensibilidade no escarro, simples e de maior rendimento. Broncoscopia, biópsia ou PET entram se o escarro não esclarecer; PET capta tanto em tuberculose quanto em conglomerado silicótico e não separa as duas.

A) Broncoscopia com biópsia da lesão ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Broncoscopia com lavado e biópsia é o passo se o escarro com TRM e cultura não esclarecer, ou se não houver escarro.

B) Teste rápido molecular e cultura no escarro CORRETA
Correta. Silicose com cavitação nova e sintomas constitucionais: TRM-TB e cultura no escarro, apesar de baciloscopias negativas.

C) PET-CT de corpo inteiro
Errada. PET capta em tuberculose, em conglomerado silicótico e em câncer: não diferencia e não diagnostica.

D) Biópsia transtorácica guiada por TC
Errada. Biópsia percutânea de lesão cavitada tem risco de pneumotórax e baixo rendimento para tuberculose; não é o primeiro exame.

Para levar. Silicose com cavitação nova é tuberculose até prova em contrário: TRM-TB e cultura no escarro antes de qualquer procedimento invasivo, mesmo com baciloscopia negativa.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019); ATS/CDC/IDSA 2017 (diagnóstico de tuberculose)

---

28 Cardiologia · Edema agudo de pulmão hipertensivo: VNI e nitrato, sem morfina de rotina

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 72 anos, hipertenso, chega à emergência com dispneia súbita há 1 hora, sentado, agitado, muito ansioso e sudoreico. PA 206×112 mmHg, FC 118 bpm, FR 34 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores até ápices, sem sopros. Consciente, colaborativo e protegendo a via aérea. ECG: taquicardia sinusal com sobrecarga de VE, sem supradesnivelamento de ST. Radiografia: congestão bilateral em asa de borboleta. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Consciente, colaborativo e protegendo a via aérea

Resolução. Agitação e ansiedade intensas são um rótulo verdadeiro que chama a morfina, e morfina com furosemida é a resposta que o banco dele aceitou em outra questão. No edema agudo de pulmão hipertensivo, o problema é redistribuição por pós-carga alta, mais que excesso de volume: o tratamento é vasodilatador (nitrato IV em doses altas, ou nitroprussiato) com ventilação não invasiva, que reduz trabalho respiratório, pré e pós-carga e a necessidade de intubação; furosemida entra junto. A morfina saiu do uso de rotina por associação a mais ventilação mecânica e mortalidade, e a ansiedade melhora com a VNI e a queda da PA. Ele está consciente e protege a via aérea, o que permite VNI em vez de intubação; diurético isolado não trata o mecanismo.

A) Intubação orotraqueal imediata
Errada. A intubação é para rebaixamento de consciência, incapacidade de proteger a via aérea ou falha da VNI; ele está consciente e colaborativo.

B) Morfina IV e furosemida IV ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A morfina deprime o drive respiratório e associou-se a pior desfecho; a agitação aqui é da hipoxemia e melhora com VNI.

C) Furosemida IV isolada em dose alta
Errada. Furosemida isolada não corrige a pós-carga alta, que é o mecanismo do edema hipertensivo, e demora mais que o nitrato.

D) VNI, nitrato IV e furosemida IV CORRETA
Correta. VNI com nitrato IV em dose alta e furosemida trata a pós-carga, a hipoxemia e a congestão, e reduz intubação.

Para levar. Edema agudo de pulmão hipertensivo: VNI, nitrato IV em dose alta (ou nitroprussiato) e furosemida; morfina não é de rotina, e a agitação melhora com a ventilação e a queda da PA.

ESC 2021 (heart failure) e atualização 2023; Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (SBC 2018)

---

29 Infectologia · Síndrome cardiopulmonar por hantavírus x leptospirose pulmonar no trabalhador rural

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 39 anos, agricultor em Santa Catarina, há 10 dias limpou um paiol de milho fechado havia meses, com muitas fezes de roedores. Há 4 dias tem febre de 39 °C, mialgia intensa, cefaleia, dor lombar e náuseas; há

12 horas, tosse seca e dispneia progressiva. Exame: T 38,7 °C, FR 32 irpm, FC 124 bpm, PA 92 × 58 mmHg, SpO2 86% em ar ambiente, estertores difusos bilaterais, sem icterícia, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores. Hematócrito 54%, leucócitos 18.400/mm³ com desvio à esquerda e linfócitos atípicos, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 1,4 mg/dL, potássio 4,2 mEq/L, CK 340 U/L, bilirrubina total 0,9 mg/dL. Radiografia: infiltrado intersticial bilateral, linhas B e pequeno derrame pleural bilateral. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Hematócrito 54%

Resolução. Trabalho rural, roedores e insuficiência respiratória com plaquetopenia lembram a forma pulmonar da leptospirose, a doença de roedor mais conhecida. Mas a via e o laboratório apontam outra: a exposição foi a poeira de um paiol fechado com excretas (inalação de aerossol, não contato com água ou lama), e o hemograma traz a tríade da hantavirose, com hemoconcentração (hematócrito de 54%), plaquetopenia e leucocitose com desvio e linfócitos atípicos, e edema pulmonar não cardiogênico de instalação rápida após pródromo febril. A leptospirose pulmonar costuma vir com hemoptise, icterícia, sufusão conjuntival, CK alta, insuficiência renal com potássio baixo ou normal e sem hemoconcentração. A distinção muda o manejo: na hantavirose não há antiviral, e a reposição volêmica agressiva piora o edema; o suporte é em UTI, com volume criterioso, vasopressor e inotrópico precoces e, se necessário, ECMO.

A) Dengue com extravasamento plasmático
Errada. Dengue grave faz hemoconcentração e plaquetopenia, mas com leucopenia e sem desvio à esquerda, e não se adquire de roedores.

B) Hantavirose cardiopulmonar CORRETA
Correta. Inalação de poeira com excretas de roedor, hemoconcentração, plaquetopenia, linfócitos atípicos e edema pulmonar rápido.

C) Pneumonia pneumocócica com sepse
Errada. Pneumonia pneumocócica daria consolidação lobar, sem hemoconcentração e sem linfócitos atípicos.

D) Leptospirose com hemorragia pulmonar ARMADILHA
Errada. É a armadilha: leptospirose seria a hipótese com enchente ou esgoto, icterícia, sufusão conjuntival, CK alta e hemoptise; hemoconcentração com linfócitos atípicos após poeira de paiol é hantavírus.

Para levar. Poeira de ambiente fechado com roedores, hemoconcentração, plaquetopenia, linfócitos atípicos e edema pulmonar: hantavírus, com volume criterioso e suporte em UTI.

Guia de Vigilância em Saúde (MS, 6ª edição, 2023), capítulo de hantavirose; Manual de Vigilância, Prevenção e Controle das Hantaviroses (MS, 2014).

---

30 Neurologia · Crises por abstinência alcoólica: benzodiazepínico agora e nenhuma anticrise de manutenção

Grade X / Y | Gabarito A

Homem de 50 anos, etilista de 1 litro de cachaça por dia há 20 anos, internado há 30 horas na cirurgia para drenagem de abscesso perianal, sem beber desde a véspera da internação, apresenta duas crises tônico-clônicas generalizadas de 1 minuto cada, com 20 minutos de intervalo, recuperando a consciência entre elas. Está agora trêmulo, sudoreico e ansioso, FC 118 bpm, PA 158/94 mmHg, Tax 37,6 °C, parcialmente orientado, sem déficit focal e sem sinais de trauma. Nunca teve crise fora de períodos de abstinência. Glicemia 104 mg/dL,

sódio 136 mEq/L, magnésio 1,6 mg/dL (VR 1,7 a 2,4). TC de crânio sem contraste: atrofia cortical difusa. Quanto ao tratamento agudo e à prevenção de novas crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Nunca teve crise fora de períodos de abstinência.

Resolução. Crises entre 6 e 48 horas após parar de beber, com tremor, sudorese e taquicardia, são crises de abstinência: provocadas, por hiperexcitabilidade glutamatérgica com perda do tônus GABAérgico. O tratamento é benzodiazepínico, que age no mesmo receptor que o álcool deixou de estimular, previne novas crises e trata a abstinência que evolui para delirium tremens; somam-se tiamina antes de glicose e reposição de magnésio. Fenitoína não previne crises de abstinência (ensaios controlados não mostraram benefício) e não age no mecanismo. Como a crise é provocada e nunca ocorreu fora da abstinência, não há indicação de anticrise de manutenção: a prevenção é a abstinência sustentada. Duas crises curtas com recuperação entre elas não são estado de mal; a TC sem lesão, num paciente sem trauma e sem déficit, já cumpriu o papel.

A) Diazepam IV / sem anticrise de manutenção CORRETA
Correta. Benzodiazepínico para as crises e a abstinência, com tiamina e magnésio, e nenhuma anticrise de manutenção para crise provocada.

B) Diazepam IV / fenitoína de manutenção ARMADILHA
Errada na segunda metade, e é a armadilha. O diazepam está certo, mas fenitoína de manutenção trataria epilepsia, e crise de abstinência é provocada; a fenitoína nem previne essa crise.

C) Fenitoína IV de ataque / sem manutenção
Errada na primeira metade. Fenitoína de ataque não trata nem previne crise de abstinência, e deixa a síndrome de abstinência sem tratamento.

D) Levetiracetam IV / levetiracetam por 6 meses
Errada nas duas metades. Levetiracetam não trata a abstinência, e manutenção por 6 meses seria para epilepsia, não para crise provocada pelo álcool.

Para levar. Crise de abstinência alcoólica: benzodiazepínico, tiamina e magnésio. Fenitoína não previne, e anticrise de manutenção não se indica para crise provocada.

ASAM 2020 (manejo da abstinência alcoólica); EFNS 2005 (crises relacionadas ao álcool); ILAE (crise aguda sintomática).

---

31 Endocrinologia · Rastreio de Cushing em usuária de estrogênio: o teste que o anticoncepcional não falseia

Droga a deduzir | Gabarito C

Mulher de 27 anos, com síndrome dos ovários policísticos, usa há três anos o comprimido diário que a ginecologista prescreveu para regularizar a menstruação e controlar a acne, e não pretende suspendê-lo. Há oito meses ganhou 12 kg, com estrias violáceas de 1,5 cm no abdome, equimoses fáceis e hipertensão recente (PA 148/96 mmHg). Glicemia de jejum 118 mg/dL, potássio 3,9 mEq/L. Exame: fraqueza proximal ao levantar da cadeira, giba dorsal, face arredondada. O exame inicial mais adequado para rastrear hipercortisolismo nesta paciente é:

O DADO QUE DECIDE

usa há três anos o comprimido diário que a ginecologista prescreveu para regularizar a menstruação e controlar a acne

Resolução. Fraqueza proximal, estrias largas, equimoses e hipertensão justificam rastrear Cushing, e o teste de supressão com 1 mg de dexametasona é o mais lembrado. A droga a deduzir é o anticoncepcional combinado, o tratamento padrão da SOP para ciclo e acne. O etinilestradiol aumenta a globulina ligadora de cortisol, e os ensaios séricos medem o cortisol total, que fica alto mesmo com supressão adequada: o teste dá falso positivo em até metade das usuárias. Como ela não quer suspender o anticoncepcional (seriam seis semanas sem ele para o teste valer), o rastreio deve usar o cortisol livre, que a globulina não afeta: cortisol salivar ao final da noite (ou cortisol livre urinário de 24 horas). ACTH e imagem vêm só depois do hipercortisolismo confirmado.

A) Cortisol após 1 mg de dexametasona ARMADILHA
Errada. Seria o teste de escolha sem estrogênio oral; com anticoncepcional combinado, o cortisol total sobe e o resultado é falso positivo.

B) ACTH plasmático pela manhã
Errada. ACTH define a etiologia depois de confirmado o hipercortisolismo; não rastreia.

C) Cortisol salivar ao final da noite CORRETA
Correta. Cortisol salivar noturno mede o cortisol livre e não é afetado pelo aumento da globulina ligadora causado pelo estrogênio.

D) Ressonância magnética de sela
Errada. Imagem antes da confirmação bioquímica e da dosagem de ACTH acha incidentaloma em até 10% da população.

Para levar. Em uso de estrogênio oral, não rastreie Cushing pelo cortisol sérico (dexametasona): use cortisol salivar noturno ou urinário, ou suspenda o estrogênio por seis semanas.

Endocrine Society, Diagnosis of Cushing's Syndrome 2008; Pituitary Society consensus on Cushing's disease (Lancet Diabetes Endocrinol 2021).

32

Reumatologia · Mialgia e CK alta em usuária antiga de estatina com LDL que subiu: TSH antes do anti-HMGCR

Dado omitido **Gabarito B**

Mulher de 66 anos, com infarto do miocárdio há 6 anos, usa atorvastatina 40 mg/dia desde então, sempre bem tolerada, além de AAS, metoprolol e enalapril. Há 3 meses refere dor e cãibras em coxas e panturrilhas, cansaço, dificuldade para levantar da cadeira e ganho de 5 kg. Nega medicação nova, e a filha confirma que ela toma a estatina regularmente. Exame físico: PA 148 × 92 mmHg, FC 56 bpm, força grau 4 em flexores do quadril, reflexos aquileus com fase de relaxamento lentificada, sem lesões cutâneas. Exames: CK 1.380 U/L (VR até 170), creatinina 1,2 mg/dL (1,0 há 1 ano), sódio 133 mEq/L, AST 64 U/L, ALT 38 U/L, LDL 162 mg/dL (68 mg/dL há 1 ano). Antes de decidir sobre a estatina, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

LDL 162 mg/dL (68 mg/dL há 1 ano)

Resolução. Dor muscular, fraqueza proximal e CK oito vezes acima do limite num usuário de estatina parecem miopatia pela estatina, e o anti-HMGCR parece o passo seguinte. Mas a estatina é usada há 6 anos sem sintomas, nenhuma droga nova entrou, e o LDL subiu de 68 para 162 com adesão confirmada: algo mudou no metabolismo, não na droga. Hipotireoidismo eleva o LDL (menos receptores hepáticos), eleva a CK, causa miopatia proximal com cãibras e é o principal fator de risco tratável para toxicidade muscular da estatina; bradicardia, hipertensão diastólica, ganho de peso, hiponatremia leve, creatinina em ascensão e relaxamento lento do reflexo aquileu completam o quadro. TSH e T4 livre vêm antes de qualquer anticorpo ou biópsia, e as recomendações sobre sintomas musculares associados à estatina incluem o TSH na avaliação. Confirmado o hipotireoidismo, trata-se com levotiroxina, e a CK e o LDL tendem a normalizar; a estatina pode ser suspensa enquanto a CK estiver muito alta e retomada depois.

A) Anticorpo anti-HMGCR ARMADILHA
Errada. Seria o exame com fraqueza e CK que progridem apesar da suspensão da estatina; aqui a causa a afastar primeiro é a que explica também a subida do LDL.

B) TSH e T4 livre CORRETA
Correta. LDL que sobe com adesão, CK alta, bradicardia e relaxamento lento do reflexo aquileu apontam hipotireoidismo, que se confirma com TSH e T4 livre.

C) Biópsia muscular
Errada. A biópsia fica para miopatia sem causa após a avaliação inicial ou com suspeita de miopatia inflamatória; é o exame do degrau seguinte.

D) Eletroneuromiografia
Errada. Mostraria padrão miopático inespecífico e não identifica a causa; não muda a conduta neste momento.

Para levar. Dor muscular com CK alta em usuário antigo de estatina, sobretudo com LDL subindo sem quebra de adesão, pede TSH antes de culpar a estatina ou pedir anti-HMGCR.

EAS Consensus Panel 2015 statement on statin-associated muscle symptoms; ESC/EAS 2019 Guidelines for the management of dyslipidaemias; ATA 2014 Guidelines for the treatment of hypothyroidism.

---

33 Hepatologia · HDA varicosa em Child-Pugh C: TIPS preemptivo nas primeiras 72 horas

Limiar **Gabarito B**

Homem de 54 anos com cirrose por álcool foi admitido há 20 horas por hematêmese volumosa. Na admissão: PA 86 × 50 mmHg, FC 124 bpm, hemoglobina 6,8 g/dL. Recebeu concentrado de hemácias com alvo de hemoglobina entre 7 e 8 g/dL, terlipressina e ceftriaxona; a endoscopia em 6 horas mostrou varizes esofágicas de grosso calibre com sangramento ativo em jato, tratadas com ligadura elástica com sucesso. Hoje está estável, sem novo sangramento, PA 112 × 70 mmHg. Classificação de Child-Pugh: 11 pontos (bilirrubina 3,4 mg/dL, albumina 2,6 g/dL, INR 1,9, ascite leve, sem encefalopatia); creatinina 1,0 mg/dL; ecocardiograma sem disfunção ventricular nem hipertensão pulmonar. Além de manter terlipressina e ceftriaxona, a conduta que reduz a mortalidade é:

O DADO QUE DECIDE

Classificação de Child-Pugh: 11 pontos

Resolução. Controlado o sangramento, a conduta habitual é profilaxia secundária com betabloqueador e ligaduras seriadas, e é o que o apressado escolhe. Mas Child-Pugh de 11 pontos coloca o doente no grupo de

alto risco de ressangramento e morte (Child C de 10 a 13 pontos, ou Child B acima de 7 com sangramento ativo na endoscopia), em que o TIPS preemptivo, colocado em até 72 horas e idealmente em 24, reduz a mortalidade em 1 ano. Ele preenche os dois critérios: Child C 11 e sangramento em jato. Não há contraindicação: ecocardiograma sem disfunção nem hipertensão pulmonar e sem encefalopatia. Balão é ponte para sangramento refratário, e escleroterapia é inferior à ligadura.

A) Propranolol e nova ligadura em 2 semanas ARMADILHA
Errada. É a isca: betabloqueador com ligadura é a profilaxia secundária de quem não é de alto risco; com Child C 11, perde para o TIPS preemptivo em sobrevida.

B) TIPS preemptivo nas primeiras 72 horas CORRETA
Correta. Child-Pugh C de 11 pontos com sangramento ativo na endoscopia: TIPS preemptivo em até 72 horas.

C) Balão de Sengstaken-Blakemore profilático
Errada. Balão de Sengstaken-Blakemore é ponte de até 24 horas no sangramento refratário; o sangramento está controlado.

D) Escleroterapia complementar das varizes
Errada. Escleroterapia é inferior à ligadura em eficácia e complicações e não muda a sobrevida do grupo de alto risco.

Para levar. HDA varicosa controlada em Child C de 10 a 13 pontos, ou Child B com sangramento ativo: TIPS preemptivo em até 72 horas.

Baveno VII (2022); AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis (2024); García-Pagán et al., N Engl J Med (2010)

---

34 Emergência · Hipotensão logo após intubar o DPOC exacerbado: hiperinsuflação dinâmica, desconectar antes de puncionar

Negativo no meio | Gabarito B

Homem de 68 anos, com DPOC grave (VEF1 de 32% do previsto), foi intubado há 15 minutos por exacerbação com falha da ventilação não invasiva (pH 7,18 e sonolência progressiva). Depois da intubação, foi ventilado com bolsa-válvula de forma vigorosa por alguns minutos e conectado ao ventilador em volume controlado: volume corrente 550 mL, frequência 24 irpm, fluxo inspiratório 40 L/min, PEEP 5 cmH2O, FiO2 60%. Agora a PA caiu de 138 × 82 para 72 × 40 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 90%. Pressão de pico 48 cmH2O e de platô 33 cmH2O. Murmúrio vesicular diminuído e simétrico, traqueia centrada, sem enfisema subcutâneo. Na tela do ventilador, a curva de fluxo expiratório não retorna à linha de base antes do ciclo seguinte. A conduta imediata mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Murmúrio vesicular diminuído e simétrico, traqueia centrada, sem enfisema subcutâneo

Resolução. Hipotensão grave logo após intubar um DPOC, com pressões altas no ventilador, faz pensar em pneumotórax hipertensivo, e a punção de alívio é o reflexo. Mas o exame no meio do caso nega o pneumotórax: murmúrio diminuído porém simétrico, traqueia centrada, sem enfisema subcutâneo. O que explica tudo é a hiperinsuflação dinâmica (auto-PEEP): ventilação vigorosa com bolsa e depois volume corrente alto com frequência de 24 irpm não deixam tempo expiratório a um pulmão com obstrução grave, e a curva de fluxo que não volta a zero antes do ciclo seguinte é a prova. O ar aprisionado eleva a pressão

intratorácica, reduz o retorno venoso e derruba a PA. A conduta imediata é desconectar o tubo do ventilador por 30 a 60 segundos: a PA sobe em segundos, o que confirma o diagnóstico; depois, reprogramar com frequência e volume menores e fluxo inspiratório maior para alongar a expiração, aceitando hipercapnia. Aumentar a frequência piora o aprisionamento, e somar PEEP externa no paciente passivo e hipotenso aumenta a pressão intratorácica.

A) Punção de alívio no segundo espaço intercostal ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta no pneumotórax hipertensivo, com murmúrio abolido de um lado, desvio da traqueia ou enfisema subcutâneo; aqui o murmúrio é simétrico e a traqueia está centrada.

B) Desconexão breve do ventilador CORRETA
Correta. Hipotensão com curva de fluxo expiratório que não zera e sem sinais de pneumotórax: desconectar libera o ar aprisionado, restaura o retorno venoso e confirma a hiperinsuflação dinâmica.

C) Aumento da frequência respiratória
Errada. Encurta o tempo expiratório e agrava o aprisionamento; seria o ajuste para acidose respiratória em pulmão sem obstrução ao fluxo e sem auto-PEEP.

D) Aumento da PEEP externa
Errada. PEEP externa ajuda o DPOC em ventilação assistida a disparar o ventilador; no paciente passivo e hipotenso, aumenta a pressão intratorácica sem esvaziar o ar aprisionado.

Para levar. Hipotensão logo após intubar asmático ou DPOC, com curva de fluxo expiratório que não zera e sem sinais de pneumotórax, é auto-PEEP: desconecte do ventilador primeiro e depois reprograme com menos frequência e menos volume.

Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (AMIB/SBPT 2013); GOLD 2025 (manejo da exacerbação).

---

35 Hematologia · Gamopatia monoclonal de significado indeterminado de baixo risco: sem medula e sem imagem

Omissão **Gabarito B**

Homem de 66 anos, hipertenso, fez eletroforese de proteínas solicitada por "proteínas totais um pouco altas" num check-up. Está assintomático, sem dor óssea, neuropatia, edema ou infecções de repetição. Exames: pico monoclonal de 0,8 g/dL na fração gama, imunofixação IgG kappa, razão de cadeias leves livres kappa/lambda de 1,4 (VR 0,26 a 1,65), Hb 14,2 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, cálcio 9,4 mg/dL, albumina 4,2 g/dL e proteinúria ausente. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

razão de cadeias leves livres kappa/lambda de 1,4

Resolução. Diante de pico monoclonal, o reflexo é estadiar como mieloma, com medula e imagem. A GMSI, porém, se estratifica antes, e os três critérios de baixo risco estão presentes: proteína M abaixo de 1,5 g/dL, isotipo IgG e razão de cadeias leves livres normal (1,4). Nesse grupo o risco de progressão é de cerca de 2% em 20 anos, e, sem anemia, hipercalcemia, lesão renal ou dor óssea, a medula e a imagem não mudam a conduta. O seguimento é repetir eletroforese, hemograma, cálcio e creatinina em 6 meses e, se estável, a cada 2 a 3 anos ou quando surgir sintoma. Biópsia de gordura se faz quando há sinal de amiloidose (proteinúria, neuropatia, insuficiência cardíaca), ausente aqui.

A) Biópsia de gordura abdominal
Errada. Seria o passo diante de sinal de amiloidose AL, como proteinúria ou neuropatia, que ele não tem.

B) Eletroforese e hemograma em 6 meses CORRETA
Correta. GMSI de baixo risco (IgG, pico de 0,8, razão normal) sem CRAB: só reavaliação clínica e laboratorial em 6 meses.

C) Tomografia de corpo inteiro de baixa dose
Errada. A imagem de corpo inteiro entra quando há suspeita de mieloma ou GMSI de maior risco; não se faz na GMSI de baixo risco assintomática.

D) Mielograma e biópsia de medula ARMADILHA
Errada. É a armadilha: medula se indica na GMSI de risco intermediário ou alto (IgA ou IgM, pico de 1,5 g/dL ou mais, razão alterada) ou com CRAB; aqui não.

Para levar. GMSI de baixo risco (IgG, pico abaixo de 1,5 g/dL, razão de cadeias leves normal) sem CRAB dispensa medula e imagem: reavalia em 6 meses e depois a cada 2 a 3 anos.

IMWG 2010 consensus on MGUS monitoring; IMWG 2014 diagnostic criteria; NCCN Multiple Myeloma 2025.

---

36 Infectologia · Sarcoma de Kaposi pulmonar x pneumocistose na aids avançada

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 34 anos, com HIV e abandono da TARV há 2 anos, CD4 38 células/mm³, procura atendimento por dispneia progressiva há 6 semanas, tosse com escarro raiado de sangue e dor torácica. Está afebril desde o início do quadro e nega sudorese noturna. Exame: T 36,7 °C, FR 26 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, lesão violácea plana em palato duro, duas máculas violáceas em coxa direita e linfedema de membros inferiores. TC de tórax: opacidades nodulares mal definidas e espessamento peribroncovascular de distribuição peri-hilar, com derrame pleural bilateral. LDH 210 U/L (VR até 250), beta-D-glucana negativa. Toracocentese: líquido serossanguinolento, exsudato, ADA 12 U/L, citologia sem células neoplásicas. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
Está afebril desde o início do quadro

Resolução. CD4 de 38, dispneia progressiva de semanas e hipoxemia montam pneumocistose, a oportunista pulmonar mais lembrada. Os negativos do meio do caso a derrubam: afebril desde o início, LDH normal e beta-D-glucana negativa, e a pneumocistose não faz derrame pleural nem hemoptoicos. Somam-se o padrão peribroncovascular e nodular peri-hilar, o derrame serossanguinolento, as lesões violáceas em palato e pele e o linfedema: sarcoma de Kaposi visceral pulmonar. A broncoscopia, que vem a seguir, costuma confirmar pelo aspecto das placas violáceas na mucosa, sem biópsia, porque ela sangra. ADA de 12 afasta TB pleural, e citologia sem células malignas pesa contra linfoma de efusão. O tratamento é TARV com quimioterapia sistêmica (doxorrubicina lipossomal ou paclitaxel), e corticoide deve ser evitado porque piora o Kaposi.

A) Sarcoma de Kaposi pulmonar CORRETA
Correta. Lesões violáceas em palato e pele, linfedema, padrão peribroncovascular e derrame hemorrágico, sem febre, com LDH normal e beta-D-glucana negativa.

B) Pneumocistose ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a hipótese com febre, LDH alta, beta-D-glucana positiva e vidro fosco difuso sem derrame; os três negativos do caso a afastam.

C) Tuberculose pulmonar e pleural

Errada. TB daria febre e sudorese, e o derrame seria linfocítico com ADA alto; o ADA é de 12.

D) Linfoma primário de efusão

Errada. Linfoma de efusão, também ligado ao HHV-8, mostra células malignas no líquido e não lesões violáceas de pele e mucosa.

Para levar. Na aids, dispneia sem febre, LDH normal, derrame hemorrágico e lesões violáceas é Kaposi pulmonar, não pneumocistose: TARV e quimioterapia, sem corticoide.

NIH/CDC/IDSA Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV, capítulo Human Herpesvirus-8 Disease (2024); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024).

37

Nefrologia · Potomania de cerveja com correção rápida do sódio · desmopressina e glicosado para reabaixar

Cronologia

Gabarito C

Homem de 58 anos, que bebe cerca de 12 latas de cerveja por dia e quase não se alimenta há um mês, é internado às 8 h por confusão leve, sem convulsão. Exames: sódio 108 mEq/L, potássio 3,0 mEq/L, osmolalidade plasmática 228 mOsm/kg, osmolalidade urinária 74 mOsm/kg, sódio urinário menor que 10 mEq/L. Recebeu 100 mL de salina a 3% em bolus, cloreto de potássio intravenoso, tiamina e 500 mL de SF 0,9%, com dieta liberada. Às 16 h está lúcido, o sódio é de 119 mEq/L, a diurese foi de 2.600 mL nas últimas seis horas, com urina clara e osmolalidade urinária de 60 mOsm/kg. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

o sódio é de 119 mEq/L, a diurese foi de 2.600 mL nas últimas seis horas

Resolução. O sódio subindo e o paciente lúcido parecem sucesso, e a reação é parar tudo e observar. Mas a hiponatremia da potomania (cerveja sem soluto, osmolalidade urinária de 74) se corrige sozinha quando chega soluto: com potássio, salina e comida, o rim volta a excretar água livre em grande volume e a correção dispara. O sódio subiu 11 mEq/L em 8 horas, acima do limite de 8 mEq/L em 24 horas de quem tem alto risco de desmielinização osmótica (etilismo, desnutrição, hipocalemia, sódio de partida abaixo de 110), e a diurese aquosa de mais de 400 mL/h vai continuar: suspender fluidos não para a diurese, e o sódio seguirá subindo. A conduta é frear a perda de água livre com desmopressina (2 a 4 µg IV) e repor água com soro glicosado a 5% para reabaixar o sódio até o alvo do dia, com dosagens a cada 1 a 2 horas. A furosemida aumentaria a perda de água livre.

A) Manter conduta e dosar sódio em 4 h

Errada. Manter e só reavaliar em 4 horas permite ultrapassar ainda mais o limite; o sódio já passou do teto de 24 horas em 8 horas.

B) Furosemida e salina isotônica

Errada. A furosemida aumenta a excreção de água livre e a salina eleva o sódio: os dois aceleram a hipercorreção.

C) Desmopressina e soro glicosado a 5% CORRETA

Correta. Correção acima do limite com diurese aquosa em curso pede desmopressina para frear a perda de água e glicosado a 5% para reabaixar o sódio.

D) Suspender fluidos e observar ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Parar a infusão não interrompe a diurese aquosa de 400 mL/h: o rim continua excretando água livre e o sódio continua subindo.

Para levar. Na potomania, o sódio se corrige sozinho quando chega soluto, com diurese aquosa explosiva; se ultrapassar o limite (8 mEq/L em 24 horas no alto risco), desmopressina e glicosado a 5% para reabaixar.

Spasovski et al., Diretriz europeia de hiponatremia (2014); Verbalis et al., Expert Panel Recommendations, Am J Med 2013; Sterns, NEJM 2015 (Disorders of plasma sodium).

38

Cardiologia · Comunicação interatrial no adulto: desdobramento fixo de B2 e eixo do QRS definindo o tipo

Negativo no meio

Gabarito D

Mulher de 36 anos procura atendimento por palpitações e cansaço aos esforços há 1 ano. Desde a infância tem um sopro que o pediatra considerou inocente. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 92 bpm irregular, impulsão sistólica paraesternal esquerda, sopro sistólico ejetivo suave no foco pulmonar, sem clique de ejeção, desdobramento amplo da B2 que não se altera entre inspiração e expiração, e sopro mesodiastólico suave em borda esternal esquerda baixa. ECG: fibrilação atrial, bloqueio incompleto de ramo direito, eixo do QRS em +110 graus. Radiografia: tronco da artéria pulmonar proeminente e trama vascular pulmonar aumentada. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

desdobramento amplo da B2 que não se altera entre inspiração e expiração

Resolução. Sopro sistólico ejetivo no foco pulmonar com desdobramento amplo de B2 é o que a estenose pulmonar valvar também tem, e é a armadilha para quem não fixou a diferença. Os negativos e o detalhe decidem: na estenose pulmonar o desdobramento é amplo mas varia com a respiração, há clique de ejeção e a trama pulmonar é reduzida; aqui o desdobramento não varia (fixo), não há clique e a trama está aumentada. Desdobramento fixo é da comunicação interatrial: o shunt equaliza as variações respiratórias de enchimento dos dois lados. O sopro ejetivo é de hiperfluxo pulmonar, o mesodiastólico baixo é de hiperfluxo tricúspide, e a fibrilação atrial no adulto vem da sobrecarga atrial. Com eixo para a direita, o tipo é ostium secundum; ostium primum dá eixo para a esquerda e costuma ter insuficiência mitral por fenda.

A) CIA tipo ostium primum

Errada. O ostium primum também tem desdobramento fixo, mas cursa com eixo desviado para a esquerda e, em geral, sopro de insuficiência mitral pela fenda.

B) Comunicação interventricular

Errada. A comunicação interventricular dá sopro holossistólico rude em borda esternal esquerda baixa, frequentemente com frêmito, e não desdobramento fixo.

C) Estenose pulmonar valvar ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Na estenose pulmonar o desdobramento amplo varia com a respiração, há clique de ejeção e a trama pulmonar é reduzida.

D) CIA tipo ostium secundum CORRETA

Correta. Desdobramento fixo, ejetivo pulmonar de hiperfluxo, ruflar tricúspide, BRD incompleto com eixo à direita e FA na quarta década: CIA ostium secundum.

Para levar. Desdobramento amplo e fixo de B2 é CIA; amplo e variável é bloqueio de ramo direito ou estenose pulmonar. Na CIA, eixo à direita é ostium secundum; eixo à esquerda é ostium primum (com fenda mitral).

ESC 2020 (adult congenital heart disease); AHA/ACC 2018 (adult congenital heart disease); Braunwald's Heart Disease, 12ª ed.

---

39 Gastroenterologia · Atrofia vilositária soronegativa com HLA negativo: enteropatia por olmesartana

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 68 anos, hipertenso, usa olmesartana 40 mg/dia e anlodipino há 4 anos. Há 7 meses tem 6 a 8 evacuações aquosas por dia, perda de 14 kg e duas internações por desidratação com lesão renal aguda pré-renal. Exame: PA 108 × 66 mmHg, sem edema. Exames: albumina 2,9 g/dL, ferritina 18 ng/mL, anti-transglutaminase IgA e antiendomísio negativos com IgA total normal, calprotectina fecal 60 µg/g, coproparasitológico e pesquisa de Giardia negativos. Endoscopia com biópsias duodenais: atrofia vilositária total, aumento de linfócitos intraepiteliais e espessamento do colágeno subepitelial. HLA-DQ2 e DQ8 ausentes. A causa mais provável da enteropatia é:

O DADO QUE DECIDE

HLA-DQ2 e DQ8 ausentes

Resolução. Atrofia vilositária com linfocitose intraepitelial é a histologia da doença celíaca, e o rótulo leva à dieta sem glúten. Mas a sorologia é negativa com IgA total normal e HLA-DQ2 e DQ8 estão ausentes, o que praticamente exclui celíaca (o valor preditivo negativo do HLA se aproxima de 100%). Em atrofia soronegativa, a primeira causa a procurar é medicamento, e a olmesartana dá exatamente este quadro: diarreia grave com perda de peso e desidratação, meses a anos após o início, às vezes com colágeno subepitelial espesso. O diagnóstico se confirma pela melhora clínica e histológica após a suspensão. Linfoma e enteropatia autoimune ficam para quem não melhora.

A) Enteropatia autoimune

Errada. Enteropatia autoimune exige anticorpo antienterócito e falha após retirar causas tratáveis; a droga ainda nem foi suspensa.

B) Linfoma intestinal de células T

Errada. Linfoma de células T associado a enteropatia complica celíaca refratária de longa data; não é a primeira hipótese com droga causal em uso.

C) Doença celíaca soronegativa ARMADILHA

Errada. É a isca: celíaca soronegativa existe, mas HLA-DQ2 e DQ8 ausentes praticamente a excluem.

D) Enteropatia por olmesartana CORRETA

Correta. Atrofia vilositária soronegativa, HLA negativo e olmesartana há 4 anos: enteropatia induzida, que melhora com a suspensão.

Para levar. Atrofia vilositária com sorologia e HLA negativos: procure droga (olmesartana, micofenolato, imunoterapia) antes de rotular celíaca.

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Celiac Disease (2023); Rubio-Tapia et al., Severe spruelike enteropathy associated with olmesartan (Mayo Clin Proc, 2012)

40

Reumatologia · Granulomatose eosinofílica com poliangeíte ANCA negativa imitando aspergilose broncopulmonar alérgica

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 44 anos tem asma iniciada aos 38 anos, de difícil controle, e rinossinusite crônica com pólipos nasais. Usa budesonida-formoterol e montelucaste e, nos últimos 6 meses, fez 3 ciclos de prednisona por crises. Há 3 semanas teve queda do pé direito e, há 5 dias, dificuldade para estender o punho esquerdo, com dor em queimação nos dois territórios. Exame físico: sibilos difusos, lesões purpúricas palpáveis em pernas, fraqueza da dorsiflexão do pé direito e da extensão do punho esquerdo, com hipoestesia nos territórios correspondentes. Exames: leucócitos 14.200/mm³ com 31% de eosinófilos, IgE total 1.400 UI/mL, IgE específica para Aspergillus fumigatus reagente, p-ANCA e c-ANCA não reagentes, creatinina 0,9 mg/dL, EAS normal, troponina normal. TC de tórax: opacidades em vidro fosco periféricas e migratórias, sem bronquiectasias centrais. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Há 3 semanas teve queda do pé direito e, há 5 dias, dificuldade para estender o punho esquerdo

Resolução. Asma de difícil controle, eosinofilia, IgE total alta, IgE para Aspergillus reagente e infiltrados pulmonares formam o quadro de aspergilose broncopulmonar alérgica, e o ANCA negativo parece confirmar que não é vasculite. Mas a aspergilose não sai do pulmão, e aqui há mononeurite múltipla (fibular direito e radial esquerdo em semanas, com dor) e púrpura palpável: há vasculite de pequenos vasos. Nos critérios ACR/EULAR 2022, doença obstrutiva de vias aéreas (3 pontos), pólipos nasais (3), eosinófilos acima de 1.000/mm³ (5; aqui são cerca de 4.400) e mononeurite múltipla (1) somam 12, muito acima dos 6 necessários para granulomatose eosinofílica com poliangeíte. O ANCA é negativo em cerca de 60% dos casos, sobretudo nos com cardiopatia e infiltrados pulmonares, e não exclui a doença. A IgE para Aspergillus é sensibilização comum na asma grave, e faltam bronquiectasias centrais. Os ciclos de corticoide e o montelucaste podem ter retardado o aparecimento da vasculite.

A) Síndrome hipereosinofílica idiopática

Errada. A síndrome hipereosinofílica pode lesar nervos e coração, mas não cursa com asma e pólipos, nem com vasculite de pequenos vasos com púrpura palpável.

B) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte CORRETA

Correta. Asma tardia, pólipos, eosinofilia de 31%, infiltrados migratórios, mononeurite múltipla e púrpura; ANCA negativo não exclui.

C) Aspergilose broncopulmonar alérgica ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com bronquiectasias centrais, IgE acima de 1.000 com precipitinas e sem doença extrapulmonar; não explica mononeurite nem púrpura.

D) Pneumonia eosinofílica crônica
Errada. A pneumonia eosinofílica crônica tem infiltrados periféricos e asma, mas é restrita ao pulmão; mononeurite múltipla indica vasculite.

Para levar. Asma com eosinofilia que ganha mononeurite múltipla ou púrpura é granulomatose eosinofílica com poliangeíte, mesmo com ANCA negativo, que é a regra em mais da metade.

ACR/EULAR 2022 classification criteria for EGPA; EULAR 2022 recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis.

---

41 Endocrinologia · Insuficiência adrenal primária com febre: regra do dia doente

Grade X / Y **Gabarito B**

Mulher de 38 anos, com insuficiência adrenal primária autoimune há cinco anos, usa hidrocortisona 10 mg ao acordar e 5 mg às 14 horas e fludrocortisona 0,1 mg/dia, com PA e potássio controlados. Há um dia tem febre de 38,6 °C, mialgia, coriza e tosse seca, em período de circulação de influenza. Alimenta-se e hidrata-se normalmente, sem vômitos ou diarreia. Exame: PA 118/74 mmHg sem variação postural, FC 96 bpm, sem desidratação. Quanto à hidrocortisona e à fludrocortisona, a conduta é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Alimenta-se e hidrata-se normalmente, sem vômitos ou diarreia

Resolução. Febre em paciente com Addison chama a dose de emergência, e o apressado vai à hidrocortisona parenteral. O que define o degrau é a via oral funcionando: ela come, bebe e não vomita, está estável e sem hipotensão postural. A regra do dia doente manda dobrar (com febre acima de 38,5 °C, alguns triplicam) a hidrocortisona oral enquanto durar a febre, e reservar 100 mg intramuscular ou venosa para vômitos, diarreia, incapacidade de ingerir ou instabilidade. A fludrocortisona não se altera, porque a demanda aumentada no estresse é de glicocorticoide e porque doses maiores de hidrocortisona já têm efeito mineralocorticoide; dobrá-la seria tratar o eixo errado.

A) Manter a dose / manter a dose
Errada. A fludrocortisona está certa, mas manter a hidrocortisona na febre é o que precipita a crise adrenal.

B) Dobrar a dose / manter a dose CORRETA
Correta. Febre com via oral preservada: dobrar a hidrocortisona e manter a fludrocortisona.

C) Dobrar a dose / dobrar a dose
Errada. A hidrocortisona está certa, mas a demanda que sobe no estresse é de glicocorticoide; dobrar a fludrocortisona trata o eixo errado e só acrescenta retenção de sódio e hipocalemia.

D) 100 mg intramuscular / manter a dose ARMADILHA
Errada. Seria a conduta com vômitos, diarreia, incapacidade de ingerir ou instabilidade hemodinâmica; com via oral preservada e sem hipotensão postural, a dose oral dobrada basta.

Para levar. Addison com febre e via oral preservada: dobre a hidrocortisona, mantenha a fludrocortisona; parenteral (100 mg) só com vômitos, diarreia ou instabilidade.

Endocrine Society, Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency 2016; Society for Endocrinology Adrenal Crisis guidance 2020.

---

42 Neurologia · Enoxaparina profilática não contraindica trombólise no AVC intra-hospitalar

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 71 anos, internada há 4 dias por erisipela em membro inferior, recebe cefazolina e enoxaparina 40 mg SC uma vez ao dia, com a última dose há 6 horas. Às 10 h, a enfermeira a encontra com hemiparesia esquerda, hipoestesia esquerda e disartria; estava conversando normalmente às 9h20. NIHSS 9. PA 172/94 mmHg, glicemia 148 mg/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 1,0 e TTPa normal. TC de crânio sem contraste: sem hemorragia, ASPECTS 9. Angiotomografia: sem oclusão de grande vaso; carótidas sem estenose. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

enoxaparina 40 mg SC uma vez ao dia

Resolução. Heparina de baixo peso molecular nas últimas 24 horas contraindica trombólise, e o apressado para aí. O que a diretriz contraindica é a HBPM em dose terapêutica (1 mg/kg de 12/12 h ou 1,5 mg/kg/dia), não a dose profilática de 40 mg ao dia, que não aumenta de forma relevante o risco de hemorragia e com a qual se trombolisa. A paciente está a 40 minutos do último momento bem, com déficit incapacitante (NIHSS 9, com hemiparesia), PA abaixo de 185/110, plaquetas e coagulação normais e TC sem sangue: tem indicação de trombólise IV, e tenecteplase 0,25 mg/kg é alternativa à alteplase. Sem oclusão de grande vaso, não há alvo para trombectomia. Dosar anti-Xa atrasa a reperfusão sem mudar a decisão, porque a dose profilática já é conhecida.

A) Trombectomia mecânica isolada
Errada. Trombectomia exige oclusão de grande vaso na angiotomografia, ausente aqui.

B) AAS 300 mg, sem trombólise ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta se ela usasse enoxaparina em dose terapêutica nas últimas 24 horas; 40 mg ao dia é profilaxia.

C) Dosar anti-Xa antes de decidir
Errada. Anti-Xa não tem ponto de corte validado para liberar trombólise e atrasa o tratamento; a dose profilática não exige o exame.

D) Trombólise IV com tenecteplase CORRETA
Correta. AVC incapacitante a 40 minutos do início, sem contraindicação: enoxaparina em dose profilática não impede a trombólise.

Para levar. Contraindica trombólise a HBPM em dose plena nas últimas 24 horas; dose profilática não contraindica.

AHA/ASA 2019 e 2026 (AVC isquêmico agudo); ESO 2021 (trombólise IV).

---

43 Pneumologia · Hemorragia alveolar sem hemoptise na vasculite ANCA: a DLCO que sobe

Dado omitido **Gabarito A**

Mulher de 44 anos, com granulomatose com poliangiite em remissão há 1 ano, em manutenção com rituximabe semestral, procura o ambulatório por dispneia progressiva e cansaço há 5 dias. Nega hemoptise, febre, escarro purulento e dor torácica. Exame: T 36,9 °C, FR 24 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, PA 128 × 80 mmHg, estertores finos bilaterais, sem edema. Hemoglobina 8,4 g/dL (há 1 mês, 12,1), leucócitos 7.800/mm³, PCR 3,2 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 sem hematúria, procalcitonina 0,08 ng/mL. TC: vidro fosco bilateral difuso, sem consolidação lobar. Ecocardiograma normal. DLCO 132% do previsto (há 6 meses, 88%). O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

DLCO 132% do previsto (há 6 meses, 88%)

Resolução. Rituximabe, vidro fosco difuso e hipoxemia sem febre compõem o quadro da pneumocistose, que é um risco real. O dado esperado da hemorragia alveolar, a hemoptise, foi omitido de propósito: falta em até um terço dos casos. O que decide são dois números. A hemoglobina caiu 3,7 g/dL em um mês sem sangramento visível, e a DLCO subiu de 88% para 132%: a hemoglobina dentro dos alvéolos capta monóxido de carbono e eleva a difusão. Infecções e pneumonites reduzem a DLCO, porque espessam a membrana e reduzem a área de troca. A confirmação é o lavado broncoalveolar com alíquotas progressivamente mais hemorrágicas e macrófagos com hemossiderina, que também exclui infecção. É recidiva da vasculite com capilarite pulmonar.

A) Hemorragia alveolar difusa CORRETA
Correta. Queda de 3,7 g/dL na hemoglobina e DLCO de 132% (era 88%) com vidro fosco difuso: hemorragia alveolar, mesmo sem hemoptise.

B) Pneumonite por rituximabe
Errada. Pneumonite por droga é rara com rituximabe, cursa com DLCO reduzida e não explica a anemia.

C) Pneumonia bacteriana bilateral
Errada. Pneumonia bilateral daria febre, consolidação, PCR e procalcitonina mais altas, e DLCO reduzida.

D) Pneumonia por Pneumocystis ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Pneumocistose em quem usa rituximabe é plausível, mas reduz a DLCO e não explica a queda de hemoglobina.

Para levar. DLCO acima do previsto (ou em alta) com anemia que cai e infiltrado difuso é hemorragia alveolar, mesmo sem hemoptise; infecção e pneumonite reduzem a DLCO.

ERS/ATS 2017 (padronização da DLCO); ERS/ATS 2022 (interpretação de testes de função pulmonar); ACR/VF 2021 (vasculites ANCA); EULAR 2022 (vasculites ANCA)

44 Infectologia · Endocardite com hemoculturas negativas em bioprótese: febre Q apesar do antibiótico prévio

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 58 anos, portador de bioprótese aórtica há 4 anos, trabalha em uma criação de cabras e ajuda nos partos dos animais. Há 3 meses tem febre baixa intermitente, sudorese noturna, astenia e perda de 6 kg. Há 5 semanas recebeu amoxicilina por 7 dias para sinusite, sem melhora. Exame: T 37,9 °C, sopro diastólico aspirativo novo em foco aórtico, hepatoesplenomegalia discreta, baqueteamento digital, sem lesões cutâneas. Hb 10,8 g/dL, plaquetas 110.000/mm³, VHS 88 mm, ALT 72 U/L, fator reumatoide positivo, hematúria microscópica. Seis pares de hemoculturas, colhidos em 3 dias sem antibiótico e incubados por 14 dias, são negativos. Ecocardiograma transesofágico: espessamento e vegetação de 4 mm na bioprótese, com regurgitação moderada. O exame que deve ser solicitado a seguir é:

O DADO QUE DECIDE

ajuda nos partos dos animais

Resolução. A amoxicilina de 5 semanas atrás é real e é a explicação mais lembrada para hemocultura negativa, o que leva a repetir culturas. Mas já se passaram semanas, e seis pares colhidos sem antibiótico e incubados por 14 dias são negativos: isso é endocardite com hemocultura verdadeiramente negativa, cujo principal agente no mundo é Coxiella burnetii. O dado que manda está na primeira linha: contato com partos de cabras, cuja placenta libera o agente em aerossol. O quadro arrastado com hepatoesplenomegalia, baqueteamento, plaquetopenia, transaminases altas e vegetação pequena em prótese é o da febre Q crônica. A sorologia para Coxiella (IgG de fase I de 1:800 ou mais) é critério maior no Duke-ISCVID 2023. O tratamento é doxiciclina com hidroxicloroquina por pelo menos 18 meses, e a troca da prótese é frequente. O PET-CT ajuda a documentar infecção de prótese, mas não identifica o agente, que é o que falta.

A) Novas hemoculturas sem antibiótico ARMADILHA
Errada. É a armadilha: repetir culturas faria sentido logo após o antibiótico; seis pares negativos, colhidos semanas depois e incubados por 14 dias, apontam agente que não cresce.

B) PET-CT com FDG
Errada. PET-CT seria útil para confirmar endocardite de prótese com eco duvidoso; aqui a vegetação já está vista e falta o agente.

C) Sorologia para Coxiella burnetii CORRETA
Correta. Contato com partos de cabras e endocardite com hemocultura negativa em prótese: sorologia para Coxiella, critério maior no Duke 2023.

D) Fator antinuclear e anti-DNA
Errada. Endocardite de Libman-Sacks entraria com FAN no lúpus; o fator reumatoide positivo aqui é fenômeno imunológico da própria endocardite.

Para levar. Hemocultura negativa persistente sem antibiótico recente, em contato com partos de animais, é Coxiella até prova em contrário: sorologia de fase I, critério maior de Duke 2023.

Duke-ISCVID Criteria for Infective Endocarditis (Clin Infect Dis, 2023); ESC Guidelines for the management of endocarditis (2023).

45 Hematologia · Paracentese no cirrótico com INR alto e plaquetopenia: sem plasma e sem plaquetas profiláticos

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 58 anos, com cirrose por vírus C, Child-Pugh C, é internado por aumento do volume abdominal, desconforto respiratório leve e febre baixa há 2 dias. Exame: T 37,9 °C, ascite volumosa, sem petéquias, sem sangramentos ativos. Exames: Hb 10,2 g/dL, plaquetas 48.000/mm³, INR 2,3, fibrinogênio 160 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. Será feita paracentese diagnóstica e de alívio. Quanto à hemostasia, antes do procedimento, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sem sangramentos ativos

Resolução. INR de 2,3 e plaquetas de 48.000 são números reais e assustadores, e o rótulo puxa para corrigir antes de puncionar. No cirrótico, porém, o INR não mede risco de sangramento: o fígado reduz ao mesmo tempo fatores pró-coagulantes e anticoagulantes (proteína C, antitrombina), e a hemostasia fica reequilibrada. A paracentese é procedimento de baixo risco, com sangramento grave em menos de 1% mesmo com INR alto e plaquetas baixas, e AASLD e AGA recomendam não transfundir plasma ou plaquetas profilaticamente. O plasma piora a hipertensão portal pela sobrecarga de volume e expõe a reações transfusionais, e adiar a punção de um cirrótico febril com ascite atrasa o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. A vitamina K não corrige o INR da insuficiência hepática.

A) Plaquetas até acima de 50.000
Errada. Plaquetas profiláticas não reduzem sangramento na paracentese; o limiar de 50.000 vale para procedimentos de alto risco.

B) Plasma fresco até INR abaixo de 1,5 ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o INR do cirrótico não prevê sangramento, e plasma aumenta a pressão portal sem reduzir complicações.

C) Puncionar sem hemocomponente CORRETA
Correta. Paracentese é de baixo risco, e sem sangramento ativo não se corrige INR nem plaquetas antes dela.

D) Vitamina K e adiar por 24 horas
Errada. A vitamina K não corrige coagulopatia de síntese hepática, e adiar atrasa o diagnóstico de PBE num cirrótico febril.

Para levar. O INR do cirrótico não mede risco de sangramento: paracentese e toracocentese se fazem sem plasma ou plaquetas profiláticos.

AASLD 2021 Practice Guidance on ascites, SBP and hepatorenal syndrome; AGA 2021 Clinical Practice Update on coagulation in cirrhosis.

---

46 Cardiologia · Hipertensão grave assintomática sem lesão aguda de órgão-alvo: urgência tratada por via oral

Negativo no meio **Gabarito A**

Mulher de 57 anos, hipertensa em uso de losartana e hidroclorotiazida, suspendeu os remédios há 10 dias por falta do medicamento e vem à emergência após medir a pressão na farmácia. Está assintomática, sem cefaleia,

dor torácica, dispneia, déficit focal ou alteração visual, mas muito ansiosa. PA 214×124 mmHg confirmada em três medidas após 15 minutos de repouso, FC 84 bpm. Fundo de olho com cruzamentos arteriovenosos patológicos, sem hemorragias, exsudatos ou papiledema. ECG com sobrecarga de VE, sem alterações agudas; creatinina 0,9 mg/dL, urina sem hematúria, troponina normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sem hemorragias, exsudatos ou papiledema

Resolução. O número assusta, e ele tende a tratar o número com a droga venosa: é a armadilha. O que separa emergência de hipertensão grave sem emergência não é o valor, é a lesão aguda de órgão-alvo, e o meio do caso a exclui: sem hemorragias, exsudatos ou papiledema, ECG sem alteração aguda, creatinina, urina e troponina normais, sem sintomas neurológicos. Cruzamentos arteriovenosos e sobrecarga de VE são lesões crônicas. Nesse cenário, reduzir a PA rapidamente não traz benefício e pode causar hipoperfusão; reintroduz-se o tratamento oral (aqui, as drogas que ela suspendeu), com redução gradual em 24 a 48 horas e reavaliação em poucos dias. Sedar a ansiedade e remedir trata o rótulo, não a hipertensão sem tratamento há 10 dias.

A) Reiniciar anti-hipertensivo oral e reavaliar em dias CORRETA
Correta. Sem lesão aguda de órgão-alvo, a conduta é retomar o anti-hipertensivo oral e reduzir a PA em horas a dias, com retorno breve.

B) Nitroprussiato IV com redução de 25% na 1ª hora ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Nitroprussiato com redução de 25% na primeira hora é o tratamento da emergência hipertensiva, que exige lesão aguda; não há nenhuma.

C) Captopril sublingual até PA abaixo de 140×90
Errada. Captopril sublingual não tem absorção sublingual real e a meta de normalizar a PA em horas é perigosa; queda brusca pode causar isquemia.

D) Benzodiazepínico e nova medida em 1 hora
Errada. A ansiedade não explica 214×124 em quem suspendeu os remédios há 10 dias; sedar e remedir adia o tratamento necessário.

Para levar. Emergência hipertensiva é definida pela lesão aguda de órgão-alvo, não pelo número. PA muito alta sem lesão aguda: anti-hipertensivo oral, redução gradual em 24 a 48 h e reavaliação em dias.

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC/SBH/SBN 2020); ESC 2024 (hypertension)

---

47 Nefrologia · Suposta glomerulonefrite pós-estreptocócica com C3 baixo há 14 semanas · biópsia por glomerulopatia C3

Limiar **Gabarito B**

Homem de 27 anos recebeu o diagnóstico de glomerulonefrite após faringite há 14 semanas, com hematúria dismórfica, edema, hipertensão, ASLO elevada, C3 baixo e C4 normal. Foi tratado com restrição de sódio, furosemida e anlodipino. Hoje está sem edema, com PA de 128/82 mmHg. Exames: creatinina 1,3 mg/dL (era 1,4 mg/dL na fase aguda), urina com 40 hemácias por campo, dismórficas, proteinúria de 24 h de 1,6 g (era 1,2 g), C3 42 mg/dL (90 a 180), C4 22 mg/dL (10 a 40), FAN não reagente, anti-HCV negativo, crioglobulinas negativas, eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

C3 42 mg/dL (90 a 180)

Resolução. Depois de aprender que a pós-estreptocócica se acompanha sem biópsia, o reflexo é continuar esperando. Mas a regra tem prazo: o C3 da pós-estreptocócica normaliza em até seis a oito semanas, e aqui, com 14 semanas, segue em 42 mg/dL, com hematúria persistente e proteinúria subindo. C3 baixo persistente com C4 normal é ativação mantida da via alternativa, e a hipótese principal passa a ser glomerulopatia C3 (que pode estrear após uma infecção, imitando a pós-estreptocócica) ou glomerulonefrite membranoproliferativa por imunocomplexo, já afastados lúpus, hepatite C, crioglobulinemia e gamopatia. O diagnóstico só vem pela biópsia, com imunofluorescência (C3 dominante, pouca ou nenhuma imunoglobulina) e microscopia eletrônica, seguida da investigação da via alternativa (fator H, fator nefrítico C3). Esperar mais oito semanas atrasa um diagnóstico que muda o tratamento.

A) Prednisona em dose imunossupressora

Errada. Imunossupressão sem diagnóstico histológico pode ser inútil ou danosa; a glomerulopatia C3 tem tratamento próprio, definido depois da biópsia.

B) Biópsia renal percutânea CORRETA

Correta. C3 baixo além de oito semanas, com hematúria persistente e proteinúria em alta, indica biópsia (suspeita de glomerulopatia C3 ou membranoproliferativa).

C) Repetir C3 em oito semanas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a conduta nas primeiras oito semanas; com 14 semanas de C3 baixo, a pós-estreptocócica autolimitada deixou de ser sustentável.

D) Antibiótico para erradicar estreptococo

Errada. O antibiótico erradica a cepa e protege contactantes na fase aguda, mas não altera o curso renal e não explica o C3 baixo meses depois.

Para levar. Na suposta pós-estreptocócica, C3 baixo além de oito semanas (e com mais razão além de 12) (ou proteinúria crescente, ou perda de função) obriga a biópsia: pense em glomerulopatia C3 ou membranoproliferativa.

KDIGO 2021 (Glomerular Diseases): glomerulonefrite associada a infecção, glomerulopatia C3 e membranoproliferativa; Riella, Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos (2024).

---

48 Gastroenterologia · Suspeita de coledocolitíase de risco intermediário: colangiorressonância antes de CPRE

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 47 anos, obesa, tem cólica biliar há 2 dias, sem febre. Exame: Tax 36,9 °C, FC 86 bpm, anictérica, dor leve em hipocôndrio direito, Murphy negativo. Exames: leucócitos 8.900/mm³, bilirrubina total 2,4 mg/dL, fosfatase alcalina 310 U/L, GGT 420 U/L, ALT 180 U/L, lipase normal. Ultrassonografia: colelitíase múltipla com cálculos pequenos, vesícula de paredes finas, colédoco de 8 mm, sem cálculo visível no colédoco. O serviço não dispõe de colangiografia nem de ultrassonografia intraoperatórias. Antes da colecistectomia, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

bilirrubina total 2,4 mg/dL

Resolução. Colelitíase com colestase e colédoco de 8 mm parece ir direto para CPRE, e o reflexo de fazer o exame terapêutico é a isca. A ASGE estratifica: alto risco (cálculo visto no colédoco, colangite, ou bilirrubina acima de 4 mg/dL com colédoco dilatado) vai à CPRE; risco intermediário (enzimas alteradas, idade acima de 55 anos ou colédoco dilatado, sem critério de alto risco) faz colangiorressonância ou ecoendoscopia, ou colangiografia intraoperatória, indisponível neste serviço. Aqui a bilirrubina é 2,4, sem febre e sem cálculo visto: risco intermediário. A CPRE diagnóstica expõe a pancreatite, sangramento e perfuração quem pode nem ter cálculo, e a TC é pouco sensível para cálculo de colédoco.

A) Colangiorressonância CORRETA
Correta. Colédoco dilatado e bilirrubina de 2,4 mg/dL, sem cálculo visto nem colangite: risco intermediário, colangiorressonância.

B) TC de abdome com contraste
Errada. A TC tem baixa sensibilidade para cálculo de colédoco, sobretudo os pequenos e radiotransparentes.

C) CPRE com papilotomia ARMADILHA
Errada. É a isca: CPRE é para alto risco (cálculo visto, colangite, ou bilirrubina acima de 4 com colédoco dilatado); aqui seria diagnóstica, com risco de complicação.

D) Nenhum, colecistectomia sem exame prévio
Errada. Seria aceitável no baixo risco, com enzimas e colédoco normais, ou no risco intermediário com colangiografia intraoperatória; aqui há colestase, colédoco dilatado e o serviço não tem colangiografia.

Para levar. Suspeita de coledocolitíase: alto risco vai à CPRE; risco intermediário, colangiorressonância ou ecoendoscopia primeiro.

ASGE Guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis (2019); ESGE Guideline: endoscopic management of common bile duct stones (2019)

49

Reumatologia · Osteoartrite de joelho sem tratamento prévio: medidas não farmacológicas e AINE tópico

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 61 anos, com IMC de 33 kg/m², hipertensa, diabética tipo 2 e com doença renal crônica estágio 3b (TFGe 38 mL/min/1,73 m²), refere dor no joelho direito há 1 ano, ao subir escadas e ao final do dia, com rigidez matinal de 10 minutos. Nunca fez tratamento, apenas dipirona eventual. Exame físico: crepitação e osteófitos palpáveis no joelho direito, sem derrame, sem calor, sem instabilidade, marcha preservada. Radiografia: redução do espaço articular medial com osteófitos marginais e esclerose subcondral (Kellgren-Lawrence grau 3). VHS e PCR normais. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
Nunca fez tratamento

Resolução. A radiografia de grau 3 impressiona e empurra para o tratamento definitivo, mas a radiografia não indica cirurgia: a dor e a função mandam, e há dissociação clínico-radiológica na osteoartrite. Paciente que nunca tratou, com marcha preservada, começa pelo que tem mais evidência e menos risco: exercício (fortalecimento de quadríceps e aeróbico), perda de peso (5% ou mais já reduz dor) e AINE tópico, que no joelho tem eficácia próxima à do oral com exposição sistêmica mínima. O AINE oral é arriscado aqui pela

doença renal estágio 3b, e o ácido hialurônico intra-articular não tem recomendação nas diretrizes atuais. Artroplastia fica para dor e limitação refratárias a tratamento clínico adequado.

A) Exercício, perda de peso e AINE tópico CORRETA
Correta. Exercício, perda de peso e AINE tópico são a base da osteoartrite de joelho e o primeiro degrau numa paciente sem tratamento prévio.

B) Viscossuplementação com ácido hialurônico
Errada. A viscossuplementação tem benefício pequeno e não é recomendada pelo ACR; não é degrau inicial.

C) Naproxeno oral contínuo
Errada. AINE oral contínuo seria opção em paciente sem contraindicação após falha do tópico; com TFGe de 38, o risco renal pesa contra.

D) Encaminhar para artroplastia total ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na dor refratária a tratamento clínico completo, com limitação funcional importante; aqui nada foi tentado.

Para levar. Osteoartrite de joelho começa com exercício, perda de peso e AINE tópico, qualquer que seja o grau radiológico; cirurgia é para refratários.

ACR/Arthritis Foundation 2019 Guideline for the Management of Osteoarthritis; OARSI 2019 guidelines for knee OA.

---

50 Endocrinologia · Hiponatremia no oitavo dia após cirurgia hipofisária: segunda fase da resposta trifásica

Cronologia **Gabarito C**

Homem de 45 anos foi submetido a ressecção transesfenoidal de macroadenoma não funcionante. Nos dois primeiros dias pós-operatórios teve diurese de 6 a 7 L/dia, sódio de 148 mEq/L e osmolalidade urinária de 140 mOsm/kg, e recebeu desmopressina; teve alta no quarto dia com desmopressina 0,1 mg por via oral de 12 em 12 horas e hidrocortisona 15 mg/dia. No oitavo dia pós-operatório volta com náuseas, cefaleia e confusão leve. Exame: euvolêmico, PA 124/78 mmHg, FC 76 bpm, sem hipotensão postural. Exames: sódio 121 mEq/L, osmolalidade plasmática 252 mOsm/kg, osmolalidade urinária 610 mOsm/kg, sódio urinário 68 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, glicemia 96 mg/dL. A causa mais provável da hiponatremia é:

O DADO QUE DECIDE

No oitavo dia pós-operatório

Resolução. Hiponatremia com sódio urinário alto depois de neurocirurgia evoca perda cerebral de sal, mas ela exige hipovolemia, e o paciente está euvolêmico, sem hipotensão postural. A cronologia explica: lesão da haste ou da neuro-hipófise produz a resposta trifásica, com diabetes insípido nos primeiros dias, depois, por volta do quinto ao décimo dia, liberação descontrolada do ADH estocado nos axônios que degeneram (fase de antidiurese inapropriada) e, por fim, diabetes insípido permanente ou recuperação. A desmopressina mantida na alta soma-se ao ADH liberado e agrava a hiponatremia. A conduta é suspender a desmopressina e restringir água, com salina hipertônica se houver sintomas graves, vigiando a volta da poliúria. Hidrocortisona de 15 mg/dia é reposição adequada e osmolalidade urinária de 610 afasta polidipsia.

A) Deficiência de cortisol
Errada. Seria considerada sem reposição ou com dose insuficiente de glicocorticoide; com 15 mg/dia de hidrocortisona e sem hipotensão, não explica.

B) Perda cerebral de sal ARMADILHA
Errada. Seria a causa com hipovolemia, hipotensão postural e balanço negativo; o paciente está euvolêmico.

C) Secreção inapropriada de ADH CORRETA
Correta. No quinto ao décimo dia após lesão da neuro-hipófise, o ADH estocado é liberado (segunda fase da resposta trifásica), e a desmopressina mantida agrava.

D) Polidipsia primária
Errada. Polidipsia dilui a urina; osmolalidade urinária de 610 mOsm/kg indica ADH ativo.

Para levar. Após cirurgia hipofisária, diabetes insípido nos primeiros dias pode virar antidiurese inapropriada do quinto ao décimo dia: suspenda a desmopressina e restrinja água.

Endocrine Society, Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults 2016; European Clinical Practice Guideline on Diagnosis and Treatment of Hyponatraemia (Spasovski et al., 2014).

---

51 Neurologia · Encefalite anti-receptor NMDA após encefalite herpética tratada: coreoatetose com PCR negativa

Cronologia **Gabarito A**

Mulher de 29 anos teve encefalite herpética confirmada por PCR no líquor, tratada com aciclovir IV por 21 dias, com boa recuperação e alta há 3 semanas. Retorna trazida pela mãe por insônia, agitação, frases desconexas e movimentos involuntários da boca e dos membros há 6 dias, sem febre. Exame: Tax 36,9 °C, FC oscilando entre 58 e 128 bpm, discinesias orofaciais e coreoatetose em membros superiores, sem rigidez de nuca. RM de encéfalo: sequela temporal esquerda, sem lesão nova ou realce. Líquor: 18 células/mm³ (linfócitos), proteína 52 mg/dL, glicose normal, PCR para herpes simples negativa. EEG: atividade lenta difusa. A etiologia mais provável do quadro atual é:

O DADO QUE DECIDE
discinesias orofaciais e coreoatetose em membros superiores

Resolução. Piora neurológica semanas após encefalite herpética puxa para recidiva viral e novo ciclo de aciclovir. Mas em cerca de um quarto dos pacientes, de 2 a 6 semanas após a encefalite herpética, surge encefalite autoimune, quase sempre anti-receptor NMDA, desencadeada pela exposição de antígenos neuronais na destruição viral. O quadro é o da anti-NMDA: sintomas psiquiátricos, insônia, discinesias orofaciais e coreoatetose (que predomina na criança pequena, mas aparece também no adulto, em quem dominam os sintomas psiquiátricos), disautonomia (FC oscilante) e EEG lento, sem febre. Contra a recidiva estão a PCR negativa, a RM sem lesão nova e o líquor pouco inflamatório; movimentos coreicos não são manifestação de replicação viral. Neurotoxicidade do aciclovir ocorre durante o uso, sobretudo com insuficiência renal, e regride ao suspender. A confirmação é o anticorpo anti-NMDAR no líquor, e o tratamento é imunoterapia (corticoide, imunoglobulina ou plasmaférese; rituximabe na segunda linha).

A) Encefalite autoimune anti-receptor NMDA CORRETA

Correta. Psiquiatria, discinesias orofaciais, coreoatetose e disautonomia 2 a 6 semanas após encefalite herpética, com PCR negativa: anti-NMDA pós-herpética.

B) Epilepsia focal pós-encefalítica

Errada. Epilepsia pós-encefalítica dá crises focais, não coreoatetose contínua com disautonomia, e o EEG mostraria atividade epileptiforme temporal.

C) Neurotoxicidade pelo aciclovir

Errada. Neurotoxicidade do aciclovir aparece durante o tratamento, em geral com DRC, e regride em dias após a suspensão; ela recebeu alta há 3 semanas.

D) Recidiva da encefalite herpética ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A recidiva viral teria PCR positiva ou lesão necrótica nova na RM, com febre; coreoatetose semanas depois aponta autoimunidade.

Para levar. Nova piora 2 a 6 semanas após encefalite herpética, com coreoatetose e PCR negativa: encefalite anti-NMDA, tratada com imunoterapia, não com aciclovir.

Graus et al., Lancet Neurol 2016 (critérios de encefalite autoimune); Armangue et al., Lancet Neurol 2018 (encefalite autoimune pós-herpética).

---

52 Infectologia · MPox com proctite em usuário de PrEP: exame confirmatório e duração do isolamento

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 29 anos, que faz sexo com homens e usa PrEP há 1 ano, procura atendimento por dor anal intensa, tenesmo e secreção mucopurulenta há 5 dias, precedidos de febre e mialgia. Há 3 dias surgiram 6 lesões em face, tronco e região perianal: pápulas e pústulas firmes, umbilicadas, algumas com crosta central. Teve sífilis tratada há 8 meses. Exame: T 37,9 °C, linfonodos inguinais dolorosos de 2 cm, proctite à anuscopia. Teste rápido para HIV não reagente, VDRL 1:2 (era 1:2 há 6 meses). O exame que confirma o diagnóstico mais provável e o período de isolamento recomendado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pápulas e pústulas firmes, umbilicadas, algumas com crosta central

Resolução. Proctite em usuário de PrEP com sífilis prévia faz pensar em linfogranuloma venéreo, gonorreia ou sífilis, mas as pústulas firmes e umbilicadas em face, tronco e períneo, após pródromo febril e com linfonodomegalia dolorosa, são de MPox. O diagnóstico se confirma por PCR em tempo real para o vírus em material de lesão (swab de pústula, crosta ou do reto); a sorologia não é usada, porque não distingue outros orthopoxvírus nem a resposta vacinal. O isolamento não se conta por um número fixo de dias: a transmissão vai do início dos sintomas até todas as lesões formarem crosta, as crostas caírem e a pele se refazer. O número 21 é o do período de incubação e do monitoramento de contatos, não o da transmissibilidade do caso.

A) Sorologia IgM / 21 dias do início

Errada. Sorologia não confirma MPox, e 21 dias é o período de monitoramento de contatos.

B) Sorologia IgM / até a reepitelização

Errada. O período de isolamento está certo, mas a sorologia não é o exame confirmatório.

C) PCR de lesão / 21 dias do início ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o exame está certo, mas 21 dias é a incubação; o isolamento vai até a reepitelização completa.

D) PCR de lesão / até a reepitelização CORRETA

Correta. PCR de material de lesão confirma, e o isolamento dura até as crostas caírem e a pele se refazer.

Para levar. MPox: confirme por PCR de material de lesão e isole até a reepitelização completa; 21 dias é o tempo de incubação, usado para monitorar contatos.

Plano de Contingência Nacional para Monkeypox (MS, 2022); WHO, Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: interim rapid response guidance (2022).

53

Pneumologia · Nódulo pulmonar sólido de 4 mm em paciente de baixo risco: nenhum exame de seguimento

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 41 anos, que nunca fumou, sem exposição ocupacional e sem antecedente pessoal ou familiar de câncer, fez TC de tórax na emergência após acidente de carro, sem lesões traumáticas. O laudo descreve nódulo sólido único de 4 mm, de contornos regulares, no lobo inferior esquerdo, e recomenda controle evolutivo. Ela tratou infecção latente por tuberculose há 6 anos, após contato com o pai. Está assintomática e muito ansiosa, com exame físico normal. Quanto ao seguimento do nódulo, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

nódulo sólido único de 4 mm

Resolução. O laudo pede controle, a paciente está ansiosa e a tuberculose do pai soa como fator de risco, e tudo isso puxa para alguma TC. Mas a Fleischner classifica o risco pelos fatores de câncer de pulmão (tabagismo, exposição a asbesto, radônio ou urânio, câncer de pulmão em parente de primeiro grau, idade, enfisema, localização em lobo superior), e infecção latente tratada não é um deles. Nódulo sólido único abaixo de 6 mm em paciente de baixo risco tem probabilidade de malignidade abaixo de 1% e não exige seguimento pela Fleischner, e abaixo de 5 mm a BTS também o dispensa. A TC em 12 meses é opcional só para alto risco com nódulo abaixo de 6 mm; TC em 3 meses é para nódulo sólido acima de 8 mm; PET não tem resolução para 4 mm. Expor a TC repetida e à ansiedade de novos laudos é o dano.

A) TC de tórax em 12 meses ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. TC opcional em 12 meses é para nódulo abaixo de 6 mm em paciente de alto risco; ela é de baixo risco.

B) TC de tórax em 3 meses

Errada. Controle em 3 meses é para nódulo sólido acima de 8 mm (com PET ou biópsia como alternativas).

C) PET-CT para caracterização

Errada. PET-CT avalia nódulo sólido de 8 mm ou mais; abaixo disso a sensibilidade é baixa e o falso negativo, a regra.

D) Nenhum seguimento de rotina CORRETA

Correta. Nódulo sólido único abaixo de 6 mm em baixo risco: sem seguimento de rotina pela Fleischner.

Para levar. Nódulo sólido abaixo de 6 mm em baixo risco não se acompanha; o risco é dado por fatores de câncer de pulmão, não pelo laudo nem pela ansiedade.

Fleischner Society 2017; BTS 2015 (nódulo pulmonar)

54

Hematologia · Anemia na LLC: anemia hemolítica autoimune x infiltração medular, e quando não tratar a LLC

Grade X / Y

Gabarito C

Homem de 70 anos, com leucemia linfocítica crônica diagnosticada há 3 anos em estádio Binet A, sem tratamento, procura atendimento por cansaço e urina escura há 10 dias. Nega febre e sudorese. Linfonodos cervicais de 1,5 cm e baço a 2 cm do rebordo, como nas consultas anteriores. Exames: Hb 7,6 g/dL (13,4 há 6 meses), VCM 108 fL, reticulócitos 11%, leucócitos 42.000/mm³ (86% de linfócitos), plaquetas 168.000/mm³, LDH 690 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 2,8 mg/dL, teste de Coombs direto positivo (IgG). O mecanismo da anemia e a conduta inicial são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

reticulócitos 11%

Resolução. Hemoglobina abaixo de 10 g/dL numa LLC reclassifica a doença como Binet C, que é indicação de tratamento, e esse é o rótulo que derruba. Binet C, porém, pressupõe anemia por infiltração medular, que é hipoproliferativa. O número que decide é a reticulocitose de 11%: a medula está produzindo, e LDH alta, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta e Coombs IgG positivo mostram que as hemácias estão sendo destruídas. É anemia hemolítica autoimune, complicação de 5 a 10% das LLC, e o VCM alto vem dos reticulócitos. A anemia autoimune não conta para o estadiamento: trata-se primeiro com corticoide, e a LLC só passa a ter indicação de tratamento se a hemólise for refratária ao corticoide. O baço e os linfonodos estáveis confirmam que a LLC não progrediu.

A) Infiltração medular / tratar a LLC ARMADILHA

Errada. É a armadilha: lê Hb abaixo de 10 como Binet C, mas reticulócitos de 11% excluem falha medular.

B) Infiltração medular / transfusão isolada

Errada. Infiltração não explica reticulocitose e Coombs positivo; e transfusão isolada não para a hemólise.

C) Hemólise autoimune / prednisona CORRETA

Correta. Reticulocitose, LDH alta, haptoglobina indetectável e Coombs IgG positivo: AHAI quente, tratada inicialmente com prednisona.

D) Hemólise autoimune / tratar a LLC

Errada. O mecanismo está certo, mas a LLC só se trata se a AHAI não responder ao corticoide, conforme o iwCLL.

Para levar. Anemia na LLC com reticulocitose e Coombs positivo é autoimune, não Binet C: começa com corticoide, e a LLC se trata só se a hemólise for corticorrefratária.

iwCLL 2018 guidelines (Hallek et al., Blood 2018); BSH 2017 guideline on autoimmune haemolytic anaemia.

---

55 Gastroenterologia · Necrose pancreática infectada encapsulada com piora apesar do antibiótico: drenagem endoscópica no step-up

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 50 anos está internado há 35 dias por pancreatite aguda necrosante de origem biliar. No 18º dia teve febre, e a TC mostrou gás em coleção necrótica; iniciado meropeném, houve melhora inicial. Há 4 dias voltou a ter febre diária de 38,6 °C e taquicardia, sem hipotensão, mantendo dieta enteral por sonda. Exame: FC 112 bpm, PA 118 × 72 mmHg, massa epigástrica dolorosa, sem peritonite. Exames: leucócitos 19.000/mm³, PCR 210 mg/L, lactato 1,4 mmol/L. TC de hoje: necrose encapsulada de 13 cm, com parede bem definida, conteúdo heterogêneo com gás, em contato com a parede posterior do estômago; sem pseudoaneurisma. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

necrose encapsulada de 13 cm, com parede bem definida

Resolução. Necrose infectada que piora após 10 dias de meropeném leva muitos à necrosectomia aberta, a conduta antiga. A abordagem atual é em degraus e tardia: antibiótico primeiro, e intervenção só se ele falhar, de preferência depois de 4 semanas, quando a necrose está encapsulada. No 35º dia, com parede bem definida e coleção junto ao estômago, a primeira intervenção é a drenagem endoscópica transmural (ou percutânea, se o acesso endoscópico não for possível), com necrosectomia endoscópica depois, se necessário. A necrosectomia aberta tem mais falência orgânica nova, fístula e mortalidade e fica para falha da via minimamente invasiva. Trocar o antibiótico sem drenar não resolve uma coleção infectada de 13 cm em quem piora.

A) Drenagem endoscópica transmural CORRETA
Correta. Necrose encapsulada infectada, com piora apesar do antibiótico e depois de 4 semanas: drenagem endoscópica transmural é o primeiro degrau invasivo.

B) Manter meropeném isolado por 4 semanas
Errada. Manter só antibiótico seria aceitável em quem melhora; com febre e leucocitose de volta após 10 dias, a coleção precisa ser drenada.

C) Trocar meropeném por polimixina
Errada. Não há dado de germe resistente a carbapenêmico; o problema é a coleção infectada sem drenagem, e não o espectro.

D) Necrosectomia cirúrgica aberta ARMADILHA
Errada. É a isca: a necrosectomia aberta foi substituída pelo step-up minimamente invasivo, que reduz complicações graves e mortalidade.

Para levar. Necrose infectada: antibiótico, e intervenção só se piorar, de preferência após 4 semanas; começa por drenagem endoscópica ou percutânea, e não por cirurgia aberta.

ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2024); AGA Clinical Practice Update on Management of Pancreatic Necrosis (2020); PANTER (2010), TENSION (2018) e POINTER (2021)

---

56 Cardiologia · Apixabana na fibrilação atrial: redução de dose exige dois de três critérios

Limiar **Gabarito B**

Homem de 83 anos, 64 kg, creatinina 1,3 mg/dL (clearance estimado de 39 mL/min), com fibrilação atrial não valvar e CHA2DS2-VA de 4, vai iniciar apixabana. Não usa fármaco que interaja. A dose adequada é:

O DADO QUE DECIDE

64 kg, creatinina 1,3 mg/dL

Resolução. Idoso de 83 anos com função renal reduzida dá vontade de reduzir a dose, e a dose reduzida é a armadilha. Na FA, a apixabana passa para 2,5 mg de 12 em 12 horas quando há pelo menos dois de três critérios: idade de 80 anos ou mais, peso de 60 kg ou menos, creatinina de 1,5 mg/dL ou mais. Ele tem só a idade: pesa 64 kg e a creatinina é 1,3. O clearance de 39 mL/min também não reduz a dose (na bula brasileira e na europeia, a redução isolada pelo clearance vale só entre 15 e 29 mL/min). Subdosar anticoagulante em idoso com escore 4 troca um risco hemorrágico que não existe por um risco de AVC que existe.

A) 2,5 mg uma vez ao dia
Errada. A apixabana não tem posologia de uma vez ao dia em nenhuma indicação: a meia-vida curta exige duas tomadas, inclusive nos 2,5 mg da profilaxia pós-artroplastia e da prevenção estendida após TEV. Tomada única diária é da rivaroxabana e da edoxabana.

B) 5 mg de 12 em 12 horas CORRETA
Correta. Um critério só (idade) não reduz a dose; com clearance de 39 mL/min, a dose plena de 5 mg duas vezes ao dia se mantém.

C) 2,5 mg de 12 em 12 horas ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a dose com dois critérios, por exemplo se pesasse 60 kg ou menos ou se a creatinina fosse de 1,5 ou mais; ele só tem a idade.

D) 10 mg de 12 em 12 horas por 7 dias
Errada. 10 mg duas vezes ao dia por 7 dias é a fase inicial do tratamento de TEV, não a dose da FA.

Para levar. Apixabana na FA: 2,5 mg de 12/12 h só com dois de três (80 anos ou mais, 60 kg ou menos, creatinina de 1,5 ou mais); um critério isolado mantém 5 mg de 12/12 h.

ESC 2024 (atrial fibrillation); EHRA Practical Guide 2021 (NOAC); bula da apixabana (ANVISA)

---

57 Reumatologia · Poliarterite nodosa associada ao vírus da hepatite B: antiviral com plasmaférese e corticoide breve

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 38 anos, com uso de drogas injetáveis no passado, procura atendimento por dor abdominal pós-prandial, perda de 8 kg e dor em queimação nos pés há 3 meses. Há 2 semanas teve dor testicular esquerda e, há 4 dias, queda do pé esquerdo. Exame físico: PA 178 × 108 mmHg (antes normotenso), livedo racemoso em coxas, nódulos subcutâneos dolorosos em pernas, orquite esquerda, fraqueza da dorsiflexão do pé esquerdo. Exames: Hb 11 g/dL, leucócitos 13.400/mm³ sem eosinofilia, creatinina 1,4 mg/dL, EAS sem hemácias e sem cilindros, proteinúria 0,3 g/24 h, c-ANCA e p-ANCA não reagentes, crioglobulinas negativas, HBsAg e HBeAg reagentes, HBV-DNA 8,2 log UI/mL, ALT 96 U/L, anti-HCV não reagente. Angiotomografia: microaneurismas em artérias renais interlobares e na mesentérica superior. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

HBsAg e HBeAg reagentes, HBV-DNA 8,2 log UI/mL

Resolução. Reconhecer a poliarterite nodosa é a metade fácil: mononeurite, orquite, livedo, angina mesentérica, hipertensão nova e microaneurismas, com ANCA negativo e EAS sem glomerulonefrite, o que afasta a poliangeíte microscópica. A armadilha está no tratamento: ciclofosfamida com corticoide prolongado é o esquema da poliarterite idiopática grave, e na forma associada ao HBV ele aumenta a replicação viral e o risco de hepatite fulminante e de cronificação. Com HBeAg reagente e carga viral alta, a doença é mediada por imunocomplexos do vírus, e o tratamento é antiviral potente (tenofovir ou entecavir), corticoide em dose alta só nas primeiras 1 a 2 semanas para controlar a inflamação, e plasmaférese para remover os imunocomplexos até a soroconversão. A ciclofosfamida fica para a doença que não responde a esse esquema.

A) PAN associada ao HBV / ciclofosfamida e corticoide prolongado ARMADILHA
Errada na segunda metade. O diagnóstico está certo, mas imunossupressão prolongada sem antiviral faz o vírus replicar e pode levar a hepatite fulminante.

B) PAN associada ao HBV / antiviral, corticoide breve e plasmaférese CORRETA
Correta. PAN com HBV replicativo: antiviral, corticoide por poucas semanas e plasmaférese até a soroconversão do HBeAg.

C) Poliangeíte microscópica / ciclofosfamida e corticoide prolongado
Errada nas duas metades. Sem glomerulonefrite, sem capilarite pulmonar e com microaneurismas e ANCA negativo, não é poliangeíte microscópica.

D) Poliangeíte microscópica / antiviral, corticoide breve e plasmaférese
Errada na primeira metade. O tratamento é o da PAN viral, mas o diagnóstico de poliangeíte microscópica exigiria glomerulonefrite ou pulmão, ausentes.

Para levar. PAN com HBV replicativo trata o vírus: antiviral, corticoide breve e plasmaférese. Ciclofosfamida prolongada é para a PAN idiopática.

Guillevin L et al., Medicine 2005 (French Vasculitis Study Group, PAN associada ao HBV); ACR/Vasculitis Foundation 2021 Guideline for the Management of Polyarteritis Nodosa (PAN não associada ao HBV); EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on HBV infection.

58

Nefrologia · Hipocalemia refratária com hipocalcemia em uso crônico de omeprazol · dosar magnésio

Dado omitido | Gabarito A

Mulher de 63 anos, com doença do refluxo em uso de omeprazol 40 mg/dia há sete anos e hipertensão controlada com anlodipino, é internada por fraqueza e palpitações. Nega diarreia, vômitos, diurético, laxante ou álcool. Exame: PA 128/78 mmHg, FC 96 bpm irregular, sem tetania. ECG: extrassístoles ventriculares frequentes e QTc de 500 ms. Recebeu 120 mEq de cloreto de potássio por via venosa e oral nas últimas 48 horas, e o potássio passou de 2,7 para 3,0 mEq/L. Outros exames: sódio 139 mEq/L, bicarbonato 26 mEq/L, cálcio total 7,6 mg/dL, albumina 4,0 g/dL, fósforo 3,6 mg/dL, PTH 18 pg/mL (15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL, potássio urinário 36 mEq/L. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

o potássio passou de 2,7 para 3,0 mEq/L

Resolução. Hipocalemia com potássio urinário alto aponta perda renal, e o apressado vai ao eixo renina-aldosterona. Mas há três sinais de hipomagnesemia, cujo exame foi deixado de fora: a hipocalemia não sobe com 120 mEq de reposição (o magnésio baixo libera o canal ROMK e o rim perde potássio sem parar), a hipocalcemia vem com PTH inapropriadamente baixo (o magnésio é necessário para a secreção e para a ação do PTH), e há QTc longo com ectopias. A causa está na primeira linha: inibidor de bomba de prótons há sete anos reduz a absorção intestinal de magnésio pelos canais TRPM6 e TRPM7. O próximo exame é o magnésio sérico; confirmada a hipomagnesemia, repõe-se magnésio antes ou junto com o potássio, e o omeprazol é suspenso ou trocado. Gitelman também cursa com hipomagnesemia, mas é diagnóstico de exclusão, e a causa adquirida evidente vem antes.

A) Magnésio sérico CORRETA

Correta. Hipocalemia refratária, hipocalcemia com PTH baixo e IBP crônico: o magnésio sérico é o exame que falta e o que muda a conduta.

B) Pesquisa genética para Gitelman

Errada. A pesquisa genética é o último degrau, para jovem com hipocalemia, alcalose e hipomagnesemia sem causa adquirida; o IBP há sete anos é a causa até prova em contrário.

C) Cálcio urinário de 24 horas

Errada. O cálcio urinário separa Gitelman (baixo) de Bartter (alto), investigação de tubulopatia que só faz sentido depois de afastar a causa adquirida evidente.

D) Renina e aldosterona plasmáticas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria o passo na hipocalemia com perda renal e hipertensão difícil; aqui a PA está controlada com anlodipino, e a refratariedade com hipocalcemia aponta outra causa.

Para levar. Hipocalemia que não sobe com reposição e hipocalcemia com PTH baixo pedem magnésio sérico; IBP crônico é causa adquirida de hipomagnesemia, e o magnésio se repõe junto com o potássio.

FDA Drug Safety Communication (inibidores de bomba de prótons e hipomagnesemia, 2011); Harrison 21ª ed. (Disorders of Magnesium and Phosphorus); UpToDate 2025 (Hypomagnesemia: causes).

59

Cronologia | Gabarito A

Infectologia · Síndrome inflamatória de reconstituição imune paradoxal na tuberculose ganglionar

Homem de 33 anos, com HIV diagnosticado junto com tuberculose ganglionar cervical (TRM-TB detectado no aspirado, sem resistência à rifampicina), CD4 inicial 46 células/mm³ e carga viral 410.000 cópias/mL. Iniciou RHZE e, 2 semanas depois, tenofovir, lamivudina e dolutegravir 50 mg de 12/12 horas. Vinha com boa adesão, afebril e com redução dos linfonodos. Três semanas após o início da TARV, volta a ter febre de 38,8 °C e aumento doloroso dos linfonodos cervicais, um deles flutuante, além de pequeno derrame pleural à direita. Exame: PA 118 × 76 mmHg, SpO2 97%, sem sinais meníngeos. CD4 atual 168 células/mm³, carga viral 1.200 cópias/mL. Hemoculturas negativas, radiografia sem consolidação. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Três semanas após o início da TARV

Resolução. Piora da tuberculose em tratamento, com febre e linfonodos maiores, faz pensar em falha ou resistência, e a troca de esquema parece a resposta firme. A cronologia conta outra história: o paciente vinha melhorando com o RHZE e piorou 3 semanas depois de iniciar a TARV, com CD4 subindo de 46 para 168 e carga viral caindo de 410.000 para 1.200. Esse é o perfil da síndrome inflamatória de reconstituição imune paradoxal, mais frequente com CD4 baixo e TARV precoce, e o TRM inicial já mostrou sensibilidade à rifampicina. A conduta é manter TB e TARV, afastar outras causas, puncionar o linfonodo flutuante se houver tensão, e associar prednisona (cerca de 1,5 mg/kg/dia por 2 semanas e 0,75 mg/kg/dia por mais 2) nas formas moderadas, o que reduz internação e procedimentos. Suspender a TARV só se cogita em reação com risco de vida, sobretudo no SNC.

A) Manter RHZE e TARV e associar prednisona CORRETA
Correta. Piora 3 semanas após a TARV, com CD4 subindo e carga viral caindo: SIRI paradoxal, tratada com manutenção dos dois esquemas e prednisona.

B) Suspender a TARV até a melhora clínica
Errada. Suspender a TARV seria considerado só em SIRI grave com risco de vida, como no SNC; aqui expõe a novas oportunistas sem ganho.

C) Trocar para esquema de TB resistente ARMADILHA
Errada. É a armadilha: troca de esquema seria a conduta na falha com resistência comprovada; a cronologia, a resposta laboratorial à TARV e o TRM sensível apontam SIRI.

D) Suspender o RHZE e repetir o TRM-TB
Errada. Interromper o RHZE numa TB sensível em plena reconstituição imune perde o tratamento; nova pesquisa pode ser feita sem suspender.

Para levar. Piora da TB 2 a 8 semanas após iniciar TARV, com CD4 subindo e carga viral caindo, é SIRI paradoxal: mantenha os dois tratamentos e use prednisona nas formas moderadas.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024); Meintjes G et al., prednisona na TB-SIRI paradoxal (AIDS, 2010).

60 Neurologia · AVC menor não incapacitante na janela: sem trombólise, dupla antiagregação por 21 dias

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 64 anos, hipertensa e dislipidêmica, chega ao PS 2 horas após início súbito de dormência na face e na mão direitas e leve imprecisão na fala, que persistem. Exame: hipoestesia em face e mão direitas e disartria leve; força normal, sem afasia, sem negligência e sem hemianopsia; NIHSS 2. Ela consegue trabalhar e cuidar da casa com os déficits atuais. PA 156/90 mmHg, glicemia 124 mg/dL, ECG em ritmo sinusal. TC de crânio sem contraste normal; angiotomografia sem oclusão de grande vaso e sem estenose carotídea significativa. Não usa antitrombóticos. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Ela consegue trabalhar e cuidar da casa com os déficits atuais.

Resolução. Ela está dentro de 4,5 horas e sem contraindicação, e quem aplica a janela trombolisa. O critério que falta é o déficit incapacitante: com NIHSS de 0 a 5 e déficit que não impede as atividades habituais (hipoestesia isolada, disartria leve), a trombólise não traz benefício funcional e acrescenta risco de sangramento (estudos PRISMS e ARAMIS). Nesse grupo, o que reduz recorrência é a dupla antiagregação precoce: AAS com clopidogrel (dose de ataque) iniciada nas primeiras 24 horas e mantida por 21 dias, depois antiagregante único (CHANCE, POINT; INSPIRES até 72 horas). Prolongar a dupla aumenta sangramento sem ganho, e AAS isolado protege menos nas primeiras semanas. Anticoagulação não tem indicação sem fonte cardioembólica: o ECG é sinusal e a investigação de FA segue com monitorização.

A) AAS isolado por tempo indeterminado
Errada. AAS isolado é a prevenção de longo prazo, mas nas primeiras semanas após AVC menor ou AIT de alto risco a dupla reduz recorrência.

B) Apixabana em dose plena
Errada. Anticoagulação é para fonte cardioembólica (FA, trombo); com ritmo sinusal e sem fonte, não reduz recorrência e sangra mais.

C) Tenecteplase em bolus ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta com déficit incapacitante (afasia, hemiparesia, hemianopsia) dentro da janela; com NIHSS 2 não incapacitante, a trombólise não traz benefício.

D) AAS e clopidogrel por 21 dias CORRETA
Correta. AVC menor não incapacitante sem cardioembolia: AAS com clopidogrel nas primeiras 24 horas por 21 dias, depois antiagregante único.

Para levar. AVC menor não incapacitante (NIHSS até 5) ou AIT de alto risco: sem trombólise, AAS com clopidogrel por 21 dias e depois um só antiagregante.

AHA/ASA 2026 (AVC isquêmico agudo); AHA/ASA 2021 (prevenção secundária); PRISMS (JAMA 2018); ARAMIS (JAMA 2023); POINT e CHANCE.

61 Endocrinologia · Microprolactinoma na gestação: suspender a cabergolina e não dosar prolactina

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 30 anos, com microprolactinoma de 6 mm diagnosticado por amenorreia e galactorreia, usa cabergolina 0,5 mg por semana há 14 meses, com prolactina normalizada e retorno dos ciclos. Desejava engravidar e tem teste de gravidez positivo, com cinco semanas de gestação. Assintomática, sem cefaleia ou queixa visual. Exame neurológico e campimetria de confrontação normais. Prolactina atual: 48 ng/mL. Em relação ao prolactinoma, a conduta mais adequada durante a gestação é:

O DADO QUE DECIDE

microprolactinoma de 6 mm

Resolução. A prolactina de 48 ng/mL depois de meses normal parece escape do tumor, e o reflexo é vigiá-la por dosagem seriada ou manter o agonista. Na gestação, porém, a prolactina sobe fisiologicamente (os lactotrofos se multiplicam sob estrogênio), e o número deixa de refletir o tumor; por isso não se dosa prolactina durante a gravidez. O dado que decide é o tamanho: microadenoma tem risco de crescimento sintomático na gestação de cerca de 2 a 3%. A conduta é suspender a cabergolina assim que a gestação é confirmada e acompanhar clinicamente, com campimetria e ressonância sem contraste só se aparecerem cefaleia ou alteração visual. Macroadenomas pedem vigilância mais próxima, e às vezes manutenção do agonista.

A) Suspender a cabergolina e observar CORRETA
Correta. Microprolactinoma: suspender o agonista ao confirmar a gestação e seguir pela clínica, sem dosagens.

B) Manter a cabergolina até o parto
Errada. Seria considerada em macroadenoma volumoso ou próximo ao quiasma; no microadenoma, expõe o feto sem necessidade.

C) Ressonância de sela trimestral
Errada. Imagem só com sintomas compressivos; rotina trimestral não tem indicação.

D) Dosar prolactina a cada trimestre ARMADILHA
Errada. A prolactina sobe normalmente na gestação e não serve para monitorar o tumor.

Para levar. Prolactinoma e gestação: microadenoma suspende a cabergolina e é seguido pela clínica; prolactina não se dosa na gravidez; imagem só com sintoma.

Endocrine Society, Hyperprolactinemia 2011; Pituitary Society consensus on prolactinomas 2023.

---

62 Oncologia · Hepatite imunomediada grau 3 por inibidor de checkpoint refratária ao corticoide: micofenolato, e não infliximabe

Grade X / Y **Gabarito B**

Mulher de 58 anos com melanoma metastático em uso de ipilimumabe e nivolumabe (3º ciclo há 3 semanas) apresenta ALT de 680 U/L e AST de 540 U/L (referência até 40 U/L), bilirrubina total 1,1 mg/dL e INR 1,0, assintomática. Sem álcool, paracetamol ou medicamento novo; sorologias virais negativas; ultrassonografia com Doppler sem metástases hepáticas e sem trombose. A imunoterapia foi suspensa e iniciada metilprednisolona

1,5 mg/kg/dia. Após 4 dias, ALT 610 U/L e AST 470 U/L, sem sinais de insuficiência hepática. Quanto ao corticoide e ao imunossupressor a associar, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Após 4 dias, ALT 610 U/L e AST 470 U/L

Resolução. Quem conhece a colite por imunoterapia lembra que o resgate do corticoide é infliximabe, e transporta a regra para o fígado. ALT de 680 U/L (17 vezes o limite) é hepatite grau 3: suspende-se a imunoterapia e inicia-se corticoide de 1 a 2 mg/kg/dia, como foi feito. Sem melhora após 3 dias (ALT ainda em 610), a hepatite é refratária e acrescenta-se micofenolato, mantendo o corticoide; o infliximabe é evitado na hepatite imunomediada pelo potencial hepatotóxico. Suspender o corticoide nesse ponto deixaria a inflamação sem controle. Tacrolimo ou globulina antitimocitária ficam para falha do micofenolato.

A) Manter corticoide / associar infliximabe ARMADILHA
Errada. É a isca: infliximabe é o resgate da colite refratária, mas é evitado na hepatite imunomediada pela hepatotoxicidade.

B) Manter corticoide / associar micofenolato CORRETA
Correta. Hepatite grau 3 sem resposta após 3 dias de corticoide: manter o corticoide e associar micofenolato.

C) Suspender corticoide / associar micofenolato
Errada. O micofenolato está certo, mas retirar o corticoide na fase ativa perde o controle da inflamação.

D) Suspender corticoide / associar infliximabe
Errada nas duas metades: retira o corticoide e escolhe a droga evitada no fígado.

Para levar. Toxicidade por imunoterapia refratária ao corticoide: na colite, infliximabe ou vedolizumabe; na hepatite, micofenolato.

ASCO Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy (2021); ESMO Clinical Practice Guideline: management of toxicities from immunotherapy (2022)

---

63 Hematologia · Anemia sideroblástica por isoniazida durante o tratamento da tuberculose: piridoxina

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 45 anos, que bebe 3 doses por semana, está no 4º mês de tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina e isoniazida, com boa resposta clínica e baciloscopia negativa. Queixa cansaço progressivo há 1 mês. Exames: Hb 8,2 g/dL, VCM 71 fL, RDW 24%, reticulócitos 0,8%, ferro sérico 210 mcg/dL, saturação de transferrina 82%, ferritina 940 ng/mL, PCR 0,6 mg/dL, vitamina B12 e folato normais. Esfregaço: população dupla de hemácias, microcíticas hipocrômicas e normocíticas, com corpúsculos de Pappenheimer. A conduta mais adequada para a anemia é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de transferrina 82%

Resolução. Tuberculose é doença inflamatória crônica, e o rótulo puxa para anemia de doença crônica; a microcitose ainda tenta para ferropenia. Os números do ferro derrubam as duas: na doença crônica a ferritina

sobe, mas a saturação de transferrina cai, porque a hepcidina prende o ferro nos macrófagos, e na ferropenia as duas caem. Saturação de 82% com ferritina de 940, PCR normal, população dupla de hemácias e corpúsculos de Pappenheimer é anemia sideroblástica: o ferro chega ao eritroblasto mas não entra no heme. A isoniazida antagoniza a piridoxina, cofator da ALA-sintase, primeiro passo da síntese do heme. Quem reconhece a droga tende a suspender o esquema, e essa é a armadilha: a conduta é repor piridoxina mantendo o tratamento, que está funcionando, e a anemia responde em semanas. O álcool também causa sideroblastose, mas em consumo pesado, não em 3 doses por semana.

A) Sulfato ferroso oral
Errada. Ferro oral seria para ferropenia, com saturação e ferritina baixas; aqui o ferro sobra e a reposição agrava a sobrecarga.

B) Piridoxina, mantendo o esquema CORRETA
Correta. Microcitose com saturação de 82% e ferritina alta em uso de isoniazida: anemia sideroblástica por falta funcional de B6, corrigida com piridoxina.

C) Alfaepoetina subcutânea
Errada. Lê "tuberculose" como anemia de doença crônica, mas na doença crônica a saturação é baixa, não 82%, e alfaepoetina não corrige defeito na síntese do heme.

D) Suspender o esquema antituberculose ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a isoniazida explica a anemia, mas não precisa sair; a piridoxina corrige o defeito, e interromper o tratamento eficaz arrisca falência e resistência.

Para levar. Microcitose com saturação de transferrina e ferritina altas não é ferropenia nem doença crônica: é anemia sideroblástica; com isoniazida, repõe piridoxina e mantém o esquema.

Ministério da Saúde, Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil (2ª edição, 2019); Bottomley e Fleming, Sideroblastic anemia, Hematol Oncol Clin North Am 2014.

---

64 Pneumologia · Pneumonia comunitária grave: hidrocortisona com influenza negativa

Negativo no meio · Gabarito A

Homem de 62 anos, hipertenso, sem internações ou uso de antibiótico nos últimos 6 meses, chega com febre, tosse e dispneia há 3 dias. FR 34 irpm, SpO2 86% em ar ambiente, PA 118 × 70 mmHg sem vasopressor, confuso, ureia 62 mg/dL. Radiografia: consolidação multilobar à direita. Foi para a UTI e está em cateter nasal de alto fluxo com FiO2 de 60%, com PaO2 de 84 mmHg. Iniciados ceftriaxona e azitromicina após hemoculturas. PCR para influenza e SARS-CoV-2 negativos; swab nasal para MRSA negativo; glicemia 168 mg/dL; sem uso prévio de corticoide. Além de manter o antibiótico, a medida adicional com benefício em mortalidade demonstrado neste perfil de paciente é:

O DADO QUE DECIDE
PCR para influenza e SARS-CoV-2 negativos

Resolução. Diante da PAC grave, o reflexo é ampliar o antibiótico. Mas ele não tem fator de risco para MRSA nem para Pseudomonas (sem internação ou antibiótico recente, swab de MRSA negativo), e ampliar só acrescenta toxicidade. É PAC grave (critério maior: suporte ventilatório; relação PaO2/FiO2 de cerca de 140), e o CAPE COD mostrou que hidrocortisona 200 mg/dia, iniciada em até 24 horas, reduz a mortalidade em 28

dias nesse grupo; a atualização da SCCM de 2024 recomenda corticoide na PAC bacteriana grave. A precondição é o negativo do meio: influenza negativa, porque na pneumonia por influenza o corticoide aumenta mortalidade e infecção secundária, e o estudo excluiu esses pacientes, assim como os em choque séptico. Hiperglicemia leve não contraindica.

A) Hidrocortisona intravenosa CORRETA

Correta. PAC grave em suporte ventilatório, sem influenza e sem choque: hidrocortisona venosa por 8 a 14 dias reduz mortalidade.

B) Associar vancomicina ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Cobertura de MRSA é para quem tem colonização, internação ou antibiótico venoso recente; swab negativo e nenhum fator de risco.

C) Oseltamivir empírico

Errada. Oseltamivir empírico cabe na suspeita de influenza enquanto o teste não chega; com PCR negativa, não acrescenta.

D) Trocar ceftriaxona por meropenem

Errada. Meropenem é para risco de Pseudomonas ou germe resistente; ceftriaxona e azitromicina cobrem a PAC grave sem esses fatores.

Para levar. Na PAC grave sem influenza e sem choque, hidrocortisona reduz mortalidade; ampliar antibiótico exige fator de risco documentado para MRSA ou Pseudomonas.

CAPE COD (N Engl J Med 2023); SCCM 2024 (atualização sobre corticoide na PAC grave); ATS/IDSA 2019 (PAC: gravidade e fatores de risco para MRSA e Pseudomonas)

---

65 Cardiologia · Sífilis terciária: aortite com insuficiência aórtica audível na borda esternal direita

Dado omitido | Gabarito A

Homem de 63 anos, hipertenso há 20 anos, procura atendimento por dispneia aos esforços há 6 meses. Refere dores lancinantes nas pernas há anos e dificuldade para andar no escuro. Exame: marcha talonante, Romberg positivo, reflexos aquileus e patelares abolidos, pupilas pequenas e irregulares que não reagem à luz e se contraem na acomodação. PA 158×60 mmHg, FC 80 bpm, ictus desviado para o 6º espaço intercostal na linha axilar anterior. Radiografia de tórax: alargamento do mediastino superior e calcificação linear da parede da aorta ascendente. O achado auscultatório mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pupilas pequenas e irregulares que não reagem à luz e se contraem na acomodação

Resolução. Idoso hipertenso com aorta calcificada e sopro puxa para estenose aórtica degenerativa, e é a armadilha. Mas a banca omitiu a sorologia e deixou a síndrome: pupilas de Argyll Robertson, dores lancinantes, ataxia sensitiva com Romberg e arreflexia são tabes dorsalis, e a mesma sífilis terciária produz aortite. A aortite sifilítica dilata a aorta ascendente e a raiz (calcificação linear da ascendente, rara na aterosclerose, que poupa esse segmento), e a lesão valvar é insuficiência aórtica. Com a raiz dilatada e deslocada para a direita, o sopro diastólico aspirativo é mais audível na borda esternal direita, enquanto na lesão primária das cúspides ele é mais audível na esquerda. Pressão de pulso de 98 mmHg e ictus desviado para baixo e para fora completam o quadro de sobrecarga de volume.

A) Sopro diastólico aspirativo em borda esternal direita CORRETA

Correta. Tabes dorsalis indica sífilis terciária, cuja aortite dilata a raiz e dá insuficiência aórtica com sopro mais audível à direita do esterno.

B) Sopro holossistólico apical irradiado para a axila

Errada. O holossistólico apical é da insuficiência mitral; a dilatação do VE pode causar IM funcional, mas não é o achado principal da aortite.

C) Ruflar diastólico apical com estalido de abertura

Errada. Ruflar apical com estalido é estenose mitral reumática. Na insuficiência aórtica grave pode haver ruflar apical sem estalido (Austin Flint), que não é a lesão primária.

D) Sopro sistólico ejetivo irradiado para as carótidas ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Seria a estenose aórtica calcífica do idoso, com pulso parvus et tardus e pressão de pulso estreita; aqui ela é larga (158×60) e a calcificação é da parede da ascendente.

Para levar. Sífilis terciária (tabes, Argyll Robertson) leva a aortite da ascendente, que leva a insuficiência aórtica; sopro diastólico na borda esternal direita sugere doença da raiz (sífilis, Marfan, dissecção, espondilite), e na esquerda, doença das cúspides.

ACC/AHA 2020 (valvular heart disease); Ministério da Saúde, PCDT IST 2022; Braunwald's Heart Disease, 12ª ed.

66

Nefrologia · Lesão renal no diabético com retinopatia e proteinúria não albumínica · nefropatia por cilindros do mieloma

Rótulo verdadeiro | **Gabarito B**

Homem de 68 anos, com diabetes tipo 2 há 12 anos, retinopatia diabética não proliferativa e hipertensão, tinha creatinina de 1,3 mg/dL há seis meses. Há dois meses tem fadiga e dor lombar. Exames: creatinina 3,9 mg/dL, hemoglobina 9,1 g/dL, cálcio 10,9 mg/dL, albumina 3,8 g/dL, proteínas totais 6,4 g/dL, glicemia 168 mg/dL. Urina: fita reagente com traços de proteína, sem hematúria, sem leucocitúria; proteinúria de 24 h de 3,6 g; relação albumina/creatinina urinária de 40 mg/g. Ultrassonografia: rins de 11,5 cm, sem hidronefrose. A causa mais provável da lesão renal é:

O DADO QUE DECIDE

relação albumina/creatinina urinária de 40 mg/g

Resolução. Diabetes de 12 anos com retinopatia é o cenário em que a doença renal do diabetes é a regra, e o rótulo é verdadeiro. Mas a proteinúria não é dela: 3,6 g em 24 horas com fita quase negativa e albuminúria de apenas 40 mg/g quer dizer que quase toda a proteína urinária não é albumina. A fita detecta albumina; a proteinúria de 24 horas mede tudo, inclusive cadeias leves. Proteinúria abundante não albumínica é cadeia leve livre filtrada (proteinúria de Bence Jones), e com anemia, hipercalcemia, dor lombar e creatinina triplicando em meses o quadro é de mieloma com nefropatia por cilindros. As globulinas de 2,6 g/dL (proteínas totais 6,4 menos albumina 3,8) não estão altas porque o mieloma de cadeia leve não produz imunoglobulina inteira. Na doença do diabetes e na amiloidose AL a lesão é glomerular, e a proteinúria é sobretudo albumina. Próximo passo: cadeias leves livres séricas, eletroforese e imunofixação.

A) Doença renal do diabetes ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Retinopatia e diabetes longo fazem dela a causa esperada, mas a doença do diabetes dá albuminúria, e aqui ela é de 40 mg/g diante de 3,6 g de proteína; além disso, não triplica a creatinina em seis meses.

B) Nefropatia por cilindros de cadeias leves CORRETA

Correta. Proteinúria maciça não albumínica (fita com traços, albumina/creatinina de 40 mg/g), anemia, hipercalcemia e lesão renal rápida: cadeias leves precipitando como cilindros nos túbulos distais.

C) Amiloidose AL renal

Errada. A amiloidose AL é glomerular e cursa com síndrome nefrótica de albuminúria alta e sedimento brando; a proteína urinária aqui não é albumina.

D) Nefropatia membranosa

Errada. A membranosa dá síndrome nefrótica com albuminúria e hipoalbuminemia, sem anemia ou hipercalcemia.

Para levar. Proteinúria de 24 h alta com fita negativa ou albuminúria baixa é proteína não albumínica (cadeia leve): pense em mieloma com nefropatia por cilindros, mesmo no diabético.

IMWG, critérios diagnósticos do mieloma (2014) e recomendações sobre lesão renal no mieloma (2016); KDIGO 2024 (CKD), avaliação da albuminúria e da proteinúria.

---

67 Reumatologia · Artrite reumatoide com neutropenia e esplenomegalia: leucemia de linfócitos grandes granulares e não Felty

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 66 anos tem artrite reumatoide soropositiva há 14 anos, erosiva, controlada com metotrexato 15 mg/semana e ácido fólico. Há 6 meses teve duas pneumonias e, há 2 meses, úlcera em perna. Exame físico: sinovite discreta em 2 metacarpofalângicas, nódulos reumatoides em cotovelos, baço palpável a 3 cm do rebordo costal, sem linfonodomegalias. Exames: Hb 11,2 g/dL, leucócitos 5.600/mm³ com neutrófilos 400/mm³ e linfócitos 4.800/mm³, plaquetas 190.000/mm³, VCM 92 fL. Citometria de fluxo: população CD3+, CD8+, CD57+ e CD16+ expandida, com rearranjo clonal do receptor de célula T. Vitamina B12 e folato normais. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

com rearranjo clonal do receptor de célula T

Resolução. Artrite reumatoide antiga, nodular e soropositiva com neutropenia, esplenomegalia, infecções e úlcera de perna é a definição de Felty, e esse rótulo é verdadeiro e tentador. O que a Felty não explica é o leucograma: o total de leucócitos é normal porque há 4.800 linfócitos, e a citometria mostra que eles são uma população T citotóxica CD3+, CD8+ e CD57+ expandida, com rearranjo clonal do receptor de célula T. Isso define a leucemia de linfócitos grandes granulares T, que se associa à artrite reumatoide e reproduz o quadro de Felty (o pseudo-Felty); no esfregaço, esses linfócitos são grandes e têm grânulos azurófilos. A distinção importa porque o tratamento é dirigido ao clone (metotrexato em dose baixa, ciclofosfamida ou ciclosporina) e o seguimento é hematológico. Neutropenia por metotrexato não vem com linfocitose clonal, e a leucemia linfocítica crônica é de células B pequenas, CD5 e CD23 positivas.

A) Neutropenia por metotrexato

Errada. A toxicidade do metotrexato tende a dar pancitopenia, macrocitose e mucosite, sem esplenomegalia nem linfocitose clonal; e a dose com ácido fólico é estável.

B) Leucemia linfocítica crônica

Errada. A leucemia linfocítica crônica é de linfócitos B pequenos e maduros (CD19, CD5, CD23), com manchas de Gumprecht, não de células T granulares.

C) Leucemia de linfócitos grandes granulares T CORRETA

Correta. Linfocitose T citotóxica CD8+ e CD57+ com clonalidade do receptor T, neutropenia e esplenomegalia em artrite reumatoide.

D) Síndrome de Felty ARMADILHA

Errada. Seria a resposta com neutropenia, esplenomegalia e linfócitos normais em número e sem clone; a linfocitose granular clonal muda o diagnóstico.

Para levar. Artrite reumatoide com neutropenia e esplenomegalia é Felty só se os linfócitos forem normais; linfocitose granular clonal CD8+ CD57+ é leucemia de linfócitos grandes granulares T.

WHO Classification of Haematolymphoid Tumours, 5ª ed. (2022); Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021).

68

Infectologia · Meningite linfocitária com glicorraquia baixa e razão normal por hipoglicemia, em contato de tuberculose

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 46 anos, diabético em uso de glibenclamida, procura o pronto-socorro por cefaleia holocraniana intensa, febre, fotofobia e vômitos há 3 dias; não se alimenta desde ontem. A esposa está no 2º mês de tratamento para tuberculose pulmonar bacilífera. Nega uso de antibióticos. Exame: T 38,4 °C, PA 128 × 80 mmHg, FC 98 bpm, Glasgow 15, rigidez de nuca, sem déficit focal ou paralisia de nervos cranianos; pele fria e sudoreica. Anti-HIV não reagente. TC de crânio normal. Líquor: pressão de abertura 18 cmH2O, límpido, 160 células/mm³ (85% linfócitos), proteína 74 mg/dL, glicose 30 mg/dL, lactato 2,1 mmol/L (VR até 2,8), ADA 3 U/L, Gram e tinta da China negativos. Glicemia capilar colhida no momento da punção: 48 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Glicemia capilar colhida no momento da punção: 48 mg/dL

Resolução. A esposa bacilífera e uma glicorraquia de 30 mg/dL com predomínio linfocitário montam, à primeira vista, a meningite tuberculosa. Mas a glicose do líquor só tem sentido contra a glicemia do mesmo momento, e o paciente está hipoglicêmico (sulfonilureia sem comer, pele fria e sudoreica): 30 sobre 48 dá razão de 0,63, normal, sem consumo. O resto do líquor concorda: quadro de 3 dias, proteína só discretamente elevada, lactato normal, ADA de 3 U/L e nenhum par craniano acometido. A TB meníngea é subaguda, com proteína muito alta, razão abaixo de 0,5 e frequentemente paralisia de nervos cranianos. É meningite viral (asséptica), que se trata com suporte. O contato domiciliar pede, à parte, avaliação para infecção latente, e a glicemia deve ser corrigida já.

A) Meningite criptocócica
Errada. Criptococo é subagudo, em imunossuprimido, com pressão alta e consumo de glicose; tinta da China negativa e anti-HIV não reagente.

B) Meningite viral CORRETA
Correta. Pleocitose linfocitária com razão glicorraquia/glicemia normal, lactato normal e quadro agudo sem déficit: meningite viral.

C) Meningite bacteriana decapitada
Errada. Bacteriana parcialmente tratada pode ficar linfocitária, mas exige antibiótico prévio, que ele nega, e costuma manter lactato alto e razão baixa.

D) Meningite tuberculosa ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o contato bacilífero e a glicorraquia de 30 puxam a TB, mas a razão é de 0,63, o quadro tem 3 dias, a proteína é de 74 e o ADA é de 3.

Para levar. A razão glicorraquia/glicemia corrige nos dois sentidos: glicose de líquor baixa em paciente hipoglicêmico pode ser razão normal e não indicar consumo.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019, atualizado); Thwaites GE et al., consenso de meningite tuberculosa (Lancet Neurol); IDSA Guidelines for Bacterial Meningitis.

69

Hepatologia · Encefalopatia hepática recorrente apesar de lactulose: rifaximina e dieta sem restrição proteica

Grade X / Y

Gabarito D

Mulher de 59 anos com cirrose por esteato-hepatite metabólica, Child-Pugh B, recebe alta após o segundo episódio de encefalopatia hepática grau 3 em 5 meses, ambos tratados com lactulose. No primeiro, o precipitante foi infecção urinária; neste, não se identificou precipitante (sem infecção, sangramento, distúrbio eletrolítico, constipação ou sedativo). Desde o primeiro episódio usava lactulose ajustada para 2 a 3 evacuações pastosas por dia, com boa adesão confirmada pela família. Na alta: orientada, sem asterixis; albumina 3,0 g/dL, sódio 134 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. Para prevenção de novo episódio, quanto ao tratamento farmacológico e à oferta proteica, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

segundo episódio de encefalopatia hepática grau 3 em 5 meses

Resolução. Dois episódios graves em 5 meses, o segundo sem precipitante e apesar de lactulose bem tomada, definem encefalopatia recorrente: a profilaxia secundária passa a ser lactulose associada a rifaximina, que reduz recorrência e internação. A segunda metade é a armadilha antiga, restringir proteína. O cirrótico é hipercatabólico, e a musculatura esquelética é o principal local alternativo de depuração da amônia (síntese de glutamina); dieta hipoproteica acelera a sarcopenia e piora a encefalopatia. A recomendação é de 1,2 a 1,5 g/kg/dia de proteína e 30 a 35 kcal/kg/dia, com refeições fracionadas e lanche noturno.

A) Manter só lactulose / proteína 0,6 g/kg/dia
Errada nas duas metades: a lactulose isolada já falhou, e a restrição proteica é contraindicada.

B) Manter só lactulose / proteína 1,2 a 1,5 g/kg/dia

Errada. A dieta está certa, mas manter só lactulose após recorrência com boa adesão desperdiça a redução de recorrência da rifaximina.

C) Associar rifaximina / proteína 0,6 g/kg/dia ARMADILHA

Errada. É a isca: acerta a rifaximina e erra a proteína, porque a restrição proteica piora a sarcopenia e a própria encefalopatia.

D) Associar rifaximina / proteína 1,2 a 1,5 g/kg/dia CORRETA

Correta. Recorrência sob lactulose: associar rifaximina; proteína de 1,2 a 1,5 g/kg/dia.

Para levar. Encefalopatia que recorre apesar de lactulose: associar rifaximina; nunca restringir proteína (1,2 a 1,5 g/kg/dia).

AASLD/EASL Practice Guideline: Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease (2014); EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy (2022); ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease (2019)

70

Neurologia · Mononeurite múltipla em diabético com inflamação sistêmica: biópsia de nervo e músculo

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 62 anos, com diabetes tipo 2 há 8 anos (HbA1c 7,1%), apresenta há 5 semanas dor em queimação e fraqueza súbita para dorsiflexão do pé esquerdo; 2 semanas depois, mão direita caída; há 10 dias, dormência no território do ulnar esquerdo. Perdeu 6 kg e tem febre baixa noturna. Exame: pé esquerdo caído, punho direito caído, hipoestesia nos territórios correspondentes. VHS 88 mm/h, PCR 6,2 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, EAS normal, ANCA, FAN e crioglobulinas negativos, HBsAg e anti-HCV não reagentes. Eletroneuromiografia: neuropatia axonal multifocal assimétrica (fibular esquerdo, radial direito, ulnar esquerdo). O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

VHS 88 mm/h, PCR 6,2 mg/dL

Resolução. O diabetes é verdadeiro, e neuropatia dolorosa no diabético puxa para controle glicêmico e analgesia. Mas a neuropatia do diabetes é em geral simétrica, distal e lenta; aqui há mononeuropatias dolorosas sucessivas em nervos de membros diferentes (fibular, radial, ulnar), em semanas, que é mononeurite múltipla. Somadas a perda de peso, febre e VHS de 88 com PCR alta, o quadro é de neuropatia vasculítica até prova em contrário. Com ANCA, crioglobulinas e hepatites negativos, rim e sedimento normais, não há órgão mais acessível para confirmar vasculite: o exame é a biópsia combinada de nervo sensitivo (sural ou fibular superficial) e músculo, que confirma vasculite de pequenos e médios vasos antes de imunossupressão prolongada. Arteriografia procura microaneurismas da poliarterite nodosa quando há envolvimento renal ou mesentérico, ausente aqui.

A) Imunoglobulina IV empírica

Errada. Imunoglobulina é tratamento de SGB, PIDC e neuropatia motora multifocal; vasculite se confirma e se trata com corticoide e ciclofosfamida ou rituximabe.

B) Biópsia de nervo e músculo CORRETA

Correta. Mononeurite múltipla com inflamação sistêmica e sorologias negativas: biópsia de nervo e músculo confirma vasculite e justifica imunossupressão.

C) Pregabalina e ajuste glicêmico ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a conduta na polineuropatia diabética distal e simétrica; mononeurite múltipla aguda com VHS de 88 não é atribuível ao diabetes.

D) Arteriografia mesentérica e renal

Errada. Arteriografia seria útil na suspeita de poliarterite nodosa com dor abdominal, hipertensão nova ou alteração renal, ausentes aqui.

Para levar. Mononeurite múltipla com VHS alta não é neuropatia diabética: suspeitar de vasculite e confirmar com biópsia de nervo e músculo quando não há outro órgão acessível.

Peripheral Nerve Society 2010 (neuropatia vasculítica); ACR/EULAR 2022 (vasculites).

---

71 Hematologia · Coagulopatia na UTI: deficiência de vitamina K x CIVD x hepatopatia pelo fator V

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 52 anos está na UTI há 18 dias por pancreatite necrotizante infectada, em jejum com nutrição parenteral e recebendo meropeném há 12 dias. Hoje apresenta sangramento em sítios de punção e hematúria, sem instabilidade hemodinâmica. Exames: Hb 9,1 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 3,4, TTPa 44 s (controle 30 s), fibrinogênio 420 mg/dL, D-dímero discretamente elevado, fator V 96%, fator VII 14%, AST 40 U/L, ALT 35 U/L, bilirrubina total 1,1 mg/dL, albumina 2,9 g/dL. O TP corrigiu por completo no teste da mistura com plasma normal. A causa mais provável da coagulopatia é:

O DADO QUE DECIDE

fator V 96%, fator VII 14%

Resolução. Paciente séptico, na UTI, sangrando com INR alto: o reflexo é coagulação intravascular disseminada. Os negativos no meio do caso a afastam: plaquetas de 210.000, fibrinogênio de 420 e D-dímero só discretamente alto não são consumo. A dosagem de fatores decide entre fígado e vitamina K: o fator V não depende de vitamina K e é sintetizado pelo fígado, então fator V normal com fator VII baixo indica falta de vitamina K; na hepatopatia e na CIVD os dois caem. O contexto explica: 18 dias de jejum (a parenteral nem sempre repõe vitamina K) e antibiótico de largo espectro, que elimina a flora produtora de menaquinona. O teste da mistura que corrige confirma deficiência, e não inibidor. A conduta é vitamina K endovenosa, com plasma ou complexo protrombínico se o sangramento for grave.

A) Deficiência de vitamina K CORRETA

Correta. Fator V normal com fator VII baixo, plaquetas e fibrinogênio normais, jejum prolongado e antibiótico: deficiência de vitamina K.

B) Coagulação intravascular disseminada ARMADILHA

Errada. É a armadilha: CIVD consumiria plaquetas e fibrinogênio e reduziria também o fator V.

C) Insuficiência hepática da sepse
Errada. A insuficiência hepática reduziria o fator V junto com o VII, e as transaminases e a bilirrubina estão normais.

D) Inibidor adquirido de fator
Errada. Um inibidor não corrigiria no teste da mistura; a correção completa indica deficiência de fator.

Para levar. No TP alargado, o fator V separa: normal com fator VII baixo é falta de vitamina K; fator V baixo é fígado ou CIVD (esta com plaquetas e fibrinogênio caindo). Mistura que corrige é deficiência, não inibidor.

ISTH 2013 guidance for DIC (Wada et al.); BSH 2009 guidelines for the diagnosis and management of DIC; UpToDate 2025, Approach to the adult with abnormal coagulation tests.

---

72 Endocrinologia · DHGNA: FIB-4 calculado na faixa intermediária com enzimas normais

Grade X / Y **Gabarito B**

Mulher de 59 anos, com obesidade (IMC 35 kg/m²), hipertensão e pré-diabetes, foi orientada a apenas perder peso após ultrassonografia com esteatose leve e enzimas hepáticas consideradas normais. Consome uma dose de álcool por semana. Sorologias para hepatites B e C negativas, ferritina 180 ng/mL com saturação de transferrina 26%. Exame: sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: AST 40 U/L (até 40), ALT 36 U/L (até 41), plaquetas 182.000/mm³, albumina 4,3 g/dL, bilirrubinas normais. O risco de fibrose avançada pelo FIB-4 e o próximo passo são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
AST 40 U/L (até 40), ALT 36 U/L (até 41), plaquetas 182.000/mm³

Resolução. Enzimas dentro da referência e esteatose leve parecem baixo risco, e é isso que o rótulo de enzimas normais faz o leitor concluir. O FIB-4 não vem pronto: idade vezes AST, dividido por plaquetas (em milhares) vezes a raiz da ALT, ou seja, 59 × 40 / (182 × 6), cerca de 2,2. A idade e a plaqueta no limite inferior pesam mais que a transaminase normal, e o resultado cai na faixa intermediária (1,3 a 2,67). O passo seguinte é a elastografia hepática transitória: abaixo de 8 kPa, baixo risco e seguimento na atenção primária; acima de 12 kPa, hepatologista. Biópsia não é o segundo degrau, e encaminhamento direto só acima de 2,67.

A) Baixo / repetir o FIB-4 em um a três anos ARMADILHA
Errada. Seria a conduta com FIB-4 abaixo de 1,3; transaminase normal não exclui fibrose avançada, e aqui o índice é cerca de 2,2.

B) Intermediário / elastografia hepática CORRETA
Correta. FIB-4 de cerca de 2,2 é indeterminado e pede elastografia.

C) Intermediário / biópsia hepática
Errada. A faixa está certa, mas o degrau seguinte é um teste não invasivo; biópsia fica para discordância ou dúvida diagnóstica.

D) Alto / encaminhar ao hepatologista
Errada. Encaminhamento direto é para FIB-4 acima de 2,67 ou elastografia acima de 12 kPa.

Para levar. Calcule o FIB-4 (idade x AST / plaquetas x raiz da ALT): enzimas normais não excluem fibrose; 1,3 a 2,67 vai para elastografia, não para biópsia.

AASLD Practice Guidance on MASLD 2023; EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on MASLD 2024; ADA Standards of Care 2026, seção 4.

---

73 Emergência · Anafilaxia refratária por betabloqueio de colírio

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 69 anos recebe dipirona venosa no pronto-socorro e, em 10 minutos, apresenta urticária difusa, sibilos, rouquidão e PA de 70 × 40 mmHg. Recebeu adrenalina 0,5 mg intramuscular na coxa, repetida 5 e 10 minutos depois, 2 litros de cristaloide e oxigênio, sem melhora: mantém PA de 76 × 44 mmHg, FC de 54 bpm e sibilos. Refere glaucoma, tratado há 4 anos com um colírio, e hipotireoidismo em levotiroxina. Nega outras medicações. A explicação mais provável para a refratariedade é:

O DADO QUE DECIDE

FC de 54 bpm

Resolução. Anafilaxia que não responde a três doses de adrenalina intramuscular costuma ser tratada como falta de adrenalina, e a infusão venosa é de fato o próximo passo. Mas o número que explica é a frequência cardíaca: choque anafilático com FC de 54 é bradicardia paradoxal, quando o esperado é taquicardia compensatória. A droga está escondida no colírio do glaucoma: timolol é betabloqueador não seletivo e tem absorção sistêmica pela mucosa nasal, sem passar pelo fígado. O betabloqueio atenua o efeito beta da adrenalina (inotropismo e broncodilatação) e favorece a refratariedade. O fármaco de resgate é o glucagon venoso (1 a 5 mg em bolus, seguido de infusão), que aumenta o AMP cíclico por via independente do receptor beta.

A) Betabloqueio pelo colírio CORRETA

Correta. Bradicardia em choque anafilático com uso de colírio para glaucoma: betabloqueio por timolol, tratado com glucagon.

B) Dose insuficiente de adrenalina ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Três doses intramusculares de 0,5 mg são adequadas; a infusão venosa vem agora, mas não explica a bradicardia.

C) Reação bifásica

Errada. Reação bifásica é a recorrência horas depois da melhora inicial; aqui não houve melhora.

D) Mastocitose sistêmica

Errada. Mastocitose predispõe a anafilaxia grave, mas não causa bradicardia nem é a explicação mais provável sem lesões cutâneas ou episódios prévios.

Para levar. Anafilaxia refratária com bradicardia: procure betabloqueador (inclusive colírio de timolol) e use glucagon venoso.

World Allergy Organization 2020 (anafilaxia); EAACI 2021 (anafilaxia); Resuscitation Council UK 2021

---

74 Infectologia · Rifampicina em paciente com prótese valvar mecânica anticoagulado

Droga a deduzir **Gabarito B**

Homem de 61 anos, portador de prótese mecânica mitral há 8 anos, em anticoagulação oral estável há 2 anos, com dieta e adesão regulares, recebe diagnóstico de tuberculose pulmonar com TRM-TB detectado, sem resistência à rifampicina. Não tem outras doenças, creatinina 1,0 mg/dL, ALT 30 U/L. Será iniciado RHZE em dose plena por peso. Em relação à anticoagulação, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

portador de prótese mecânica mitral há 8 anos

Resolução. O anticoagulante não é nomeado, mas prótese mecânica só se anticoagula com antagonista da vitamina K: os anticoagulantes orais diretos são contraindicados nela. A droga, portanto, é a varfarina, e a rifampicina é indutora potente de CYP2C9, CYP3A4 e CYP1A2, o que acelera a depuração da varfarina e derruba o RNI em 1 a 2 semanas, com risco real de trombose da prótese. Manter o controle habitual expõe a esse risco. A conduta é monitorar o RNI de perto (semanalmente no início) e aumentar a dose conforme necessário, muitas vezes para o dobro ou mais, e lembrar de reduzi-la de novo ao fim da rifampicina, quando o efeito indutor se desfaz em algumas semanas. Trocar por anticoagulante direto é contraindicado, e suspender a anticoagulação numa prótese mitral mecânica é inaceitável.

A) Trocar por anticoagulante oral direto
Errada. Anticoagulante oral direto é contraindicado em prótese mecânica, além de ter o nível também reduzido pela rifampicina.

B) RNI semanal e aumento da dose CORRETA
Correta. A droga a deduzir é a varfarina; a rifampicina reduz o RNI, que deve ser controlado semanalmente com aumento de dose.

C) Manter a dose e o controle habitual ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta com uma droga sem interação relevante; a indução enzimática da rifampicina derruba o RNI.

D) Suspender o anticoagulante durante o RHZE
Errada. Suspender a anticoagulação em prótese mitral mecânica expõe a trombose valvar e embolia, sem justificativa.

Para levar. Prótese mecânica significa varfarina; rifampicina derruba o RNI em 1 a 2 semanas: controle semanal, aumento de dose e redução ao final do tratamento.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019, atualizado); Diretriz Brasileira de Valvopatias (SBC, 2020).

---

75 Hepatologia · Coinfecção HIV e hepatite B: tenofovir obrigatório e terapia dupla contraindicada

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 32 anos tem diagnóstico recente de infecção pelo HIV (CD4 480 células/mm³, carga viral 38.000 cópias/mL) e está assintomático. Na triagem: HBsAg reagente, HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-

DNA 900 UI/mL, ALT 24 U/L (referência até 40 U/L), elastografia hepática 5,1 kPa, anti-HCV não reagente; genotipagem pré-tratamento do HIV sem mutações de resistência. Creatinina 0,9 mg/dL, sem proteinúria e sem doença óssea. Ele deseja o esquema com menos comprimidos possível. O esquema antirretroviral inicial mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

HBsAg reagente

Resolução. O HBV-DNA de 900 UI/mL com ALT normal, sozinho, seria infecção crônica sem indicação de tratamento, e a terapia dupla com dolutegravir e lamivudina atende ao desejo de menos comprimidos. Mas na coinfecção HIV e hepatite B todo paciente trata o vírus B junto com o HIV, independentemente de DNA, ALT ou fibrose, e o esquema precisa conter tenofovir (TDF ou TAF) com lamivudina ou entricitabina. Lamivudina como única droga ativa contra o vírus B seleciona resistência em até 90% em 4 anos, e por isso dolutegravir com lamivudina é contraindicado com HBsAg reagente. Entecavir isolado em quem tem HIV sem TARV seleciona a mutação M184V e atrasa a TARV, indicada para todos.

A) Entecavir e adiar a TARV
Errada. Entecavir sem TARV supressiva seleciona resistência do HIV à lamivudina (M184V) e atrasa a TARV, indicada para todos.

B) Dolutegravir e lamivudina ARMADILHA
Errada. É a isca: a terapia dupla é opção para quem não tem hepatite B; com HBsAg reagente, a lamivudina isolada seleciona vírus B resistente.

C) Tenofovir, lamivudina e dolutegravir CORRETA
Correta. HBsAg reagente: o esquema inicial inclui tenofovir e lamivudina, com dolutegravir.

D) Zidovudina, lamivudina e dolutegravir
Errada. Zidovudina não age contra o vírus B e é mais tóxica; deixa a lamivudina como única droga anti-HBV.

Para levar. Coinfecção HIV e hepatite B: TARV para todos com tenofovir mais lamivudina ou entricitabina; dolutegravir com lamivudina é contraindicado.

DHHS Adult and Adolescent Antiretroviral Guidelines (2024); EACS Guidelines versão 12.0 (2023); PCDT para Hepatite B e Coinfecções (Ministério da Saúde, 2017)

---

76 Reumatologia · LES na gestação com anti-Ro: manter hidroxicloroquina e vigiar o bloqueio cardíaco fetal

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 31 anos tem LES há 6 anos, com artrite, fotossensibilidade e leucopenia, sem nefrite, em remissão há 2 anos com hidroxicloroquina 400 mg/dia. Anti-Ro/SSA reagente em título alto, anti-La/SSB não reagente, anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteína I não reagentes. Está com 8 semanas de gestação planejada e pergunta se deve parar a hidroxicloroquina, porque leu que remédios fazem mal ao bebê. PA 112 × 70 mmHg, EAS sem proteinúria, C3 e C4 normais, anti-DNA nativo não reagente. Quanto à hidroxicloroquina e à vigilância fetal específica do anti-Ro, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Anti-Ro/SSA reagente em título alto

Resolução. O pedido da paciente e a ideia de que remédio na gestação faz mal empurram para suspender. No LES, suspender a hidroxicloroquina na gestação aumenta o risco de reativação, e a droga é segura, além de reduzir o risco de bloqueio cardíaco congênito nas mães anti-Ro positivas. O anti-Ro atravessa a placenta e pode lesar o sistema de condução fetal entre 16 e 26 semanas, por isso se recomenda ecocardiografia fetal seriada com medida do intervalo PR mecânico nesse período. Dexametasona profilática não é recomendada: não previne o bloqueio e expõe o feto a efeitos adversos; pode ser considerada só diante de bloqueio de primeiro ou segundo grau detectado. Também se indica AAS em dose baixa a partir de 12 semanas para prevenir pré-eclâmpsia no LES.

A) Manter / ecocardiografia fetal seriada de 16 a 26 semanas CORRETA

Correta. Hidroxicloroquina mantida em toda a gestação e ecocardiografia fetal seriada entre 16 e 26 semanas pela presença do anti-Ro.

B) Manter / dexametasona profilática desde agora

Errada na segunda metade. Manter a droga está certo, mas dexametasona profilática não previne o bloqueio e expõe o feto sem benefício; seria discutida só com bloqueio incompleto detectado.

C) Suspender / ecocardiografia fetal seriada de 16 a 26 semanas ARMADILHA

Errada na primeira metade. A vigilância está certa, mas suspender a hidroxicloroquina aumenta a chance de reativação e tira a proteção contra o bloqueio cardíaco.

D) Suspender / dexametasona profilática desde agora

Errada nas duas metades. Retira a droga que protege e acrescenta o corticoide fluorado que não está indicado.

Para levar. LES na gestação: manter hidroxicloroquina, AAS em dose baixa e, com anti-Ro, ecocardiografia fetal seriada de 16 a 26 semanas. Dexametasona não é profilaxia.

ACR 2020 Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases; EULAR 2017 recommendations for women's health in SLE and/or APS.

77

Cardiologia · Avaliação pré-operatória com boa capacidade funcional: operar sem teste de isquemia

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 69 anos, com diabetes em uso de insulina NPH, hipertensa, creatinina 1,1 mg/dL, vai a colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática. Caminha 3 km por dia e sobe dois andares de escada sem parar e sem sintomas. Nega angina, dispneia, síncope e palpitações. Exame: PA 132×80 mmHg, FC 70 bpm, sem sopros, sem sinais de congestão. ECG: bloqueio de ramo esquerdo, já presente em traçado de 4 anos atrás. Em relação à avaliação cardiovascular pré-operatória, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sobe dois andares de escada sem parar e sem sintomas

Resolução. O bloqueio de ramo esquerdo e o índice de Lee de 2 (insulina e cirurgia intraperitoneal) parecem pedir estratificação, e o BRE ainda sugere que o teste tenha de ser farmacológico: é o raciocínio que leva à

armadilha. Mas o algoritmo pré-operatório pergunta, antes de qualquer teste, se o resultado mudaria a conduta. Paciente sem condição cardíaca ativa e com capacidade funcional de 4 METs ou mais (subir dois andares sem sintomas) vai para a cirurgia sem teste de isquemia, qualquer que seja o escore. O BRE antigo, estável e sem sintomas, não é condição ativa. Um teste positivo levaria a cateterismo e revascularização, que não reduzem eventos perioperatórios e ainda atrasariam a cirurgia com dupla antiagregação.

A) Cintilografia com estresse farmacológico ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O BRE só justificaria escolher estresse farmacológico se houvesse indicação de teste, o que exige capacidade funcional baixa ou desconhecida.

B) Ecocardiograma com estresse farmacológico
Errada. Mesma lógica: com 4 METs ou mais, nenhum teste de isquemia muda a conduta.

C) Operar sem teste de isquemia CORRETA
Correta. Sem condição cardíaca ativa e com capacidade funcional de 4 METs ou mais, opera-se sem teste, mesmo com índice de Lee elevado.

D) Cineangiocoronariografia
Errada. Cateterismo pré-operatório só se indica pelos mesmos critérios de fora da cirurgia, como síndrome coronariana aguda.

Para levar. No pré-operatório, capacidade funcional de 4 METs ou mais sem condição cardíaca ativa encerra a investigação de isquemia, qualquer que seja o escore de risco; BRE antigo não é condição ativa.

AHA/ACC 2024 (perioperative cardiovascular management for noncardiac surgery); ESC 2022 (noncardiac surgery); 3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da SBC (2017)

78

Nefrologia · Sobrecarga hídrica refratária no choque séptico · indicação de diálise com creatinina modesta e método contínuo

Grade X / Y

Gabarito A

Mulher de 71 anos, no terceiro dia de UTI por choque séptico de foco pulmonar, em ventilação mecânica com FiO2 de 0,7 e PEEP de 12 cmH2O (relação PaO2/FiO2 de 105), recebe noradrenalina 0,3 µg/kg/min. Balanço hídrico acumulado de +9 litros, com edema generalizado, e radiografia com congestão e infiltrados bilaterais. A creatinina subiu de 0,8 para 2,7 mg/dL. Nas últimas 12 horas, recebeu furosemida 80 mg IV em bolus seguida de infusão de 20 mg/h, com diurese total de 180 mL. Exames: potássio 4,8 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, pH 7,31, ureia 96 mg/dL. Quanto à terapia renal substitutiva, a indicação e o método são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

com diurese total de 180 mL

Resolução. Creatinina de 2,7, potássio de 4,8 e pH de 7,31 parecem dizer que ainda não há indicação, sobretudo para quem acabou de aprender a não dialisar pelo número. Mas a indicação deste caso é a sobrecarga de volume refratária: balanço de +9 litros, congestão contribuindo para hipoxemia grave (P/F de 105 com FiO2 de 0,7) e diurese de 180 mL em 12 horas apesar de bolus e infusão de furosemida, ou seja, falha da resposta ao diurético. Sobrecarga hídrica acima de 10% do peso associa-se a mais mortalidade, e esperar a piora é aceitar mais dias de ventilação com o pulmão encharcado. Quanto ao método, a paciente está em choque com noradrenalina em dose moderada: a terapia contínua (hemodiálise ou hemodiafiltração

venovenosa contínua) retira volume de forma lenta e tolerável, sem a hipotensão das sessões intermitentes de quatro horas. A indicação é o volume, não a creatinina.

A) Indicada agora / método contínuo CORRETA
Correta. Sobrecarga hídrica refratária ao diurético com hipoxemia grave indica terapia renal substitutiva agora, e o choque com noradrenalina pede método contínuo.

B) Indicada agora / método intermitente
Errada. A indicação está certa, mas a hemodiálise intermitente concentra a ultrafiltração em poucas horas e causa hipotensão em quem já depende de vasopressor.

C) Ainda não indicada / contínuo se piorar ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Potássio, pH e creatinina não indicam diálise, mas a sobrecarga refratária com hipoxemia indica; esperar piorar prolonga a ventilação e aumenta a mortalidade.

D) Ainda não indicada / intermitente se piorar
Errada. Erra nas duas metades: adia uma indicação presente e escolhe o método que a instabilidade desaconselha.

Para levar. Diálise na lesão renal aguda se indica pela complicação refratária, e sobrecarga de volume com hipoxemia apesar do diurético é uma delas mesmo com creatinina modesta; no paciente em vasopressor, método contínuo.

KDIGO 2012 (Acute Kidney Injury); KDIGO Controversies Conference on AKI (Ostermann et al., Kidney Int 2020); STARRT-AKI (NEJM 2020).

79

Pneumologia · Asma não controlada por má adesão com eosinofilia: MART antes do biológico

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Homem de 29 anos, com asma desde a adolescência, tem prescritos fluticasona-salmeterol 250/50 mcg duas vezes ao dia e salbutamol de resgate. Tem sintomas diurnos quase diários, acorda com tosse duas vezes por semana e teve duas crises tratadas com prednisona oral no último ano. Usa salbutamol cerca de 10 vezes por semana. Conta que usa o inalador de manutenção quando lembra, em geral só nos dias de crise, e o registro da farmácia mostra retirada de 4 dispositivos nos últimos 12 meses. Técnica inalatória correta na demonstração. Eosinófilos 520/mm³, IgE total 410 UI/mL, teste cutâneo positivo para ácaros. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

retirada de 4 dispositivos nos últimos 12 meses

Resolução. Eosinófilos de 520 e IgE alta com crises e sintomas diários desenham o candidato a biológico, e o fenótipo é real. Mas asma grave só se define depois de confirmar adesão e técnica em dose alta: 4 dispositivos em 12 meses é cerca de um terço do prescrito, e ele usa o corticoide só na crise, apoiado no salbutamol. É asma difícil de controlar por má adesão, não asma grave refratária. O passo indicado pela GINA é trocar para budesonida-formoterol como manutenção e resgate (MART, trilha 1): cada alívio leva corticoide, o que compensa a adesão irregular e reduz exacerbações graves em relação ao esquema com SABA. Biológico, tiotrópio ou dose alta entram se o controle não vier com o esquema certo em uso real.

A) Dobrar a dose de fluticasona-salmeterol
Errada. Dobrar a dose de um inalador que ele não usa não muda nada; o problema é adesão, não dose.

B) Associar tiotrópio ao esquema atual
Errada. LAMA é add-on da etapa 4 e 5 em quem já usa corretamente corticoide e LABA; não corrige a falta de corticoide.

C) MART com budesonida-formoterol CORRETA
Correta. Má adesão com resgate só com SABA: MART com budesonida-formoterol, que garante corticoide a cada alívio.

D) Iniciar mepolizumabe subcutâneo ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Mepolizumabe é para asma grave eosinofílica não controlada com corticoide inalatório em dose alta e adesão confirmada; ele usa um terço do prescrito.

Para levar. Antes de escalar (dose alta, LAMA, biológico), confirmar adesão e técnica; no mal aderente, MART com budesonida-formoterol é a troca que mais reduz crise.

GINA 2024 (inclui a abordagem da asma de difícil controle e grave); Recomendações SBPT para o manejo da asma 2020

80

Hematologia · Hemorragia intracerebral em uso de dabigatrana: reversão imediata e específica

Qualificador **Gabarito D**

Mulher de 79 anos, com fibrilação atrial em uso de dabigatrana 110 mg duas vezes ao dia (última dose há 4 horas), chega com hemiparesia direita, e a tomografia mostra hematoma intraparenquimatoso de 22 mL. Clearance de creatinina estimado de 42 mL/min, plaquetas 190.000/mm³, TTPa 58 s (controle 30 s). Para reverter de forma imediata e específica o efeito anticoagulante, a medida mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

de forma imediata e específica

Resolução. Todas as alternativas reduzem o efeito de algum anticoagulante, e o qualificador do comando é o que seleciona. A dabigatrana é inibidor direto da trombina e tem antídoto próprio, o idarucizumabe, um fragmento de anticorpo monoclonal que a liga com afinidade muito maior que a trombina e reverte o efeito em minutos. O andexanete é o antídoto dos inibidores do fator Xa (apixabana, rivaroxabana) e não liga a dabigatrana, e é a armadilha de quem lembra que "DOAC tem antídoto". O complexo protrombínico é alternativa inespecífica quando o antídoto não está disponível. A hemodiálise remove a dabigatrana, que tem baixa ligação proteica, mas não é imediata e exige acesso calibroso num paciente anticoagulado.

A) Complexo protrombínico de 4 fatores
Errada. O complexo protrombínico é inespecífico, usado quando falta o antídoto; não é a reversão específica pedida.

B) Hemodiálise de urgência
Errada. A diálise remove a dabigatrana, mas não de forma imediata; fica para sobredose com função renal ruim quando não há idarucizumabe.

C) Andexanete alfa ARMADILHA

Errada. É a armadilha: andexanete reverte inibidores do fator Xa, não a dabigatrana.

D) Idarucizumabe CORRETA

Correta. Antídoto específico da dabigatrana, com reversão em minutos.

Para levar. Dabigatrana: idarucizumabe; inibidores do fator Xa: andexanete (ou complexo protrombínico de 4 fatores); varfarina: complexo protrombínico com vitamina K.

AHA/ASA 2022 guideline for spontaneous intracerebral hemorrhage; EHRA 2021 practical guide on NOACs; ACC 2020 expert consensus on bleeding with oral anticoagulants.